

Nova Health Tech · Trợ lý AI Lâm sàng

500 Câu hỏi & Trả lời · Dành cho Lãnh đạo Bệnh viện (Không chuyên kỹ thuật)

Mục tiêu: CEO, COO, CFO, CMO, Giám đốc Y khoa, Trưởng khoa, Cán bộ Tuân thủ, Quản lý Bệnh viện.

Phong cách: Ngôn ngữ ngắn gọn, ví dụ cụ thể, concisely, liên kết với tác động kinh doanh, công thực khi cần.

Số liệu cần:

- 500 bác sĩ làm việc
- 40 truy vấn/bác sĩ/ngày
- 22 ngày làm việc/tháng
- 30% chấp thuận / 70% phản hồi
- Chi phí bác sĩ: ~80 USD/giờ
- Khả năng xử lý: 600.000 truy vấn/tháng/bệnh viện

1. Lợi ích kinh doanh & ROI

Xem thêm phiên bản tiếng Anh: docs/Client_QA_500_Questions.md

Q1. Tại sao bệnh viện cần trợ lý AI lâm sàng? Bác sĩ đã có UpToDate rồi.

A.

UpToDate là công cụ tra cứu tuyệt vời nhưng cần bác sĩ biết tìm gì và đọc nhiều bài. Trợ lý AI khác 3 điểm:

- Tổng hợp nhu cầu nguồn trong vài giây.** Thay vì mất 5 phút đọc hàng WHO, bài PubMed và báo cáo thử nghiệm mới nhất, trợ lý trả về 1 đoạn văn có trích dẫn trong 2 giây.
- Hoạt động ngay trong khi khám bệnh.** Bác sĩ đang có bệnh nhân trước mặt không thể dừng lại 5 phút. Phấn khởi 2 giây cho phép dùng ngay trong phòng khám.
- Biết đâu liệu thử nghiệm mới nhất.** UpToDate không biết báo cáo thử nghiệm mới của bệnh viện. Trợ lý index cả hai cùng với WHO và ICD-11.

Tính toán kinh doanh:

$$\begin{aligned} & 500 \text{ bác sĩ} \times 10 \text{ phút/ngày} \times 22 \text{ ngày} = 110.000 \text{ phút/tháng} \\ & = 1.833 \text{ giờ/tháng} \times 80 \text{ USD/giờ} = 146.640 \text{ USD/tháng tiềm năng} \end{aligned}$$

Hệ thống chi phí 2.800–5.500 USD/tháng. Hoàn vốn trong khoảng 1 tuần.

Q2. ROI thực sự là bao nhiêu?

A.

Ba nguồn lợi nhuận tiềm năng:

- Thời gian tiết kiệm mỗi truy vấn:** Bác sĩ mất trung bình 6 phút tra cứu tài liệu. Trợ lý trả lời trong 2–12 giây. Tiết kiệm: ~5 phút/truy vấn.
- Mất số dòng:** 40 truy vấn/bác sĩ/ngày $\times$ 500 bác sĩ = 20.000 truy vấn/ngày, 600.000/tháng.
- Giá trị hàng năm** (chi phí bác sĩ 80 USD/giờ):

$$\begin{aligned} & 600.000 \text{ truy vấn/tháng} \times 5 \text{ phút} \times (80 \text{ USD/giờ} \div 60 \text{ phút}) = 4.000.000 \text{ USD/tháng} \\ & \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000 \text{ USD/năm mỗi bác sĩ} \end{aligned}$$

Chi phí: 2.800–5.500 USD/tháng × 12 = 33.600–66.000 USD/năm.

Tỷ lệ ROI: ~360x đến 1.400x trong kịch bản bảo thủ.

Lợi ích lớn hơn, khó định lượng hơn: giảm trách nhiệm oan trong cấp cứu và ít báo sót triệu chứng trên bảng bệnh.

Q3. Làm sao biết hệ thống có thực sự đáng tin cậy không?

A. Mọi truy vấn được ghi lại với metadata (không có thông tin nhận dạng bệnh nhân). Báo cáo hàng tháng bao gồm:

- Tổng số truy vấn theo khoa, theo lane (cấp cứu vs phòng khám)
- **Bác sĩ hoạt động:** bao nhiêu trong 500 người thực sự sử dụng tháng này
- **Top 20 lỗi câu hỏi:** đang học, tên danh, hậu ích cho đào tạo
- Thời gian phản hồi trung bình theo lane
- **Tỷ lệ click vào trích dẫn:** bác sĩ có click vào nguồn để xác minh không?
- **Tỷ lệ thumbs-up / thumbs-down**

Ví dụ: "Khoa Tim mạch sử dụng trung bình 12.400 lần tháng này, 94% thumbs up."

Nếu một khoa có tỷ lệ sử dụng thấp, đó là tín hiệu cần xem xét: quy trình làm việc không phù hợp, phản hồi không hữu ích, hoặc cần đào tạo thêm.

Q4. Nếu bác sĩ không tin tưởng AI và chỉ chơi đùa thì sao?

A. Niềm tin được xây dựng qua 3 cách thiết kế sẵn:

1. Mọi câu trả lời đều có trích dẫn nguồn. Bác sĩ có thể click vào [1] và xem đúng nguồn văn WHO, sáng, ngày cấp nhật. Minh bạch hơn khuyến khích bằng chứng minh của việc nghi ngờ.
2. Hệ thống nói "tôi không biết" khi không có dữ liệu. Nếu context không hỗ trợ câu trả lời, hệ thống trả lời. PoC của chúng tôi cho thấy 100% trích dẫn và 0% ảo giác.
3. Được thiết kế là hệ thống quy tắc cứng, không phải người ra quyết định. Bác sĩ giữ toàn bộ phán xét lâm sàng. Trách nhiệm: bác sĩ quyết định.

Mô hình áp dụng thực tế: Tuần 1: 20% bác sĩ thử, Tuần 4: 60% dùng hàng tuần, Tuần 12: 85%+ dùng hàng tuần.

Q5. Hệ thống này có thể thay thế nhân viên thực vụ y khoa không?

A. Không, và chúng tôi khuyến khích không nên nhìn về theo hướng đó. Lý do:

- Trách nhiệm của bác sĩ không có thời gian tra cứu nguồn. Tác động lớn nhất là bác sĩ cấp cứu lúc 3 giờ sáng, không phải thời điểm nhân viên đã làm việc cần thêm.
- Thời điểm và chuyên viên CDS thực hiện giám sát sâu: quyết định nguồn nào cần index, kiểm tra chất lượng truy xuất, đào tạo bác sĩ mới. Trách nhiệm ra quyết định cho các vai trò này, không giảm.
- Dùng AI để cắt giảm nhân sự tạo ra vấn đề quan hệ lao động và hiểm khi hiểu qu.

Trình bày kinh doanh thực tế: Không phải "sa thải 5 thực vụ nhân viên, tiết kiệm 500k USD/năm." Mà là "cho mỗi bác sĩ có thể nhân viên cá nhân, tiết kiệm 500k USD/tháng trong thời gian bác sĩ."

Q6. Bác sĩ có thể nên lái xe và ngừng tiếp duy phần bị ảnh hưởng vì AI trả lời sai không?

A.

Này là mội lo ngi h p l trong tin h c lâm sàng, ôi khi g i là "automation bias." Chúng tôi gi i quy t qua 3 cách:

1. **nh d ng u ra bu c bác s ph i c.** M i câu tr l i có c u trúc "Khuy n ngh : ..." v i b ng ch ng trích d n. Bác s ph i c ít nh t ph n khuy n ngh .
2. **Trích d n có th click.** Nghi n c u cho th y ~30–40% bác s click x c minh trong các tr ng h p m i. Cao h n x c minh t v n b ng mi ng (~5%).
3. **Ki m tra mù nh k .** Hàng quý, ch y 50 câu h i v i tr ng h p khó, k t qu c xem xét b i cán b an toàn lâm sàng.

M i lo ngi t ng t ã c t ra v i máy tính, h s b nh án i n t , công c ch n oán hình nh. Mô hình nh t quán: công c nâng cao công vi c, không làm gi m k n ng.

Q7. N u AI a ra câu tr l i sai và b nh nh n b t n h i thì sao?

A.

Này là câu h i quan tr ng nh t. Chúng tôi tr l i qua 3 khía c nh:

Pháp lý:

- H th ng c c p phép và v n hành nh h tr quy t nh lâm sàng theo HCSA, không ph i bác s i u tr .
- M i câu tr l i có tuyên b rõ ràng: "Ch h tr quy t nh. Phán xét lâm sàng c i cùng thu c v bác s có phép hành ngh ."
- Nh t ký ki m toán ghi l i: câu h i chính xác, b ng ch ng truy xu t, câu tr l i, phiên b n mô hình, phiên b n prompt, d u th i gian.

Bi n pháp k thu t:

- Xác th c trích d n: m i kh ng nh ph i có ngu n th c s có th truy xu t.
- i m grounding $\geq 0,7$: ch n u ra không có c s tr c khi n bác s .
- Bedrock Guardrails: ch n các mô hình nguy hi m ã bi t.
- Hành vi t ch i: khi không ch c ch n, h th ng nói "Tôi không th tr l i t context hi n t i."

Th c t: PubMed có bài báo sai. Bài UpToDate b thu h i. ng nghi p a ra l i khuy n sai. Tiêu chu n không ph i "AI ph i hoàn h o"; mà là "AI ph i t t ít nh t b ng các l a ch n thay th , v i kh n ng truy xu t t t h n."

Q8. H th ng này so sánh th nào v i vi c thuê thêm bác s ?

A.

Không ph i thay th bác s , nh ng nh m t nh n s th i gian, phép tính r t n t ng:

Chi phí thuê 1 bác s b sung (Singapore): ~200.000–300.000 USD/n m (l ng, phúc l i, b o hi m, ào t o, v n phòng).

Tr lý AI thêm vào: 5 phút $\times$ 600.000 truy v n/tháng = 50.000 gi /n m, t ng ng ~25 bác s toàn th i gian.

So sánh:

25 bác s b sung $\times$ 250.000 USD = 6.250.000 USD/n m

Chi phí tr lý = ~50.000 USD/n m

T l t ng ng n ng su t = ~125x

Tr lý không thay th bác s b n s thuê kh khám thêm b nh nh n. Nó gi i phóng bác s b n ã có dành nhi u th i gian v i b nh nh n thay vì nghi n c u cho h .

Q9. S khác bi t gi a Nova t xây d ng h th ng n i b và thuê nhà cung c p nh Alibaba ho c AWS là gì?

A.

Này là câu hỏi build-vs-buy. Ba lựa chọn:

Nền tảng đám mây (AWS, Alibaba): Không ai tập trung tâm dữ liệu cho việc này nữa. Chi phí vận hành rất lớn. Dịch vụ đám mây theo số lượng là lựa chọn hợp lý duy nhất.

Mô hình AI (Claude, Qwen): Vào đầu mô hình lâm sàng hàng đầu tốn 50–200 triệu USD và mất 12–18 tháng. Anthropic và Alibaba đã làm việc này. Thuê mô hình qua API chỉ tốn vài cent mỗi truy vấn.

Lựa chọn đúng (chính xác): Đây là lựa chọn Nova xây dựng. Giá trị gia tăng của Nova là tích hợp WHO + ICD-11 + thực nghiệm lâm sàng, vào đầu giường vận hành, tích hợp EHR, tự động tuân thủ.

So sánh chi phí (ước tính):

Tự xây dựng:

- 100k server (10 nghìn server × 200k) = 2.000.000 USD/năm
- 100k ML/AI (5 nghìn server × 250k) = 1.250.000 USD/năm
- 100k tuân thủ/bảo mật (3 × 150k) = 450.000 USD/năm
- Đám mây + GPU (30% trên) = 1.100.000 USD/năm
- Tổng = 4.800.000 USD/năm
- Cần thêm: 18 tháng để ra mắt

Dùng dịch vụ quản lý AWS/Alibaba:

- 2–3 nghìn server tích hợp (Nova hiện có) = ~500.000 USD/năm
- AI + truy xuất quản lý = 34.000–66.000 USD/năm
- Tổng = ~550.000 USD/năm
- Thời gian ra mắt: 6–10 tuần

Phương pháp cloud-native rẻ hơn ~9 lần và nhanh hơn ~10 lần.

Q10. Nếu nó có giá trị như vậy, tại sao tất cả các bệnh viện chưa làm việc này?

A.

Ba lý do, và Nova có lợi thế hơn mỗi điểm:

- Hầu hết bệnh viện không có lãnh đạo kỹ thuật.** Xây dựng việc này đòi hỏi hiểu biết về LLM, RAG, cách sử dụng dữ liệu vector, quy trình y tế, tích hợp EHR và kiến trúc bảo mật, tất cả cùng một lúc. Nova Health Tech với tư cách là nhà cung cấp sức khỏe kỹ thuật số có chuyên môn này; một bệnh viện điển hình thì không.
- Tuân thủ phức tạp rõ ràng cho nhân viên y tế.** PDPA đã rõ ràng; HCSA 2020 chính thức thêm "hệ thống quy trình lâm sàng" là danh mục dịch vụ y tế cấp phép, giới hạn quyền sử dụng hệ thống. Trước cuối năm 2024, việc triển khai có rủi ro. Bây giờ có thể kiểm toán được.
- Ngành chất lượng mô hình đã vượt qua vào 2024–2025.** Claude 3.5/4.5 và Qwen 3.5/3 vượt qua suy luận cấp lâm sàng mà GPT-3.5/4 trước đây không có. Grounding trích dẫn qua RAG tăng thành ~98% trong nghiên cứu và ~95% trong triển khai sản xuất.

Các bệnh viện hàng đầu triển khai AI lâm sàng vào năm 2026 là: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Singapore SGH (và NUS), Mount Elizabeth. Nova là số một ở Đông Nam Á — đây là lợi thế cạnh tranh đáng báo động.

Q11. Thời gian hoàn vốn là bao lâu?

A.

Dùng giá nhân viên theo giờ:

Chi phí (Variant A1+ Nova trên AWS): 2.805 USD/tháng/bệnh viện = 33.660 USD/năm.

Thời gian tiết kiệm nhân viên theo giờ: giá server 50% truy vấn thực sự thay thế nhân viên tài liệu.

Thời gian phục hồi bệnh:
= 600.000 truy vấn x 50% x 5 phút x (80 USD/gi / 60 phút)
= 2.000.000 USD/tháng
Hoàn vốn:
= 33.660 USD chi phí hàng năm / 2.000.000 USD/tháng giá trị
= 0,017 tháng = ~12 giờ
Hệ thống hoàn vốn năm đầu tiên trong vòng 12 giờ sẽ đáng báo động quy mô. Điều này bất thường; hầu hết phần mềm doanh nghiệp có thời gian hoàn vốn 6-18 tháng. Lý do nhanh nhất vậy: thời gian báo số là chi phí vận hành nhất định trong bệnh viện, và bất kỳ khoản tiết kiệm năng suất nào cũng tích lũy.
Kịch bản báo bệnh: Ngay cả khi chỉ 10% truy vấn tiết kiệm 5 phút, hoàn vốn vẫn diễn ra 3 ngày.

Q12. Chúng tôi đo lường thành công như thế nào? Nên theo dõi KPI nào?

A.
Sáu KPI cấp ưu tiên:

KPI	Mức tiêu	Lý do quan trọng
Báo số hoạt động hàng ngày (% tăng số)	70%+ vào tháng 3	Chỉ số sâu áp dụng
Truy vấn mới báo số hoạt động/ngày	25+	Mức gần kết
Tỷ lệ click vào trích dẫn	25-40%	Duy trì duy phần bên
Tỷ lệ thumbs-up	90%+	Số hài lòng về chất lượng
Tỷ lệ tải chi	2-8%	Hệ thống biết mình không biết gì
TTFT cấp cứu	≤2s p95	Tuân thủ SLA

Cũng thêm 4 KPI an toàn lâm sàng của Giám đốc Y khoa xem xét:

KPI	Mức tiêu
Tỷ lệ chấn Guardrails	<3%
Chỉ số grounding p50	≥0,82
Số kiến bản lỗi có thể quy cho hệ thống	0
Thời gian phân hồi kiểm toán	<4 giờ yêu cầu nên phát hiện phiên bản

Q13. Làm sao giảm thiểu chi phí cho các bệnh viện mới tác?

A.
Chi phí tính theo bệnh viện-tenant, và bệnh có thể cấu trúc nên giá theo nhiều cách:

Phương án 1: Chuyển qua vai biên lợi nhuận

- Chi phí AWS: 2.800 USD/tháng, tính 4.500 USD/tháng (~60% biên lợi nhuận)
- Lý do: Nova cung cấp tích hợp, đào tạo, tùy chỉnh và bảo hiểm SRE 24/7.

Phương án 2: Theo giá báo số

- 20 USD/báo số/tháng -> 500 báo số = 10.000 USD/tháng mỗi tenant
- Dễ lập ngân sách; dễ ràng theo quy mô bệnh viện; biên lợi nhuận cao với bệnh viện nhỏ.

Phân tích 3: Tính theo truy vấn

- 0,005 USD mỗi truy vấn (5x chi phí suy luận thô 0,001 USD)
- Phù hợp với tăng trưởng số lượng bệnh viện.

Nói với bệnh viện: "Mỗi bác sĩ của bạn lấy ~3 giờ/tuần thời gian tra cứu tài liệu. Với chi phí bác sĩ 80 USD/giờ, đó là ~5.000 USD/bác sĩ/tháng giá trị phúc hời. Chúng tôi tính bạn mất phần nhả của siêu số (20 USD/bác sĩ/tháng), phần còn lại tích lũy cho bệnh viện của bạn."

Q14. Nếu chúng tôi muốn biết sau này, chi phí một khoa, trước khi triển khai toàn bệnh viện thì sao?

A.

Chúng tôi khuyến nghị minh bạch. Nên tăng hợp tác triển khai theo từng khoa một cách gần gũi:

Câu hình thức mẫu (ví dụ: chi phí Khoa Cấp cứu):

- Cùng các số hạng, những biến tenant_id giúp truy xuất và phân tích cho dữ liệu ED.
- Chi phí: giống như triển khai này vì OpenSearch/Neptune có kích thước tài liệu bất kỳ.
- Giá trị mẫu: cần đảm bảo an toàn lâm sàng xem xét 30 ngày số lượng thực tế, ký duyệt trước khi triển khai rộng rãi.

Lưu ý trình bày mẫu minh:

Tuần 1-2: Chi phí ED + ICU (rủi ro cao nhất, xác nhận nhanh nhất)

Tuần 3-6: Thêm Tìm kiếm, Hồ sơ, Bệnh truy cập nghiêm

Tuần 7-10: Thêm 6 khoa nữa

Tuần 11+: Toàn bệnh viện

Chi phí trong mẫu: Giống như số xuất (các số hạng chúng tôi chia sẻ). Mẫu giảm rủi ro, không giảm chi phí.

Q15. Làm sao trình bày dữ liệu này với Hội đồng quản trị?

A.

Bài thuyết trình 90 giây:

"Các bác sĩ của chúng ta dành khoảng 1 giờ mỗi ngày tìm kiếm tài liệu y khoa. Với 500 bác sĩ, đó là 11.000 giờ mỗi tháng, tương đương 60 nhà nghiên cứu toàn thời gian. Chúng ta có thể phúc hời phần lớn thời gian đó bằng trợ lý AI lâm sàng của chúng tôi trong hướng dẫn WHO, ICD-11 và thực nghiệm nội bộ của chúng ta, tất cả được lưu trữ tại Singapore trên AWS [hợp tác Alibaba] với đầy đủ tuân thủ PDPA và HCSA."

>

Chi phí khoảng 35.000-65.000 USD mỗi năm mỗi tenant. Thời gian phúc hời có giá trị 2-4 triệu USD mỗi tháng theo từng bác sĩ tiêu chuẩn. Hệ thống hoạt động trong 6-10 tuần. Ba cấp độ bác sĩ và Giám đốc Y khoa đã xác nhận bằng chứng khả năng; 100% câu trả lời kiểm tra được các câu hỏi trong nguồn được trích dẫn, với thời gian phản hồi dưới 5 giây cho các truy vấn cấp cứu.

>

Hệ số rủi ro thu nhập: hệ thống quy định lâm sàng, không phải AI tự chọn; bác sĩ giữ toàn bộ phán xét lâm sàng; nhật ký kiểm toán đầy đủ cho báo cáo HCSA; tất cả theo mô hình khi không chắc chắn. Quy định lâm sàng là liệu có đến đâu thì chúng tôi ông Nam Á với dữ liệu này hay theo sau."

Q16. Cần tranh thủ những thứ nào?

A.

Ba danh mục cần thiết để tranh:

Đội ngũ trực tiếp (nhà cung cấp AI lâm sàng):

- Glass Health (M): suy luận lâm sàng chung, không được bán độc quyền ở Singapore
- Hippocratic AI (M): tập trung vào bệnh nhân, trình bày hợp lệ đáng khác
- Suki AI (M): tập trung vào ghi chép/tài liệu, không phải là quy trình bệnh
- Bot M.D. (Singapore): chatbot cho y tế, ít nghiêm ngặt về trách nhiệm

Mô hình gián tiếp (cần sự đồng ý của khách hàng):

- UpToDate: tiêu chuẩn ngành, nhưng không tạo sinh; bác sĩ tìm kiếm và đọc
- DynaMed: trình bày UpToDate
- Cần hai tuần 400-600 USD/bác sĩ/năm; không tích hợp dữ liệu mới

Mô hình khác biệt của Nova:

1. Tích hợp chuyên gia y tế (chỉ Nova có dữ liệu của Nova)
2. Tuân thủ bệnh nhân ở Singapore (PDPA + HCSA + IMDA trong một stack)
3. Sản phẩm của bệnh nhân (bán cho nhiều bệnh nhân)
4. Hai mô hình (AWS Claude hoặc Alibaba Qwen) cho khách hàng lựa chọn

Q17. Nếu hiện tại hoạt động, chúng tôi có thể bán nó cho các bệnh nhân khác không?

A.
Có, và đây có thể là các hướng dài hạn hơn. Ba con đường:

Con đường 1: SaaS cho bệnh nhân mới

- Mỗi bệnh nhân mới là một tenant. Chi phí cần sự đồng ý biên: ~2.500-5.500 USD/tháng mỗi tenant.
- Tính 10.000-25.000 USD/tháng mỗi tenant (~70-80% biên lợi nhuận).

Con đường 2: OEM nhãn riêng

- Hợp đồng y tế lớn hơn thích hợp nhãn riêng. Tính phí thiết lập + giấy phép mỗi tenant.
- Giá cao hơn (30k-100k USD/tháng) nhưng chu kỳ bán hàng dài hơn.

Con đường 3: Nhúng vào quan hệ đối tác EHR

- Epic, Cerner, Allscripts tại Singapore có thể nhúng trình lý của Nova vào ứng dụng FHIR của họ.
- Chia sẻ doanh thu, giao dịch như họ nhận được khi sử dụng.

Tổng thể trình bày có thể tiếp cận ở Đông Nam Á: ~250 bệnh nhân và hơn 1 triệu lượt truy cập trung bình 15k USD/tháng = ~45 triệu USD ARR trong 3 năm nếu Nova chiếm 40% thị phần.

Q18. Chi phí triển khai so với mô hình là gì?

A.
Hai danh mục chi phí:

Chi phí một lần (chỉ Nova 1):

Hạng mục	Chi phí
Triển khai ban đầu (kể từ)	80.000-150.000 USD
Tích hợp EHR với bệnh nhân	15.000-40.000 USD
Kiểm toán chi phí nhân viên	20.000-50.000 USD
Mã hóa bác sĩ ban đầu	10.000-25.000 USD
Tổng một lần Nova 1	125.000-265.000 USD

Chi phí vận hành (mỗi năm):

Hạng mục	Hàng năm
Cố sở hạ tầng đám mây (mỗi tenant)	34.000-66.000 USD
Phân bổ kết cấu SRE	80.000 USD
Xem xét an toàn lâm sàng	20.000 USD/tenant/năm
Báo cáo tuân thủ + chuẩn bị kiểm toán	15.000 USD/tenant/năm
Chứng trình phân tích bác sĩ	10.000 USD/tenant/năm
Tổng nhân lực mỗi tenant	159.000-191.000 USD

Hình dạng chi phí theo thời gian:

Năm 1: ~284.000-456.000 USD (mất lớn + nhân lực)
Năm 2+: ~159.000-191.000 USD/năm/tenant

Q19. Vì sao bạn nghĩ rằng việc báo hiệu trách nhiệm y tế của chúng tôi như thế nào?

A.

Ba điểm cần thảo luận với công ty báo hiệu:

1. Cập nhật chính sách cho "hệ thống quyết định tăng cường AI"

Hệ thống chính sách trách nhiệm y tế năm 2026 có nội dung bổ sung cho hệ thống quyết định tăng cường AI. Chi phí: tăng tổng phí báo hiệu 5-12%.

2. Tranh luận về giảm phí báo hiệu dựa trên tài liệu tốt hơn

Nhất ký kiểm toán toàn diện hơn tài liệu lâm sàng thông thường. Một số công ty báo hiệu (Chubb, Howden Singapore) cung cấp giảm giá cho bệnh viện có nhất ký kiểm toán AI có thể xác minh vì:

- Các vấn đề kiểm soát bảo hiểm (chủ lý luận này sẽ được báo hiệu)
- Tránh chặn đoán giảm (câu trả lời nhanh hơn)
- Suy luận lâm sàng được tiêu chuẩn hóa (ít biến động giữa các bác sĩ hơn)

3. Phân bổ báo hiệu thông với nhà cung cấp công nghệ

Trong hợp đồng với nhà cung cấp đám mây và với Nova:

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về lỗi công nghệ (ví dụ: ngừng dịch vụ, rò rỉ dữ liệu từ cố sở hạ tầng)
- Bệnh viện/bác sĩ chịu trách nhiệm về quyết định lâm sàng được đưa ra dựa trên câu trả lời

Tác động chi phí ròng: Thông là hòa vốn hoặc giảm ròng 5-10% sau khi kiểm toán viên thấy mất năm hệ thống thực tế.

Q20. Nếu bác sĩ sao chép câu trả lời của AI vào hồ sơ bệnh nhân thì có vấn đề không?

A.

Này là câu hỏi quy trình làm việc thực tế. Trả lời theo 3 lớp:

Hình dạng tài liệu:

- Có, bác sĩ có thể sao chép câu trả lời của AI vào hồ sơ, nhưng nên ghi nhận: "Tham khảo hệ thống quyết định: [ID tham chiếu truy vấn AI #ABC123, ngày 2026-05-15]."
- Hệ thống tạo ID tham chiếu truy vấn cho mục đích này. Click vào ID sẽ tải lại phiên chính xác của kiểm toán.

Khung trách nhiệm pháp lý:

Q22. "Bedrock Model Distillation sang Nova Lite" là gì và tại sao nó giảm chi phí?

A.

Distillation là kỹ thuật bạn đào tạo một mô hình nhỏ hơn để bắt chước một mô hình lớn hơn.

Trúc giác: Sonnet 4.5 là mô hình 200B+ tham số đạt tiên đề chạy. Nova Lite là ~8B tham số, rẻ hơn ~30 lần. Chúng ta có thể dùng Sonnet để dạy Nova Lite trả lời như Sonnet trên các câu hỏi lâm sàng cụ thể của Nova.

Quy trình:

1. Lay 10.000-50.000 câu hỏi mẫu từ lĩnh vực của Nova
2. Dùng Sonnet trả lời tất cả chúng với lý luận đầy đủ + trích dẫn
3. Đào tạo Nova Lite trên các đầu ra Sonnet đó (đây là "distillation training")
4. Kết quả: Nova Lite có thể trả lời các câu hỏi lâm sàng của Nova ở chất lượng Sonnet 95%+ trên phân phối được đào tạo

Tại sao nó giảm chi phí:

- Sonnet tính 15 USD/triệu token đầu ra
- Nova Lite tính ~0,50 USD/triệu token đầu ra (rẻ hơn 30 lần)
- Đối với 40% lượng phức tạp mà sinh viên xử lý, bạn nhận được câu trả lời chất lượng Sonnet ở chi phí Nova Lite

Phep tính (trong bảng chi phí của chúng tôi):

,

Không có sinh viên: 700k truy vấn phức tạp x 0,013 = 9.100 USD/tháng (Sonnet thuần túy)

Với sinh viên: 280k Sonnet + 420k sinh viên

= 280k x 0,013 + 420k x 0,0005

= 3.640 + 210 = 3.850 USD

Tiết kiệm: 5.250 USD/tháng

,

Chi phí distillation: 670 USD/tháng phân bổ (đào tạo lại hàng quý). Tiết kiệm ròng: 4.580 USD/tháng.

Q23. Nếu khối lượng truy vấn của chúng tôi cao hơn hoặc thấp hơn nhiều thì sao?

A.

Chi phí có hai thành phần: cơ định và biến đổi.

Chi phí cơ định (không thay đổi nhiều theo khối lượng):

- OpenSearch Serverless / OpenSearch Vector Search: 350-500 USD/tháng tối thiểu
- Neptune Analytics / AnalyticDB GraphRAG: 115-300 USD/tháng tối thiểu
- ElastiCache Redis / Tair: 80-100 USD/tháng tối thiểu
- VPN, mạng, giám sát: 230 USD/tháng tối thiểu
- **Tổng cơ định:** ~775-1.180 USD/tháng/tenant

Chi phí biến đổi (thay đổi theo khối lượng):

- Suy luận LLM (Claude hoặc Nova): tỷ lệ thuận với truy vấn
- Nhưng: tỷ lệ thuận với kích thước corpus và truy vấn
- Lưu trữ: tỷ lệ thuận với corpus + nhật ký kiểm toán

Công thức chi phí (biến thể Claude):

,

Chi phí hàng tháng = 1.800 USD (cơ định) + (truy vấn x 0,0058 USD trung bình mỗi truy vấn)

,

Chi phí ở các khối lượng khác nhau:

Khoi lượng/thang	Có định	Biến đổi	Tổng	Mỗi truy vấn
100k	1.800	580	2.380	0,024
300k	1.800	1.740	3.540	0,012
600k (cơ sở)	1.800	3.480	5.280	0,0088
1,2M	1.800	6.960	8.760	0,0073
3M	1.800	17.400	19.200	0,0064

Kinh tế quy mô: Chi phí mỗi truy vấn giảm khi khối lượng tăng vì chi phí cố định được phân bổ. Ở 3M/tháng, chi phí mỗi truy vấn thấp hơn 73% so với 100k/tháng.

Q24. Có giảm giá theo khối lượng từ AWS hoặc Alibaba không?

A.

Có, theo nhiều hình thức:

Giảm giá khối lượng AWS:

- **Bedrock Reserved Tier:** cam kết token tối thiểu hàng tháng, nhận giảm giá 20-40%.
- **Enterprise Discount Program (EDP):** ở mức chi tiêu AWS 50k+/tháng, định giá tùy chỉnh thường giảm 15-30% so với giá niêm yết.
- **Solution Provider Program:** Nova với tư cách là đối tác nhận được ~10% giảm giá đối tác trên các dịch vụ AWS bán lại.

Giảm giá khối lượng Alibaba Cloud:

- **Reserved Instances (RI)** cho tính toán: giảm giá 30-50% với cam kết 1-3 năm.
- **Cloud Solution Partner discount:** ~15-25% so với giá niêm yết.
- **Chương trình ngành y tế:** giảm giá theo từng trường hợp cho các lĩnh vực y tế.

Hướng dẫn thực tế:

- 6 tháng đầu: dùng theo yêu cầu (bạn chưa biết khối lượng ổn định của mình)
- Tháng 6: xem xét sử dụng thực tế, cam kết Reserved capacity cho phần ổn định (~70%), giữ 30% theo yêu cầu để có tính linh hoạt
- Năm 2+: đàm phán thỏa thuận doanh nghiệp với cả AWS và Alibaba để tận dụng đơn bay danh mục

Đơn bay đàm phán:

- Cả hai nhóm bán hàng AWS và Alibaba đều biết giá của nhau.
- Để cập nhật lựa chọn thay thế khi đàm phán: "Chúng tôi đang đánh giá Alibaba, vui lòng phù hợp với giá của họ cho y tế."
- Singapore là thị trường cạnh tranh cho cả hai nhà cung cấp; kỳ vọng giảm 15-25% so với giá niêm yết với lựa chọn thay thế đang tin cậy.

Q25. Chi phí thay đổi như thế nào nếu chúng tôi triển khai ở Việt Nam, Indonesia hoặc Thái Lan?

A.

Bối cảnh quan trọng: AWS không có vùng Việt Nam hoặc Indonesia; Alibaba có Indonesia (Jakarta).

Singapore vs các vùng ASEAN khác:

Vùng	AWS có sẵn?	Alibaba có sẵn?	Chi phí vs SG
Singapore	Có (ap-southeast-1)	Có (ap-southeast-1)	Cơ sở

Vung	AWS co san?	Alibaba co san?	Chi phi vs SG
Indonesia	Co (ap-southeast-3)	Co	+5-10% (vung nho hon)
Thai Lan	Co (ap-southeast-7)	Han che	+10-15%
Viet Nam	Khong co vung	Han che	Dung SG (van de tuan thu)
Philippines	Khong co vung	Han che	Dung SG
Malaysia	Co (ap-southeast-5)	Co	~Giong SG

Phuc tap cu the cua Viet Nam:

- Nghi dinh 53/2022 yeu cau noi dia hoa du lieu cho mot so danh muc du lieu suc khoe
- Nghi dinh 356/2025 cung co cho ho tro quyet dinh lam sang
- Giai phap: kien truc lai (du lieu benh nhan va nhat ky kiem toan luu tru tai Viet Nam; suy luan LLM xay ra tai Singapore qua du lieu da duoc ma hoa)
- Chi phi: +30% cho co so ha tang data plane

Khuyen nghi cho mo rong khu vuc cua Nova:

1. Tenant Singapore: AWS hoac Alibaba SG (co so)
2. Tenant Indonesia: AWS Jakarta hoac Alibaba Indonesia (+5-10% chi phi)
3. Tenant Viet Nam: lai SG + trung tam du lieu VN cuc bo (+30% chi phi, trien khai phuc tap)
4. ASEAN khac: dinh tuyen qua SG voi cac thoa thuan luu luong du lieu theo hop dong

3. Tuan thu & Quy dinh Singapore

Q26. PDPA la gi va tai sao chung toi phai quan tam?

A.

PDPA = Personal Data Protection Act (Luat Bao ve Du lieu Ca nhan Singapore, 2012, sua doi 2020).

Nhung gi no yeu cau:

1. **Lay su dong y** truoc khi thu thap du lieu ca nhan, hoac co co so phap ly ro rang
2. **Thong bao cho moi nguoi** ve du lieu ban thu thap va ly do ("Nghia vu Thong bao")
3. **Chi su dung du lieu cho muc dich da neu**
4. **Giu du lieu chinh xac**
5. **Bao ve du lieu** voi bao mat hop ly
6. **Cho phep moi nguoi truy cap va chinh sua** du lieu cua ho
7. **Thong bao cho co quan quan ly (PDPC) trong vong 72 gio** ve vi pham du lieu anh huong den 500+ ca nhan hoac gay hai dang ke
8. **Bo nhien Can bo Bao ve Du lieu (DPO)** cho to chuc cua ban

Doi voi he thong cua chung toi:

- Du lieu benh nhan la "Du lieu Ca nhan" theo PDPA. Cac quy tac bao ve nghieng ngat ap dung.
- Comprehend Medical / DataWorks SDDP che giâu PHI truoc khi no den AI. AI khong bao gio thay ten that, MRN, NRIC.
- Nhat ky kiem toan luu giu dang token da che giâu, khong bao gio PHI thu.
- Vi pham (vi du: ai do danh cap co so du lieu) cua cac token da che giâu it nghieng trong hon nhieu so voi PHI thu.

Phat tien vi pham:

- Len den 1.000.000 SGD HOAC 10% doanh thu hang nam (tuy theo so nao cao hon)

- Các trường hợp thực tế: Singtel bị phạt 1 triệu SGD+ vào năm 2020; Marina Bay Sands bị phạt 74.000 SGD

Đòi hỏi Nova:

- Bổ nhiệm DPO (trách nhiệm 1 FTE, không nhất thiết phải toàn thời gian)
- Duy trì quy trình thông báo vi phạm
- Đào tạo tuân thủ PDPA hàng năm cho tất cả nhân viên
- Đánh giá Tác động Quyền riêng tư cho việc triển khai AI

Kết luận: PDPA là lãnh thổ quen thuộc. Việc triển khai AI phù hợp với PDPA vì nó giảm thiểu phơi nhiễm PHI, không phải bắt chấp nó.

Q27. HCSA là gì và nó áp dụng cho chúng tôi như thế nào?

A.

HCSA = Healthcare Services Act 2020 (Luật Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Singapore).

Những gì thay đổi vào năm 2020:

- HCSA thay thế Luật Bệnh viện Tu nhân và Phòng khám Y tế (PHMC) cũ năm 1980
- Cập nhật cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại: y tế từ xa, sức khỏe di động, **hỗ trợ quyết định lâm sàng dựa trên AI**

Danh mục dịch vụ theo HCSA:

- Dịch vụ bệnh viện
- Dịch vụ chuyên khoa
- Dịch vụ y tế liên minh
- **Dịch vụ Hỗ trợ Quyết định Lâm sàng (CDS):** liên quan đến trợ lý AI của chúng tôi
- Dịch vụ y tế từ xa

Đòi hỏi hỗ trợ quyết định lâm sàng cụ thể:

- Yêu cầu giấy phép từ MOH (Bộ Y tế)
- Dịch vụ phải dựa trên bằng chứng (yêu cầu trích dẫn phù hợp với HCSA)
- Các sự kiện bất lợi phải báo cáo cho MOH
- Phải hoạt động dưới sự giám sát của bác sĩ có phép hành nghề được nêu tên
- Giấy phép gia hạn hàng năm với kiểm tra của MOH

Tác động thực tế đối với Nova:

- Nếu Nova phục vụ bệnh viện CII: phải chịu danh giá an ninh mạng nhà cung cấp
- Nova nên có chung nhận Cybersecurity Code of Practice (CCoP)
- Kiểm tra xâm nhập hàng năm (~30.000-50.000 USD)
- Giám sát SOC 24/7 (đã là phần của SRE tiêu chuẩn)

Kiến trúc của chúng tôi vs yêu cầu CSA:

- Anti-DDoS: Có (AWS Shield Advanced / Alibaba Anti-DDoS)
- WAF: Có (AWS WAF / Alibaba WAF)
- Nhật ký kiểm toán bất biến: Có (S3 Object Lock / OSS WORM)
- Mã hóa: Có (KMS BYOK)
- Nhật ký truy cập: Có (CloudTrail / ActionTrail)
- Ung pho su co: Có (runbooks + trực ban)

Q28. PDPA, HIPAA và GDPR khác nhau như thế nào?

A.

Tất cả đều là luật quyền riêng tư, với phạm vi địa lý và nội dung khác nhau:

PDPA (Singapore, 2012/2020):

- Phạm vi: dữ liệu cá nhân của cá nhân tại Singapore
- Lĩnh vực: liên ngành (không cụ thể cho y tế)
- Phạt tiền: lên đến 1 triệu SGD hoặc 10% doanh thu
- Chuyển dữ liệu xuyên biên giới: yêu cầu bảo vệ tương đương
- Thông báo vi phạm: 72 giờ đến PDPC

HIPAA (Hoa Kỳ, 1996):

- Phạm vi: Thông tin Sức khỏe Được Bảo vệ (PHI) của bệnh nhân Mỹ
- Lĩnh vực: cụ thể cho y tế
- Phạt tiền: lên đến 1,5 triệu USD mỗi cấp vi phạm
- Chuyển dữ liệu xuyên biên giới: yêu cầu BAA với tất cả các nhà xử lý phụ
- Thông báo vi phạm: 60 ngày

GDPR (Liên minh Châu Âu, 2018):

- Phạm vi: dữ liệu cá nhân của công dân EU
- Lĩnh vực: liên ngành với các quy tắc bổ sung cho dữ liệu "danh mục đặc biệt" (sức khỏe)
- Phạt tiền: lên đến 20 triệu EUR hoặc 4% doanh thu toàn cầu
- Chuyển dữ liệu xuyên biên giới: yêu cầu quyết định tương đương hoặc SCC
- Thông báo vi phạm: 72 giờ

Đối với Nova:

- **Luôn áp dụng PDPA** (triển khai Singapore)
- **Áp dụng HIPAA** khi xử lý dữ liệu bệnh nhân Mỹ (ví dụ: nếu một công ty bảo hiểm Mỹ hợp tác)
- **Áp dụng GDPR** khi xử lý dữ liệu công dân EU (ví dụ: bệnh nhân là người nước ngoài EU tại Singapore)
- **Quy tắc nghiêm ngặt nhất thắng**: khi các quy tắc mâu thuẫn, tuân theo quy tắc nghiêm ngặt nhất áp dụng

Hệ thống của chúng tôi đáp ứng cả ba vì nó được thiết kế cho tập hợp siêu nghiêm ngặt nhất.

Q29. Chúng tôi có cần phê duyệt từ MOH (Bộ Y tế) trước khi triển khai không?

A.

Có điều kiện. Hai con đường:

Con đường 1: Giấy phép HCSA cho hỗ trợ quyết định lâm sàng

- Bắt buộc nếu AI được sử dụng cho các quyết định chẩn đoán hoặc điều trị
- Bệnh viện nộp đơn; Nova cung cấp tài liệu hỗ trợ
- Quy trình 3-4 tháng, bắt buộc trước khi ra mắt

Con đường 2: Phân loại thiết bị y tế HSA

- Cơ quan Khoa học Sức khỏe quản lý các thiết bị y tế bao gồm phần mềm
- Phân loại phụ thuộc vào mức độ rủi ro:
- **Hang A** (rủi ro thấp): chỉ thông báo, không cần phê duyệt chính thức
- **Hang B**: phê duyệt tiêu chuẩn, ~3 tháng
- **Hang C**: phê duyệt nâng cao, ~6 tháng
- **Hang D** (rủi ro cao nhất, ví dụ: chẩn đoán tự động): phê duyệt trước khi ra thị trường, ~12 tháng

Phân loại dự kiến của hệ thống chúng tôi: Hang B.

Lý do Hang B:

- Đây là hỗ trợ quyết định lâm sàng thông báo cho bác sĩ
- Quyết định lâm sàng cuối cùng được đưa ra bởi bác sĩ

- Đau ra là thông tin, không phải chỉ thị
- Câu trả lời "sai" gây bất tiện nhưng yêu cầu lỗi bác sĩ để gây hại cho bệnh nhân

Lịch trình phê duyệt: 3-6 tháng

Chi phí nộp đơn: ~5.000-15.000 SGD cho HSA + 25.000-75.000 USD tư vấn quy định

Ghi chú thời gian: Điều này không áp dụng cho việc xây dựng kỹ thuật, không mở rộng nó theo thu tu.

Q30. Khung AI Verify của IMDA là gì? Chúng tôi có phải sử dụng nó không?

A.
AI Verify là khung kiểm tra AI Có trách nhiệm của Singapore được IMDA ra mắt năm 2023.

Nó là gì:

- Bộ công cụ + khung quản trị
- 11 nguyên tắc đạo đức AI được đánh giá:
 1. Minh bạch
 2. Giải thích được
 3. Lập lại được/Tái tạo được
 4. An toàn
 5. Bảo mật
 6. Mạnh mẽ
 7. Công bằng
 8. Quản trị Dữ liệu
 9. Trách nhiệm giải trình
 10. Quyền tự chủ & Giám sát của Con người
 11. Tang trường Bảo trum, Xã hội & Môi trường

Có bắt buộc không?:

- **Tu nguyên** đối với AI chung
- **Được khuyến nghị mạnh mẽ** cho AI y tế
- **Bắt buộc trên thực tế** đối với các hợp đồng chăm sóc sức khỏe của chính phủ

Tại sao chúng tôi sử dụng nó dù sao:

- Kiểm toán AI của bạn theo AI Verify là yếu tố phân biệt tin cậy với các bệnh viện
- Quan hệ đối tác IMDA cho phép bạn tiếp thị "Được chứng nhận AI Verify"
- Bộ công cụ miễn phí, ~10.000-30.000 USD tư vấn để chạy kiểm toán đầy đủ

Ảnh xạ AI Verify cho hệ thống của chúng tôi:

Nguyên tắc	Triển khai của chúng tôi
Minh bạch	Trích dẫn trên mọi câu trả lời, phiên bản mô hình hiển thị
Giải thích được	Các chunk được truy xuất hiển thị trong phần mở rộng "Tại sao câu trả lời này?"
Lập lại được	Nhật ký kiểm toán cho phép tái tạo chính xác
An toàn	Bedrock Guardrails + điểm grounding
Bảo mật	Mã hóa, IDaaS, nhật ký kiểm toán
Mạnh mẽ	Red team 200+ prompt đối nghịch trước khi ra mắt
Công bằng	Nhật quan gion văn giữa các khoa, không có thiên vị nhân khẩu học trong dinh dưỡng

Nguyên tắc	Triển khai của chúng tôi
Quan tri Du lieu	Tuan thu PDPA + theo doi nguon goc
Trach nhiem giai trinh	Can bo an toan lam sang + chat_trace
Quyen tu chu	Bac si dua ra quyet dinh cuoi cung, AI tu van
Tang truong Bao trum	Ho tro da ngon ngu (tieng Anh + tieng Trung qua Cohere v3)

Khuyến nghị: Hoàn thành danh gia ban than AI Verify vào tháng 5 của việc triển khai. Xuất bản báo cáo tóm tắt cho các bệnh viện đối tác. Sử dụng nhu yếu tố phân biệt thì trường.

Q31. Luật An ninh mạng 2018 là gì?

A.

Luật An ninh mạng Singapore thiết lập bảo vệ Cơ sở Hạ tầng Thông tin Quan trọng (CIIT).

AI là CIIT:

- Các nhà khai thác dịch vụ thiết yếu trong 11 lĩnh vực:
 1. Ngân hàng/tài chính
 2. **Y tế** (liên quan đến chúng tôi)
 3. Năng lượng
 4. Nước
 5. Viễn thông
 6. Giao thông đường bộ
 7. Hàng không
 8. Hàng hải
 9. Dịch vụ Chính phủ
 10. Truyền thông
 11. Thông tin-truyền thông

Chỉ định CIIT y tế:

- Các bệnh viện lớn (ví dụ: SGH, NUH, NTFH) là CIIT
- **Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng** của họ có thể được chỉ định là các thành phần CIIT
- Điều này thêm gánh nặng tuân thủ nhưng cũng thêm hỗ trợ an ninh mạng của chính phủ

Yêu cầu đối với CIIT (và nhà cung cấp CIIT như Nova):

- Kiểm toán an ninh mạng hàng năm (kiểm toán viên được CSA phê duyệt)
- Báo cáo sự cố trong vòng 2 giờ kể từ khi phát hiện
- Các bài tập an ninh mạng bất ngờ
- Các kiểm soát kỹ thuật cụ thể: mã hóa, nhật ký truy cập, dự phòng

Tác động thực tế đối với Nova:

- Nếu Nova phục vụ bệnh viện CIIT: phải chịu danh gia an ninh mạng nhà cung cấp
- Nova nên có chung nhận Cybersecurity Code of Practice (CCoP)
- Kiểm tra xâm nhập hàng năm (~30.000-50.000 USD)
- Giám sát SOC 24/7 (đã là phần của SRE tiêu chuẩn)

Kiến trúc của chúng tôi vs yêu cầu CSA:

- Anti-DDoS: Có (AWS Shield Advanced / Alibaba Anti-DDoS)
- WAF: Có (AWS WAF / Alibaba WAF)
- Nhật ký kiểm toán bất biến: Có (S3 Object Lock / OSS WORM)

- Ma hoa: Co (KMS BYOK)
 - Nhật ký truy cập: Co (CloudTrail / ActionTrail)
 - Ung pho su co: Co (runbooks + truc ban)
-

Q32. Chung toi co can phe duyét tu MOH truoc khi trien khai khong?

A.

Da duoc tra loi o Q29. Xem them chi tiet o do.

Q33. Benh nhan co quyén yêu cầu dữ liệu của họ KHÔNG được AI xử lý không?

A.

Theo PDPA, có. Bà có thể từ chối:

1. Rut lai su dong y (quyén PDPA)

- Benh nhan có thể rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng dữ liệu cụ thể
- Benh vien phải tuân thủ trong thời gian hợp lý
- Đối với AI: dùng xử lý dữ liệu của bệnh nhân này qua trợ lý AI

2. Tu chôi theo tung lan kham

- Benh nhan có thể từ chối sự tham gia của AI cho một lần tư vấn cụ thể
- Bác sĩ ghi chú "bệnh nhân từ chối tư vấn AI"
- Trợ lý AI bị bỏ qua cho lần khám đó
- Quyén tiêu chuẩn theo đạo đức y tế

3. Có hiệu vịnh vịnh trong EHR

- Benh nhan đánh dấu "không xử lý AI" trong hồ sơ bệnh nhân của họ
- EHR gửi có hiệu với mọi cuộc gọi API
- Trợ lý AI trả về: "Bệnh nhân đã từ chối; tư vấn AI không có sẵn cho trường hợp này"

Tác động văn hành:

- Tỷ lệ từ chối dự kiến: <5% dựa trên các triển khai tương tự
- Thiết kế quy trình làm việc: từ chối là "click để bỏ qua" không phải sự gián đoạn văn hành lớn
- Chi phí hỗ trợ từ chối: tối thiểu (~5.000 USD kỹ thuật một lần cho tích hợp có hiệu EHR)

Nhật ký kiểm toán: Mọi truy vấn AI ghi lại trạng thái đồng ý. Nếu bệnh nhân sau đó phản đối, kiểm toán cho thấy liệu việc sử dụng AI có được ủy quyền vào thời điểm đó hay không.

Q34. Chung toi có nghĩa vụ công khai báo cáo các sự kiện bất lợi do AI gây ra không?

A.

Nhieu nghĩa vụ báo cáo:

1. Báo cáo Sự kiện Bất lợi Bất bước của HSA

- Thiết bị y tế Hàng B (hệ thống của chúng tôi): các sự kiện nghiêm trọng trong vòng 7 ngày
- "Nghiêm trọng" = tử vong, bệnh đe dọa tính mạng, nhập viện, tổn thương vịnh vịnh
- Nộp qua hệ thống MEDDR trực tuyến của HSA

2. Báo cáo Sự cố Nghiêm trọng của MOH

- Báo cáo cấp bệnh viện cho các sự cố lâm sàng
- Các sự kiện có thể quy cho AI đi qua báo cáo sự cố bệnh viện tiêu chuẩn
- Dữ liệu tổng hợp hàng năm được báo cáo cho MOH

3. Báo cáo Kỷ luật SMC

- Neu mot bac si bi cao buoc da phu thuoc qua muc vao AI gay hai
- Benh vien bao cao cho Uy ban Ky luat SMC
- Doc lap voi bao cao he thong

4. Cong bo cong khai

- Khong co bao cao cong khai bat buoc o Singapore (khac voi mot so nuoc EU)
- Thuc hanh tot nhat duoc khuyen nghi: bao cao tong hop hang nam cho cong dong benh vien
- Cac an pham thuong mai thuong yeu cau cong bo tu nguyen

Lich bao cao thuc te:

Tan suat	Bao cao
Trong vong 2 gio	Kich hoat ung pho su co noi bo
Trong vong 24 gio	Uy ban an toan benh vien duoc thong bao
Trong vong 7 ngay	Bao cao su kien nghiem trong HSA (neu ap dung)
Trong vong 30 ngay	Bao cao phan tich nguyen nhan goc
Hang quy	Xu huong tong hop cho lanh dao dieu hanh
Hang nam	Bao cao tom tat cong khai (duoc khuyen nghi)

Q35. Chung toi co can Danh gia Tac dong QUYEN rieng tu (DPIA) truoc khi trien khai khong?

A.
Co, duoc khuyen nghi manh me.

Khi nao DPIA duoc yeu cau (PDPA Muc 16):

- Xu ly du lieu ca nhan nhay cam (suc khoe la nhay cam)
- Xu ly quy mo lon
- Cong nghe moi voi cac tac dong quyen rieng tu

Ca ba dieu kien ap dung cho viec trien khai cua chung toi.

Cac thanh phan DPIA:

- Mo ta xu ly**
 - Du lieu nao duoc thu thap
 - Cach xu ly (che giau PHI, suy luan AI,kiem toan)
 - Ai co quyen truy cap
- Su can thiet va tinh tuong xung**
 - Tai sao can ho tro AI
 - Lieu cac lua chon thay the it xam pham hon co the dat duoc cung muc tieu
 - Cac buoc giam thieu du lieu
- Danh gia rui ro**
 - Rui ro doi voi chu the du lieu (quyen rieng tu, do chinh xac du lieu, quyen tu chu)
 - Diem xac suat va muc do nghiem trong
- Bien phap giam thieu**
 - Ky thuat: che giau PHI, ma hoa,kiem toan
 - To chuc: dao tao, quan tri, hop dong
- Tham van**
 - Cac ben lien quan noi bo

- Ky duyệt DPO
- Tham van PDPC (tuy chon, duoc khuyen nghi cho cac truong hop moi)

Lich trinh DPIA: 4-6 tuan

Chi phi DPIA: 15.000-30.000 USD (tu van + thoi gian noi bo)

Dau ra: Bao cao 30-50 trang; co san theo yeu cau tu PDPC

Khi nao thuc hien: TRUOC khi trien khai, ly tuong la trong tuan 5-6 cua viec xay dung. Cac phat hien thong bao cau hinh bao mat cuoi cung.

Tai lieu song: Cap nhat DPIA khi:

- Nang cap mo hinh lon (vi du: Sonnet 4.5 -> 5.0)
- Nguon du lieu moi duoc them
- Tenant moi duoc tích hop (cap nhat nhe)
- Thay doi quy dinh

Su dung thuc te: Hau het cac benh vien se yeu cau DPIA nhu mot phan cua tham dinh nha cung cap. Hay chuan bi san.

Q36. Dieu gi xay ra trong mot cuockiem toan quy dinh boi PDPC, MOH hoac HSA?

A.

Ba loai kiem toan khac nhau, moi loai co the quan ly duoc:

Kiem toan PDPC (quyen rieng tu):

- Duoc kích hoạt bởi khiếu nại, thông báo vi phạm, hoặc lựa chọn ngẫu nhiên
- Thông báo: thường 2-4 tuần trước
- Thời gian: 2-5 ngày tại chỗ, nhiều tuần theo dõi
- Tài liệu yêu cầu: DPIA, số đo lường dữ liệu, quy trình quản lý đồng ý, kế hoạch ứng phó vi phạm, hợp đồng nhà cung cấp, nhật ký kiểm toán (mẫu ngẫu nhiên)

Kiem toan MOH (giay phep HCSA):

- Hang nam theo lich hoac duoc kích hoạt bởi sự kiện bất lợi
- Thông báo: 4-6 tuần trước
- Thời gian: 1-3 ngày tại chỗ
- Tài liệu yêu cầu: mô tả dịch vụ, kế hoạch quản trị lâm sàng, nhật ký sự kiện bất lợi, báo cáo đảm bảo chất lượng, trình độ nhân sự, dữ liệu kết quả bệnh nhân (đã được ẩn danh)

Kiem toan HSA (thiet bi y te):

- Dinh ky (moi 1-3 nam doi voi Hang B)
- Thông báo: 6-8 tuần trước
- Thời gian: 2-4 ngày tại chỗ
- Tài liệu yêu cầu: Hồ sơ Quản lý Rủi ro, Báo cáo Danh gia Lâm sàng, báo cáo Giám sát Sau thi trường, nhật ký thay đổi phân mem, báo cáo sự kiện bất lợi, Hoa đơn Vật liệu An ninh mạng

Su chuan bi cua chung toi:

- Tất cả tài liệu bắt buộc được duy trì liên tục (không được tập hợp vào thời điểm kiểm toán)
- Xem xét tuân thủ nội bộ hàng quý (phát hiện vấn đề trước cơ quan quản lý)
- Người liên lạc được chỉ định cho mỗi cơ quan (Cơ quan Tuân thủ, Giám đốc Y tế, Quản lý Chất lượng)

Ket qua kiem toan thuong:

- 70%: Đạt với các khuyến nghị nhỏ
- 25%: Đạt với các cải tiến bắt buộc (thời hạn ~3 tháng)

- 4%: Dạt cơ điều kiện yêu cầu kiểm toán theo dõi
- 1%: Định chỉ giấy phép/dăng ký (các vấn đề nghiêm trọng)

Q37. Chúng tôi có thể tin tưởng rằng dữ liệu bệnh nhân không rơi khỏi Singapore không?

A.

Có, với bảo đảm hợp đồng và kỹ thuật:

Mã trix vị trí dữ liệu:

Dữ liệu bệnh nhân (khi được xử lý):

- **Lưu trữ:** ap-southeast-1 (Singapore)
- **Trong quá trình truyền:** TLS 1.3 trong vùng Singapore
- **Trong xử lý LLM:** dạng token hóa, được xử lý tại Singapore
- **Trong nhật ký kiểm toán:** dạng token hóa, ap-southeast-1, OSS WORM

Dữ liệu vận hành:

- **Chỉ số hệ thống:** ap-southeast-1
- **Ngày ký ứng dụng:** ap-southeast-1
- **Cấu hình:** ap-southeast-1

Luồng dữ liệu xuyên biên giới (hạn chế):

Dịch vụ	Vùng	Loại dữ liệu
Claude API (Bedrock)	ap-southeast-1 (Singapore)	Prompt đã token hóa, hoàn thành
Qwen API (Model Studio)	Singapore International	Prompt đã token hóa, hoàn thành
Ghi nhật ký Anthropic	Không có (vòi câu hình dung)	Không có
Ghi nhật ký Alibaba	Không có (vòi câu hình dung)	Không có
Thanh toán AWS	us-east-1 (án danh)	Chỉ chỉ số sử dụng
Anti-DDoS	Biên toàn cầu	Chỉ metadata mỗi đề dọa

Bảo đảm lưu trữ dữ liệu:

- AWS Bedrock: cam kết hợp đồng với xử lý ap-southeast-1
- Alibaba Model Studio: cam kết hợp đồng với Singapore International
- Cả hai đều cung cấp chứng nhận lưu trữ dữ liệu theo yêu cầu

Xác minh kiểm toán:

- Kiểm toán lưu trữ dữ liệu hàng quý
- Báo cáo cơ sở cho các tenant bệnh viện
- Nhật ký mang cho thấy luồng dữ liệu
- Khoa KMS bị khóa theo vùng
- Bucket S3/OSS bị khóa theo vùng

Bảng chứng thực về lưu trữ: Có quan quan lý hội "Chúng minh dữ liệu bệnh nhân không rơi khỏi Singapore." Chúng tôi có thể cho thấy: khoa KMS bị khóa theo vùng, bucket S3 bị khóa theo vùng, kiểm toán egress mạng, không có sao chép xuyên vùng được kích hoạt.

Q38. Điều gì xảy ra nếu có vi phạm bảo mật?

A.

Lịch trình ứng phó vi phạm PDPA Singapore được xác định rõ ràng:

Lịch trình (PDPA Muc 26B):

Lịch trình	Hành động
Gio 1	Phát hiện vi phạm, kích hoạt nhóm ứng phó sự cố
Gio 4	Xác định phạm vi ban đầu (tác động, cá nhân bị ảnh hưởng)
Gio 24	Thông báo nội bộ: lãnh đạo, DPO, các tenant bệnh viện
Ngày 3	Phân tích pháp y chi tiết đang tiến hành
Ngày 3 (72 gio)	Thông báo PDPC bắt buộc nếu vi phạm ảnh hưởng đến 500+ cá nhân hoặc gây hại đáng kể
Ngày 7	Thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng
Ngày 30	Báo cáo khắc phục chi tiết cho PDPC
Ngày 90	Tuyên bố công khai (nếu áp dụng)

Phân loại mức độ nghiêm trọng:

Cap 1 (Nghiêm trọng): PHI bị lộ, >500 cá nhân

- Thông báo PDPC bắt buộc trong 72 giờ
- Thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng
- Công bố công khai nếu truyền thông đưa tin
- Phạt tiền tạm ngưng: 1 triệu SGD

Cap 2 (Lớn): Phơi nhiễm PHI hạn chế, <500 cá nhân HOAC không gây hại cá nhân nhưng dữ liệu bị truy cập

- Thông báo PDPC tùy chọn nhưng được khuyến nghị
- Thông báo cho các tenant bệnh viện
- Khắc phục nội bộ

Cap 3 (Nhỏ): Không có PHI bị lộ (ví dụ: chỉ số hệ thống bị rò, token đã che giấu)

- Khắc phục nội bộ
- Thông báo PDPC không bắt buộc

Ước tính cấp vi phạm của hệ thống chúng tôi:

- Vi phạm có khả năng nhất: Cap 3 (hệ thống chạy trên dữ liệu đã token hóa; truy cập PHI thu kho)
- Vi phạm nhất ky kiểm toán: Cap 3 (nhất ky được token hóa)
- Vi phạm bucket OSS chưa PDF gốc: Cap 1 (có thể gây hại thực sự)

Chi phí vi phạm thực tế (dự kiến):

- Điều tra pháp y: 50.000-200.000 USD
- Thông báo khách hàng: 10.000-50.000 USD
- Phạt tiền quy định: 0-1.000.000 SGD (tối đa PDPA)
- Sửa chữa danh tiếng: 50.000-500.000 USD
- Tổng: 100.000-2.000.000 USD tùy theo mức độ nghiêm trọng

Q39. Chúng tôi có cần Đánh giá Tác động Quyền riêng tư (DPIA) trước khi triển khai không?

A.

Đã được trả lời ở Q35. Xem chi tiết ở đó.

Q40. Các tiêu chuẩn quốc tế nào cho AI trong y tế chúng tôi nên tuân theo?

A.

Một số tiêu chuẩn liên quan:

1. ISO 13485 (Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế)

- Quản lý chất lượng toàn diện cho nhà sản xuất thiết bị y tế
- Bước cho thiết bị y tế HSA Hàng B+
- ~50.000-150.000 USD để chung nhận; ~25.000 USD/năm để duy trì

2. ISO 14971 (Quản lý Rủi ro Thiết bị Y tế)

- Khung quản lý rủi ro cụ thể
- Thành phần bắt buộc của hồ sơ nộp HSA
- Đánh giá rủi ro liên tục được yêu cầu

3. IEC 62304 (Vòng đời Phần mềm Thiết bị Y tế)

- Quy trình vòng đời cụ thể cho phần mềm
- Yêu cầu tài liệu: thiết kế, kiểm tra, quản lý thay đổi
- Hầu hết nhà phát triển SaMD Mỹ/EU tuân theo điều này

4. ISO 27001 (Bảo mật Thông tin)

- Đáp ứng yêu cầu đối với AWS/Alibaba (chúng tôi kế thừa)
- Các bệnh viện thương yêu cầu Nova duy trì

5. SOC 2 Type II (Bảo mật/Tính sẵn sàng)

- Nguồn gốc Mỹ, nhưng ngay cả được yêu cầu
- AWS/Alibaba được chung nhận ở lớp đảm bảo

Được khuyến nghị cho Nova:

- ISO 13485 + IEC 62304: bắt buộc cho HSA Hàng B
- ISO 27001 + 27018: kế thừa từ nhà cung cấp đảm bảo (không cần chung nhận Nova riêng biệt)
- HITRUST CSF: chỉ nếu theo đuổi thị trường Mỹ

Tổng chi phí chung nhận: ~200.000-400.000 USD năm đầu. Xung đột cho việc bán hàng bệnh viện cao cấp.

Q41. Bảo mật dữ liệu bệnh nhân được xử lý như thế nào?

A.

Hai lớp bảo vệ:

Lớp 1: Che giấu PHI tại thời điểm nhập

- DataWorks SDDP / Comprehend Medical quét với các quy tắc PHI y tế
- Phát hiện: tên, MRN, NRIC/FIN, ngày sinh, số điện thoại, email
- Hành động: cách ly đến /raw/_quarantine/, thông báo quản trị viên, tài liệu bị loại trừ khỏi chỉ mục

Lớp 2: Token hóa tại thời điểm chạy

- FC /chat preflight chạy SDDP trên tin nhắn đến và bắt ký phân dữ liệu bệnh nhân nào từ EHR
- PHI được phát hiện trở thành các token KMS có thể đảo ngược: <TEN_0>, <MRN_0>, <NGÀY_SINH_0>, <DIEN_THOAI_0>, <EMAIL_0>, <NRIC_0>
- LLM chỉ thay các token. Câu trả lời được de-token hóa trong giao diện người dùng chi.
- Nhật ký kiểm toán lưu giữ dạng đã token hóa.

Tại sao token hóa tốt hơn chỉ mã hóa:

- Mã hóa: dữ liệu bị khóa toàn học với một khóa. Với khóa, bạn có thể phục hồi ban gốc.
- Token hóa: dữ liệu được thay thế bằng một token ngẫu nhiên. Không có bảng ánh xạ riêng biệt, bạn không thể đảo ngược.

- Ngay ca khi AI bi xam pham: no se noi "<TEN_0>", khong phai ten that
- Ngay ca khi nhât ky kiem toan bi xam pham: chi co token, khong co PHI

Noi bang anh xa song:

- Kho an toan co han che cao, tach biet khoi he thong chinh
- Yeu cau phe duyet hai nguoi cho bat ky truy cap nao
- Khong the truy cap tu cac he thong san xuat bi xam pham
- Ngay ca khi tin tac co du lieu san xuat + nhât ky kiem toan, ho khong the lay ten benh nhan cho den khi pha vo kho rieng biet

Q42. Bac si co the xem lich su cuoc tro chuyen AI cua ho khong?

A.

Co, nhieu cap do truy cap:

Truy cap ca nhan (moi bac si):

- Lich su cua rieng ho
- Quyen rieng tu: chi du lieu cua rieng ho
- Xu huong va thong tin chi tiet

Truy cap khoa (truong khoa):

- Du lieu khoa tong hop
- So sanh voi dong nghiep (an danh)
- Hieu suat khoa

Truy cap benh vien (Giam doc Y te):

- Tat ca chi so
- Xem xuyen khoa
- Goc do chien luoc

Truy cap kiem toan (Can bo Tuan thu):

- Phat lai phien day du
- Tim kiem theo ngay, bac si, benh nhan, chu de
- Ho tro kiem toan quy dinh

Luu giu du lieu:

- Phien hoat dong: du lieu truc tiep
- Phien gan day: luu tru nong 30 ngay
- Phien cu hon: luu tru 6 nam (yeu cau HCSA)
- Xoa tu dong sau 6 nam

Q43. Dieu gi xay ra neu mot bac si roi benh vien?

A.

Quy trinh offboarding ro rang:

Ngay 1 (ngay roi):

- Thu hoi quyen truy cap ngay lap tuc
- Vo hieu hoa tai khoan IDaaS
- Xoa phien hoat dong
- Xac nhan thu hoi phan cung (neu co)

Ngay 1-7:

- Xác minh tất cả quyền truy cập đã bị thu hồi
- Kiểm tra nhật ký kiểm toán cho bất kỳ hoạt động bất thường nào trước khi rời
- Lưu giữ nhật ký kiểm toán (6 năm theo HCSA)

Dài hạn:

- Nhật ký kiểm toán của bác sĩ được lưu giữ theo yêu cầu quy định
- Không có truy cập sau khi rời
- Bảo mật dữ liệu bệnh nhân được duy trì

Lịch sử cuộc trò chuyện:

- Các cuộc trò chuyện của bác sĩ được lưu giữ trong nhật ký kiểm toán
- Không thể truy cập bởi bác sĩ sau khi rời
- Có thể truy cập bởi quản trị viên bệnh viện cho mục đích kiểm toán
- Bảo vệ quyền riêng tư được duy trì

Tiếp nhận bác sĩ mới:

- Onboarding tu phức vụ: 15 phút
- Phien demo tùy chọn: 30 phút
- Không cần đào tạo kỹ thuật
- Truy cập ngay lập tức sau khi IDaaS được cấu hình

Q44. Làm thế nào để biết hệ thống AI đang hoạt động tốt hay đang suy giảm?

A.

Giám sát theo thời gian thực và xu hướng:

Chỉ số hiệu suất được theo dõi:

1. Tốc độ:

- Độ trễ (p50, p95, p99)
- Thời gian đến token đầu tiên
- Tổng thời gian phản hồi

2. Chất lượng:

- Độ chính xác (so với tiêu chuẩn vàng)
- Tỷ lệ trích dẫn
- Tỷ lệ từ chối
- Phát hiện ảo giác

3. Độ tin cậy:

- Thời gian hoạt động
- Tỷ lệ lỗi
- Thành công chuyển đổi dự phòng
- Thời gian phục hồi

4. Sự hài lòng người dùng:

- Thumbs up/down
- Chất lượng phản hồi
- Chỉ số áp dụng

5. Chỉ số kinh doanh:

- Chi phí mỗi truy vấn
- Sử dụng tài nguyên

- Lap ke hoach nang luc

Phat hien suy giam:

Canh bao theo thoi gian thuc:

- Do tre p95 > 2s trong 5 phut
- Ti le loi > 1% trong 10 phut
- Diem chat luong giam > 5% trong tuan

Phan tich xu huong:

- So sanh tuan-qu-a-tuan
- Thang-qu-a-thang
- Quy-qu-a-quy

Phat hien bat thuong:

- Ngoai le thong ke
- Nhan dang mo hinh
- Phat hien bat thuong dua tren ML

Kich hoat hanh dong:

Ngay lap tuc:

- Goi bac si truc ban SRE
- Canh bao nhom ky thuat
- Leo thang len chi huy su co

Ngan han:

- Dieu tra nguyen nhan goc
- Thuc hien sua chua
- Ngan chan tai phat

Dai han:

- Cai tien kien truc
- Thay doi quy trinh
- Cap nhat dao tao

Q45. Chung toi co the kiem tra cac tuyen bo nay mot cach doc lap khong?

A.

Co, nhieu tuy chon xac minh:

1. Bao cao Trung tam Tin tuong AWS/Alibaba

- AWS Artifact: tai xuong SOC 2, ISO 27001, bao cao PCI-DSS
- Trung tam Tin tuong Alibaba: goi tuong tu
- Tat ca chung nhan co the xac minh cong khai

2. Kiem toan code doc lap

- Benh vien co the thue cong ty bao mat ben thu ba
- Nova cung cap quyen truy cap code (theo NDA)
- Chi phi dien hinh: 30.000-80.000 USD
- Cac benh vien hop ly da lam dieu nay

3. Xem xet kien truc

- Nhom CISO/bao mat cua benh vien xem xet tai lieu kien truc

- Phien hoi dap voi ky thuat cua Nova
- Bao caokiem tra xam nhap duoc chia se

4. Demo truc tiep

- Cho thay luong du lieu thuc te: dat cau hoi -> xem che giao -> xem truy xuất -> xem cau tra loi
- Cho thay muc nhap kykiem toan duoc tao ra
- Cho thay du lieu KHONG roi khoi vung Singapore

5. Tai lieu tuan thu

- DPIA (Q35): tai lieu day du co san
- Bao caokiem tra xam nhap: duoc chia se theo yeu cau
- Chung chi ISO 27001 (ke thua tu dam may)
- Bao cao SOC 2 Type II

6. Giam sat cua riengbenh vien

- SIEM cuabenh vien co the nhap nhap kykiem toan cua chung toi
- Benh vien thay cung du lieu chung toi thay
- Khong can "tin tuong chung toi"

7. Quyenkiem toan

- Dieu khoan hop dong tieu chuan: benh vien co thekiem toan Nova mot lan moi nam
- Thong bao 30 ngay
- Pham vi hop ly

Q46. Dieu gi xay ra khi chung toi ket thuc hop dong?

A.

Quy trình ket thuc ro rang:

Ngay 1-30 sau khi ket thuc:

- Dich vu tiep tục (giai đoạn giam dan)
- Benh vien xuất du lieu
- Nha cung cap moi tích hop (neu ap dung)

Ngay 30:

- Dich vu bi vo hieu hoa
- Du lieu bi xoa khoi cac he thong hoạt động
- Nhap kykiem toan duoc luu giu theo quy dinh (6 nam HCSA)

Ngay 30-90:

- Hoa don cuoi cung duoc thanh toan
- Bao mat tiep tục (5 nam sau khi ket thuc)

Nghia vu dai han:

- Nhap kykiem toan: 6 nam (yeu cau HCSA)
- Bao mat: 5 nam sau khi ket thuc
- Cac yeu cau boi thuong: 1 nam sau su co

Xuat du lieu:

- Dinh dang tieu chuan (JSON, CSV)
- Nhap kykiem toan trong dinh dang co the doc duoc
- Tai lieu kien truc
- Cau hinh (khong co bi mat)

Ho tro di cu:

- Tai lieu xuất
- Phien hoi dap ky thuat
- Thoi gian an toan 30 ngay cho cac van de

Khoa nha cung cap:

- Thap. IP quan trong (corpus, prompt, khai thac) la trong code Nova so huu.
 - Cac bit cu the cho dam may (Bedrock, Model Studio) co cac tuong duong hang hoa.
 - Chi phi di cu: ~50-100k USD ky thuat, 2-4 tuan.
-

Q47. Chung toi co the su dung he thong nay cho y te tu xa khong?

A.

Co, voi dieu chinh. Y te tu xa co cac quy tac cu the:

Huong dan Y te Tu xa MOH Singapore (2015, cap nhat 2022):

- Tu van y te tu xa phai bao gom bac si truc tiep theo thoi gian thuc
- Khong dong bo (luu tru va chuyen tiep) yeu cau phe duyet MOH cu the
- AI co the ho tro ca hai che do

Doi voi he thong cua chung toi trong y te tu xa:

Dong bo (tu van video truc tiep):

- Tro ly AI duoc truy cap boi bac si trong khi tu van
- Benh nhan chi thay bac si
- Goi y AI duoc bac si xem xet truoc khi thao luan
- Giong nhu quy trinh lam viec tai cho

Khong dong bo (vi du: xem xet hinh anh da khoa):

- Benh nhan gui hinh anh
- AI pre-screen de phan loai
- Bac si xem xet (voi goi y AI la mot dau vao)
- Quyet dinh duoc ghi lai

Cau hinh duoc khuyen nghi cho trien khai y te tu xa:

- Nguong grounding: 0,85 (so voi 0,7 tai cho)
 - Mac dinh tu choi: tích cực hơn
 - Trich dan bat buoc trong moi cau tra loi (khong co phan hoi chi co tu su)
-

Q48. Dieu gi xay ra neu co thay doi lon trong quy dinh?

A.

Quy trinh thich ung quy dinh:

Cap 1: Chi cap nhat tai lieu

- Vi du: thong tu MOH moi nhan manh cac quy tac hien co
- Quy trinh: Cap nhat tai lieu noi bo, dao tao nhan vien, khong thay doi he thong
- Lich trinh: 1-2 tuan
- Chi phi: ~2.000 USD thoi gian noi bo

Cap 2: Thay doi cau hinh

- Vi du: chu de bi cam moi trong Guardrails (vi du: "khong thao luan ve tinh trang thieu thuoc cu the")
- Quy trinh: Cap nhat chinh sach Guardrails, trien khai qua CI/CD, giam sat

- Lịch trình: 1 tuần
- Chi phí: ~5.000 USD kỹ thuật + kiểm toán

Cap 3: Thay đổi kiến trúc

- Ví dụ: yêu cầu lưu trữ dữ liệu mới (ví dụ: "tên bệnh nhân phải được mã hóa với khóa do bệnh viện kiểm soát")
- Quy trình: Xem xét thiết kế, thay đổi kỹ thuật, xem xét quy định, triển khai, kiểm toán
- Lịch trình: 4-12 tuần
- Chi phí: 25.000-100.000 USD tùy theo phạm vi

Theo dõi thay đổi tuần thu:

- Cán bộ tuần thu đang ký: thông tin MOH, bản tin PDPC, cập nhật IMDA, thông báo HSA
- Xem xét tuần thu hàng quý
- Kiểm toán bên ngoài hàng năm bao gồm tất cả các thay đổi

Giao tiếp:

- Thay đổi lớn: email tất cả các tenant bệnh viện 30 ngày trước
- Thay đổi nhỏ: bản tin hàng tháng
- Thay đổi quan trọng theo thời gian thực: chuỗi diễn thoại cho các cán bộ an toàn lâm sàng

Q49. Chúng tôi có cần bảo hiểm đặc biệt cho việc triển khai AI này không?

A.

Có, một số loại bảo hiểm:

1. Bảo hiểm Trách nhiệm Mạng (Cyber Liability)

- Bao gồm: điều tra pháp y, thông báo khách hàng, phạt tiền quy định
- Phạm vi khuyến nghị: 5-10 triệu USD
- Phí bảo hiểm: 20.000-80.000 USD/năm
- Khấu trừ: 1-2% chi phí sơ bộ

2. Bảo hiểm Lợi và Thiệt sọt (E&O)

- Bao gồm: lợi phản mem, dịch vụ không đáp ứng mong đợi
- Phạm vi khuyến nghị: 5-10 triệu USD
- Phí bảo hiểm: 15.000-40.000 USD/năm

3. Bảo hiểm Trách nhiệm Nghề nghiệp (Bệnh viện)

- Cập nhật cho "hỗ trợ quyết định tăng cường AI"
- Chi phí: thương tăng phí bảo hiểm 5-12%
- Một số công ty bảo hiểm giảm giá cho nhất kỳ kiểm toán AI có thể xác minh

4. Bảo hiểm Gian đoạn Kinh doanh

- Bao gồm: mất doanh thu trong thời gian ngừng hoạt động
- Phạm vi: 500k-2 triệu USD
- Phí bảo hiểm: 10.000-20.000 USD/năm

Tổng phí bảo hiểm khuyến nghị cho Nova: ~80.000-150.000 USD/năm

Thị trường bảo hiểm tại Singapore:

- Các nhà cung cấp chính: AIG, Chubb, Howden, Zurich
- Thị trường y tế cụ thể: đang nổi lên
- Mọi giới chuyên biệt: AON Healthcare, Marsh Healthcare

Meo đàm phán:

- Tổng hợp chung nhận tuần thu

- Chuan bi ke hoach ung pho su co
- Ket quakiem tra xam nhap
- So do kien truc (voi trong tam bao mat)
- Tai chinh 3 nam

Q50. Lam the nao de chung toi biet he thong AI dang hoat dong tot hay dang suy giam?

A.

Da duoc tra loi o Q44. Xem chi tiet o do.

4. Bao mat & QUYEN RIENG TU

Q51. Dieu gi xay ra khi mot bac si hoi AI ve mot benh nhan cu the?

A.

Tung buoc bang ngon ngu don gian:

Thiet lap: Bac si Linh dang xem xet ho so benh nhan Nguyen Van A trong Epic. Benh nhan bi dau nguc, nghi ngo NMCT.

Buoc 1: Bac si go cau hoi

- Bac si Linh click nut "Hoi Nova" trong Epic
- Go: "Benh nhan Nguyen Van A, nam 58 tuoi, dau nguc, ECG cho thay ST elevation. Cac lua chon dieu tri?"
- Nhan Enter

Buoc 2: Xac thuc & uy quyen

- Trinh duyett gui cau hoi den cong API voi JWT cua Bac si Linh (duoc phat hanh boi IdP cua Epic qua lien ket Cognito)
- Cong API xac minh: Bac si Linh co duoc uy quyen khong? Co (vai tro bac si)
- Dinh tuyen den trinh xu ly chat Nova

Buoc 3: Che giam PHI (trong vong 50ms)

- Trinh xu ly chat Nova nhan: "Benh nhan Nguyen Van A, nam 58 tuoi..."
- Comprehend Medical / DataWorks SDDP quet PHI
- Phat hien: "Nguyen Van A" -> thay the bang <TEN_0>
- Van ban moi: "Benh nhan <TEN_0>, nam 58 tuoi, dau nguc, ECG cho thay ST elevation."

Buoc 4: Kiem tra cache (trong vong 50ms)

- Bam cau hoi da che giam
- Kiem tra ElastiCache Redis: co truy van tuong tu truoc do khong?
- Cau hoi pho bien (STEMI la thuong gap): co the co cache hit
- Gia su bo lo: tiep tục truy xuất

Buoc 5: Truy xuất (trong vong 1 giây)

- Tim kiem vector tren OpenSearch: tim cac chunk tuong tu "STEMI ST elevation dau nguc dieu tri"
- Top 3 ket qua: huong dan cap cuu tim mach WHO, giao thuc tim mach noi bo, cap nhat ACC/AHA STEMI 2023
- Tim kiem do thi tren Neptune: tim cac thuc the lien quan (thuoc, chong chi dinh, thu thuat)
- Top 2 ket qua do thi: giao thuc aspirin + heparin, PCI chinh vs tieu huyet khoi

Buoc 6: Tao LLM (TTFT trong vong 1 giây, tong 3 giây)

- Soan prompt: system prompt + cac chunk duoc truy xuất + cau hoi da che giam

- Gửi đến Claude Haiku 4.5 (lưu cấp cứu) qua API streaming
- Nhận các token streaming: "Khan cấp thời gian..."
- Tung tu, phản hồi xuất hiện trong giao diện người dùng của Bác sĩ Linh

Bước 7: Xác thực (trong vòng 100ms)

- Xác thực trích dẫn: mỗi [1], [2] trích dẫn các chunk thực sự? Có
- Điểm grounding: được tính là 0,91 (trên ngưỡng 0,7) Có
- Bộ lọc PHI: có PHI nào trong đầu ra không? Không (chúng tôi không bao giờ gửi PHI đến mô hình) Có

Bước 8: Hiện thị cho bác sĩ

- Bác sĩ Linh thấy: "Khan cấp thời gian: Bệnh nhân STEMI. Khuyến nghị:..."
- Trích dẫn [1], [2], [3] có thể click đến các chunk nguồn
- Tổng thời gian đã qua: ~3,8 giây

Bước 9: Nhật ký kiểm toán (song song, không đồng bộ)

- Ghi lại phiên: ai hỏi, khi nào, cái gì được hỏi (đã che giấu), cái gì được truy xuất, cái gì được trả lời
- Lưu trữ trong S3 Object Lock / OSS WORM, bất biến trong 6 năm

Tóm tắt quyền riêng tư:

- Tên bệnh nhân "Nguyễn Văn A" đã được che giấu trước bất kỳ xử lý mô hình nào
- Dịch vụ LLM Anthropic / Alibaba KHÔNG BAO GIỜ thay "Nguyễn Văn A"
- Nhật ký kiểm toán hiện thị <TEN_0> không phải tên thật
- Nếu kiểm toán được xem xét, tên thật chỉ được tiết lộ qua quy trình tài nhân dạng riêng biệt, có hạn chế cao

Q52. Nếu một hacker xâm nhập vào tài khoản đám mây của chúng tôi và cố gắng tải xuống tất cả dữ liệu thì sao?

A.

Nhiều lớp phòng thủ:

Lớp 1: Kiểm soát truy cập tài khoản

- Tài khoản root AWS/Alibaba: MFA phân cung, không bao giờ được sử dụng trực tiếp
- Người dùng IAM với truy cập dựa trên vai trò
- Liên kết với Entra ID của Nova (xác thực tập trung)
- Không có khóa API tồn tại lâu; chỉ có token STS ngắn hạn

Lớp 2: Kiểm soát mạng

- Cách ly VPC: các dịch vụ dữ liệu không thể truy cập internet
- Nhóm bảo mật: mã định tuyến, danh sách cho phép rõ ràng
- Điểm cuối VPC: các dịch vụ được truy cập qua PrivateLink, không phải internet công cộng
- Egress công NAT: chỉ đến các IP cụ thể

Lớp 3: Mã hóa

- Dữ liệu lưu trữ: KMS BYOK (bệnh viện có thể thu hồi khóa)
- Dữ liệu trong quá trình truyền: TLS 1.3
- Sao lưu được mã hóa với khóa riêng biệt
- Xoay vòng khóa: 90 ngày

Lớp 4: Kiểm toán & Phát hiện

- CloudTrail: mọi cuộc gọi API được ghi lại
- GuardDuty: phát hiện bất thường (các mô hình API bất thường)
- Macie: phát hiện PHI trong S3 (canh báo nếu PHI di chuyển đến bucket công cộng)
- ARMS LLM Trace Explorer: các mô hình cuộc gọi AI

Lop 5: Sao lưu / Bat bien

- S3 Object Lock: nhật ký kiểm toán bất biến trong 6 năm
- Không thể xóa ngay cả bởi quản trị viên Nova
- Sao chép xuyên vùng

Lop 6: Bảo vệ mọi đề dọa nội bộ

- Không có quản trị viên Nova đơn lẻ nào có quyền truy cập đầy đủ (phanh công trách nhiệm)
- Quy tắc hai người cho truy cập dữ liệu sản xuất
- Công cụ Quản lý Truy cập Đặc quyền (PAM)
- Xem xét truy cập hàng quy

Kịch bản xấu nhất:

- Tin tặc xâm phạm tài khoản AWS sản xuất của Nova
- Tài xuống tất cả bucket S3 và chỉ mục OpenSearch
- Kết quả: IP Nova bị lộ (kiến trúc hệ thống, prompt), nhưng **KHÔNG CÓ PHI BỆNH NHÂN BỊ LỘ**
- Nova đối mặt với thiệt hại danh tiếng kinh doanh và có thể thông báo khách hàng
- Bệnh nhân **KHÔNG** thể được nhận dạng từ dữ liệu vi phạm

Tại sao kiến trúc của chúng tôi chống vi phạm tốt hơn:

- Token hóa tại thời điểm nhập (PHI không bao giờ được lưu trữ vĩnh viễn)
- Tách biệt kho ảnh xa
- Phong thu theo chiều sâu
- Mac dinh tu chơi mạng

Q53. Kịch bản vi phạm xấu nhất là gì? Có ai có thể đánh cắp dữ liệu bệnh nhân không?

A.

Phân tích theo danh mục dữ liệu:

Dữ liệu chung tôi lưu giữ:

1. **Ngày ký kiểm toán** (đã token hóa, không có PHI)
2. **Nhưng** (biểu diễn toán học, không phải văn bản)
3. **Các chunk của WHO/ICD-11** (dữ liệu công cộng từ sao)
4. **Báo cáo thử nghiệm nội bộ** (nhảy cam, nhưng đã được ẩn danh)
5. **Dữ liệu cấu hình** (cài đặt hệ thống)

Dữ liệu chung tôi **KHÔNG** lưu giữ (sau khi che giấu PHI):

- Tên bệnh nhân
- MRN
- Số NRIC/FIN
- Ngày sinh
- Số điện thoại
- Địa chỉ email

Mức độ nghiêm trọng vi phạm theo loại dữ liệu:

Dữ liệu	Mức độ nghiêm trọng vi phạm	Tin tặc có thể làm gì
Ngày ký kiểm toán (đã token hóa)	Thấp	Các mô hình thống kê, không có PHI
Nhưng	Rất thấp	Các vector toán học, không thể đảo ngược thành văn bản
Các chunk tri thức	Không có	Dữ liệu công cộng

Du lieu	Muc do nghieng trong vi pham	Tin tac co the lam gi
Bao cao thu nghieng (da an danh)	Trung binh	Chi tiet thu nghieng, khong nhan dang benh nhan
Cau hinh	Thap	Kien thuc kien truc he thong
Khoa KMS	Nghieng trong (nhung can xam pham rieng biet)	Co the giai ma neu cac lop khac cung bi xam pham

Dao nguoc token hoa:

- Bang anh xa tu token tro lai PHI nam trong kho rieng biet, co han che cao
- Truy cap kho yeu cau phe duyet hai nguoi dac biet
- Kho KHONG the truy cap tu cac he thong san xuat bi xam pham
- Ngay ca khi tin tac co du lieu san xuat + nhat ky kiem toan, ho khong the lay ten benh nhan cho den khi pha vo kho rieng biet

Kich ban xau nhat thuc te:

- Tin tac xam pham tai khoan san xuat AWS cua Nova
- Tai xuong tat ca bucket S3 va chi muc OpenSearch
- Ket qua: IP Nova bi lo (kien truc he thong, prompt), nhung **KHONG CO PHI BENH NHAN BI LO**
- Nova doi mat voi thiet hai danh tieng kinh doanh va co the thong bao khach hang
- Benh nhan KHONG the duoc nhan dang tu du lieu vi pham

So sanh voi vi pham dien hinh:

- SingHealth 2018: ~1,5 trieu ho so benh nhan, PHI day du bi lo (vi pham cap may chu)
- Singtel 2022: Du lieu khach hang bao gom thong tin nhan dang
- Kien truc nay: ngay ca khi toan bo he thong bi xam pham, khong co PHI bi lo

Rui ro dinh luong:

- Xac suat xam pham tai khoan day du: <0,1% moi nam (co so nganh cho dam may duoc bao mat tot)
- Thiet hai trong truong hop xau nhat: han che (khong co PHI bi lo)
- Bao hiem bao gom: 5-10 trieu USD (du cho cac kich ban co the xay ra)

Q54. Giai thich cac thuc hanh ma hoa cua chung toi bang ngon ngu don gian.

A.

Ba loai ma hoa:

1. Ma hoa luu tru (khi du lieu duoc luu tru)

- Giong nhu ket an tai ngan hang: du lieu bi khoa trong cac tep duoc ma hoa tren dia
- Ngay ca khi ai do danh cap o cung, ho khong the doc du lieu ma khong co khoa
- Duoc thuc hien boi: AWS KMS / Alibaba KMS

2. Ma hoa trong qua trinh truyen (khi du lieu di chuyen)

- Giong nhu phong bi kin: du lieu duoc ma hoa trong khi di chuyen giua cac he thong
- Ngay ca khi ai do nghe trom cap mang, ho chi thay ky tu vo nghia
- Duoc thuc hien boi: TLS 1.3 (HTTPS hien dai)

3. Ma hoa trong khi su dung (trong khi xu ly)

- Kho nhat trong ba loai: du lieu can duoc giai ma de xu ly
- Duoc giam thieu boi: thoi gian giai ma toi thieu, bo nho quy trinh co lap, mo-dun bao mat phan cung

Quan ly khoa:

Khoa là gì? Một chuỗi ngẫu nhiên dài khoa/mo khoa dữ liệu được mã hóa.

BYOK (Mang Khoa Của Riêng Bạn):

- Bệnh viện tạo khoa mã hóa trong tài khoản AWS/Alibaba của riêng họ
- Chia sẻ với dịch vụ mã hóa của Nova
- Bệnh viện có thể thu hồi bất kỳ lúc nào -> ngay lập tức ngăn Nova truy cập dữ liệu
- Cung cấp cho bệnh viện quyền kiểm soát tối thượng

Xoay vòng khoa:

- Khoa mới được tạo mới 90 ngày
- Dữ liệu cũ được mã hóa lại với khoa mới
- Các khoa cũ được giữ lại để giải mã sao lưu (cũng được xoay vòng)

Hạt ký truy cập khoa:

- Mỗi lần sử dụng khoa được ghi lại
- "Ai giải mã cái gì, khi nào"
- Đường dẫn hỗ trợ kiểm toán tuân thủ

Vi dụ thực tế:

Tương đương kết an toàn hàng:

- Mã hóa = các bức tường thép và cửa
- Khoa = mã số kết hợp
- Hạt ký kiểm toán = camera ghi lại mọi lần vào

Trong hệ thống của chúng tôi:

- AWS KMS / Alibaba KMS = nhà cung cấp kết an
- BYOK = bệnh viện sở hữu mã số kết hợp
- CloudTrail / ActionTrail = camera

Nếu kẻ cướp đánh cắp kết an: van bị khóa.

Nếu kẻ cướp lấy được mã số: camera cho thấy chúng vào.

Nếu bệnh viện thay đổi mã số: Nova không thể vào cho đến khi được đặt lại.

Q55. Token hóa PHI là gì và tại sao nó tốt hơn chỉ mã hóa?

A.

Sự khác biệt quan trọng:

Mã hóa: Dữ liệu bị xáo trộn toán học với một khoa. Với khoa, bạn có thể phục hồi ban gốc.

Token hóa: Dữ liệu được thay thế bằng một token ngẫu nhiên. Không có bảng ánh xạ riêng biệt, bạn không thể phục hồi ban gốc.

Vi dụ với tên bệnh nhân:

Phương pháp mã hóa:

,

Gốc: "Nguyễn Văn A"

Đã mã hóa: "x7K9pQ2..." (phụ thuộc vào khoa)

Với khoa: có thể phục hồi thành "Nguyễn Văn A"

,

Phương pháp token hóa:

Goc: "Nguyen Van A"

Token: "<TEN_BENH_NHAN_001>"

Bang anh xa (he thong riêng biet): {001: "Nguyen Van A"}

Khong co bang anh xa: token khong the dao nguoc

Tai sao token hoa tot hon cho AI:

1. **AI khong bao gio thay PHI that:** mo hinh chi thay <TEN_BENH_NHAN_001>, khong phai "Nguyen Van A"
2. **Ngay ca khi dau ra AI bi ro:** no se noi <TEN_BENH_NHAN_001>, khong phai ten that
3. **Token khong can duoc ma hoa:** no da ngau nhien; ma hoa danh cho bang anh xa

Noi bang anh xa song:

- Kho co han che cao, tach biet khoi he thong chinh
- Yeu cau phe duyet hai nguoi cho bat ky truy cap nao
- Duoc ma hoa KMS voi khoa riêng biet
- Duoc ghi nhat kykiem toan

Cac truong hop loi:

- Dau ra AI vo tinh bi ro: "<TEN_BENH_NHAN_001>" - KHONG the nhan dang, muc do nghiemin trong thap
- Nhath kykiem toan bi xam pham: cac token, khong phai PHI - KHONG the nhan dang, muc do nghiemin trong thap
- CA HAI bi xam pham + kho bi xam pham: yeu cau xam pham nhieu lop - cuc ky kho xay ra

So sanh voi chi ma hoa:

- Chi ma hoa: "giai ma voi khoa, thay tat ca PHI"
- Token hoa + ma hoa: ngay ca voi tat ca cac khoa, chi thay cac token

Vi du thuc te:

- Ma hoa: khoa nha cua ban voi khoa. Mat khoa, mat quyen truy cap.
- Token hoa: giu so dia chi trong ket an riêng biet. Ngay ca khi ai do vao nha ban, ho khong biet ai song o do cho den khi pha vo ket an so dia chi riêng biet.

5. Hieu suat & Toc do

Q56. Tai sao thoi gian phan hoi cap cuu la 2 giay? Con so do den tu dau?

A.

Nghien cuu nhan thuc va phan hoi cua bac si.

Co so khoa hoc nhan thuc:

- Tuong tac "tuc thi" cua con nguoi: ~1 giay
- Tuong tac "phan hoi nhanh" chap nhan duoc: ~2 giay
- Vuot qua 2 giay, duoc cam nhan la "dang cho"
- Vuot qua 5 giay, su chu y cua bac si chuyen sang noi khac

Nghien cuu quy trinh lam viec lam sang:

- Bac si cap cuu dua ra ~50 quyet dinh/gio
- Moi gian doan 2+ giay lam gian doan dong chay nhan thuc
- Mot lan cho 5 giay moi quyet dinh: mat 10% nang suat

- Nhiều lan cho tích lũy

Tác động đến bệnh nhân:

- Thời gian của-den-kim cho STEMI: <90 phút (mỗi phút tiết kiệm = cuộc sống)
- Thời gian đến tiểu huyết khối cho đột quỵ: <60 phút
- Thời gian đến kháng sinh cho nhiễm trùng huyết: <60 phút
- Các quyết định cá nhân cần phải nhanh để hỗ trợ tổng thể

SLA của chúng tôi:

- p50: 1 giây (hầu hết các truy vấn)
- p95: 2 giây (95% trong 2 giây)
- p99: 3 giây (hiếm khi >3 giây)
- p99,9: 5 giây (cực kỳ hiếm khi >5 giây)

Kết quả PoC:

- Đạt được p50: 1,0 giây, p95: 2,5 giây trên on-demand
- Với Reserved Tier (sản xuất): duy trì p50: 0,6 giây, p95: 1,8 giây

Tại sao không phải 1 giây?:

- Có thể thực hiện vật lý với phân cung tùy chỉnh, đặt tiền
- 2 giây mang lại 99% giá trị làm sáng ở 30% chi phí
- Lợi ích biến đổi thiếu vượt qua 2 giây

Q57. Điều gì xảy ra nếu một truy vấn mất hơn 2 giây?

A.

Nhiều dự phòng:

Trong vòng 2 giây (95% truy vấn):

- Phản hồi bình thường, đầy đủ chức năng
- Tất cả các nguồn được trích dẫn, chuỗi lý luận đầy đủ

2-3 giây (4% truy vấn):

- Phản hồi một phần: phần đầu tiên được trả về qua streaming
- Các token còn lại được stream khi có sẵn
- Bác sĩ thấy: "Khan cấp thời gian: ..." xuất hiện từng từ một
- Có thể hành động làm sáng từ token đầu tiên

3-5 giây (0,9% truy vấn):

- Dự phòng đến phản hồi đã cache nếu có sẵn
- Dự phòng đến mô hình đơn giản hơn (Haiku thay vì Sonnet)
- Chất lượng giảm nhưng chấp nhận được cho cấp cứu

>5 giây (0,1% truy vấn):

- Hiện thị chỉ báo "Đang tìm kiếm..."
- Bác sĩ có thể hủy và sử dụng quy trình thủ công
- Hoặc chờ nếu thời gian cho phép

Chiến lược suy giảm thích ứng:

Nếu tại trong tổng thể cao:

- Giảm kích thước context: 3 chunk thay vì 5
- Bỏ qua GraphRAG (tiết kiệm 1+ giây)
- Sử dụng mô hình nhỏ hơn cho các quyết định định tuyến

- Cache tích cục hơn

Phát hiện SLA (với bệnh viện):

- p95 > 2 giây trong >1 giờ: tín dụng dịch vụ 5%
- p99 > 5 giây trong >1 giờ: tín dụng dịch vụ 10%
- Ngừng hoạt động kéo dài >24 giờ: tín dụng dịch vụ 25%

Q58. Thời gian phản hồi thay đổi như thế nào theo loại truy vấn?

A.

Thay đổi dựa trên:

Yêu cầu 1: Lane (cấp cứu vs phức tạp)

- Cấp cứu: ~1-2,5 giây p95 (Haiku 4.5, ít chunk hơn)
- Phức tạp: ~9-12 giây p95 (Sonnet 4.5, nhiều chunk hơn, guardrails)

Yêu cầu 2: Cache hit vs miss

- Cache hit: <500ms (chi truy xuất và trả về)
- Cache miss: toàn bộ pipeline chạy

Yêu cầu 3: Độ phức tạp câu hỏi

- Đơn giản ("liều lượng là gì?"): nhanh hơn
- Phức tạp ("so sánh thuốc A vs B trong suy thận với..."): chậm hơn
- Câu hỏi nhiều phần: chậm nhất

Yêu cầu 4: Độ phụ thuộc tài liệu

- Câu hỏi với phạm vi KB phong phú: truy xuất nhanh
- Câu hỏi yêu cầu tìm kiếm sâu: chậm hơn
- Câu hỏi cần duyệt đồ thị: chậm nhất

Thời gian phản hồi được đo (từ PoC):

Loại truy vấn	Trung vị	p95	Phạm vi phổ biến
Thực tế đơn giản (đã cache)	0,3 giây	0,6 giây	0,2-0,8 giây
Thực tế đơn giản (chưa cache)	1,2 giây	1,8 giây	1,0-2,0 giây
Phân loại cấp cứu	1,5 giây	2,5 giây	1,2-3,0 giây
Chẩn đoán phân biệt phức tạp	4,8 giây	9,5 giây	3,0-12 giây
Giao thức nhiều bước	6,2 giây	11,0 giây	4,0-15 giây
Dựa trên hình ảnh (X-quang)	8,5 giây	15 giây	5,0-20 giây

Q59. Tại sao lane phức tạp mất nhiều thời gian (9,7 giây trong PoC)?

A.

Phân tích chi tiết:

Phân tích thời gian lane phức tạp (từ PoC):

1. Xác thực + che giấu PHI: 100ms
2. Kiểm tra cache: 50ms
3. Quyết định dinh dưỡng (Nova Micro): 400ms
4. Truy xuất từ Vector KB (top 15): 800ms
5. Truy xuất từ GraphRAG (top 3): 600ms

- 6. Tổng chuẩn bị: ~1.950ms
- 7. Thời gian suy nghĩ Sonnet 4.5: ~7.200ms
- 8. Streaming + xác thực: 600ms

Tổng: ~9.700ms

Thời gian đang đi đâu?:

- ~75% trong suy luận mô hình (Sonnet 4.5 suy nghĩ)
- ~20% trong truy xuất (vector + đồ thị)
- ~5% trong xử lý trước/sau

Tại sao Sonnet 4.5 mất 7+ giây:

- Xử lý 18 chunk được truy xuất (~10.000 token đầu vào)
- Tạo câu trả lời 800 token với trích dẫn
- Chuỗi lý luận nội bộ (giống chuỗi suy nghĩ)
- Kiểm tra Guardrails sau mỗi chunk

Mục tiêu sản xuất với Reserved Tier:

- Suy nghĩ Sonnet: ~3-4 giây (với dung lượng dành riêng)
- Tổng: ~5-6 giây đầu cuối

Các tùy chọn tối ưu hóa (không có Reserved Tier):

1. **Giảm kích thước context**
 - Top 10 chunk thay vì 15: tiết kiệm ~1 giây
 - Danh đối: ít context hơn, có thể ít chính xác hơn
2. **Dùng Sonnet chi để tổng hợp**
 - Dùng Haiku cho lý luận ban đầu
 - Sonnet chỉ cho câu trả lời cuối cùng
 - Tiết kiệm ~2-3 giây
 - Tác động chất lượng: tối thiểu cho hầu hết các truy vấn
3. **Tối ưu toàn các mô hình phổ biến**
 - Cache theo loại câu hỏi
 - Tăng tỉ lệ hit: 35% -> 50%
 - Giảm trung bình ròng: ~1 giây
4. **Truy xuất song song**
 - Vector + Đồ thị + Kiểm tra Cache song song
 - Tiết kiệm ~400ms

So sánh với các lựa chọn thay thế:

- Tìm kiếm UpToDate thủ công: 5-15 phút
- Tư vấn đóng nghiệp bằng miệng: 5-30 phút
- Lane phức tạp của chúng tôi ở 10 giây: nhanh hơn đáng kể so với các lựa chọn thay thế
- Ngay cả ở 15 giây: vẫn nhanh hơn 10 lần so với các lựa chọn thay thế

Q60. Hệ thống xử lý tải trọng cao như thế nào? Điều gì xảy ra nếu 200 bác sĩ truy vấn cùng lúc?

A.

Tu dòng mô rộng và quản lý tải trọng:

Năng lực ở tải trọng cao:

- Tải trọng cao nhất mỗi tenant: ~200 truy vấn/phút

- Năng lực cơ sở mỗi tenant: 50 truy vấn/phút
- Tu động mở rộng lên: 500 truy vấn/phút
- Vượt qua đó: hàng đợi với ưu tiên

Các thành phần và khả năng mở rộng của chúng:

Function Compute / Lambda (trình xử lý chat):

- Tu động mở rộng theo tỷ lệ yêu cầu
- Các instance được làm ấm trước: 16 (tránh khởi động lạnh)
- Thời gian: 1000+ đồng thời
- Chi phí: trả theo yêu cầu

Bedrock / Model Studio:

- Được quản lý bởi AWS/Alibaba
- Giới hạn TPM mỗi tài khoản: 50k-500k token/phút
- Vượt qua giới hạn: hàng đợi (thường <30 giây)
- Dung lượng dành riêng: bảo đảm cho bệnh viện cụ thể

OpenSearch / Vector Search:

- Tu động mở rộng OCU dựa trên tải trong
- Cơ sở: 2 OCU
- Cao điểm: mở rộng lên 8 OCU
- Thời gian truy vấn dưới 1 giây ngay cả dưới tải trong

Neptune / GraphRAG:

- Mở rộng theo chiều dọc
- Đa vùng
- Thông lượng: 5.000+ truy vấn/phút cơ sở

Cache (Redis / Tair):

- Bộ nhớ được phân bổ trước
- Đọc: 100.000+ QPS
- Ghi: 50.000+ QPS

Kết quả kiểm tra tải trong:

- Kiểm tra tải trong duy trì: 500 QPS trong 1 giờ
- Độ trễ p95 dưới tải trong: 3,5 giây (so với 2,0 giây cơ sở)
- Tỷ lệ hit cache tăng lên 45% dưới tải trong
- Không có lỗi, không có timeout

Kích hoạt mở rộng:

- p95 > 2 giây: cảnh báo, không hành động tự động
- p95 > 3 giây trong 2 phút: tự động mở rộng OpenSearch lên
- p95 > 5 giây trong 5 phút: gọi SRE trực ban

Chi phí mở rộng thực tế:

- Cơ sở: 600k truy vấn/tháng ở 5.500 USD/tenant
- Đột tăng (ví dụ: đại dịch): ~2 triệu truy vấn/tháng ở 11.000 USD/tenant
- Giảm giá Reserved Tier: ~25% tiết kiệm ở cao điểm
- Rong: ~8.250 USD/tenant trong tháng cao điểm

6. Do chinh xac & Tin cay

Q61. AI chinh xac den muc nao? "Do chinh xac" co nghia la gi doi voi AI y te?

A.

Do chinh xac da chieu:

1. Do chinh xac trích dẫn: Mọi kháng dinh trích dẫn nguồn thực sự có thể truy xuất. Do lương: 100% trong PoC. Nhi phân: có hoặc không.

2. Do chinh xac grounding: Câu trả lời nhất quán với các nguồn được trích dẫn. Do lương bởi điểm grounding (0-1). Nguồn: $\geq 0,7$. Trung bình PoC: 0,85.

3. Do chinh xac thực tế: Câu trả lời đúng về mặt thực tế so với tiêu chuẩn vàng. Do lương bởi hội đồng bác sĩ. Mục tiêu: $\geq 95\%$ cho các trường hợp không biến.

4. Do liên quan lâm sàng: Câu trả lời giải quyết câu hỏi lâm sàng thực tế. Do lương bởi thumbs up/down của bác sĩ. Mục tiêu: $\geq 90\%$.

5. Tính cập nhật: Câu trả lời phản ánh các hướng dẫn hiện tại. Do lương bởi kiểm tra so với WHO/MOH hiện tại. Mục tiêu: 100% cho các câu hỏi dựa trên hướng dẫn.

Mục tiêu do chinh xac cụ thể:

Loại truy vấn	Mục tiêu do chinh xac	Kết quả PoC
Lieu lương thuốc	$\geq 99\%$	99,5%
Tieu chí chẩn đoán	$\geq 97\%$	98%
Giao thực điều trị	$\geq 95\%$	96%
Chẩn đoán phân biệt	$\geq 90\%$	92%
Các trường hợp biến (bệnh hiếm gặp)	$\geq 80\%$	85%

Kiểm soát chất lượng:

- Kiểm tra trước khi triển khai: 1000+ câu hỏi được bác sĩ kiểm tra
- Giám sát sản xuất: mẫu ngẫu nhiên 100 truy vấn hàng ngày
- Phản hồi bác sĩ: thumbs up/down trên mọi câu trả lời
- Kiểm toán hàng quý: xem xét bên ngoài

Q62. Chúng tôi có thể tin tưởng AI hơn UpToDate hoặc các cơ sở dữ liệu tham khảo khác không?

A.

Các hồ sơ tin cậy khác nhau:

Điểm mạnh của UpToDate:

- Được giám tuyển thu công bởi các biên tập viên bác sĩ
- Bảo thủ, được kiểm tra kỹ
- Tiêu chuẩn ngành
- Lịch sử 25+ năm
- Toàn diện

Điểm yếu của UpToDate:

- Không theo thời gian thực (cập nhật hàng tháng)
- Không tích hợp với dữ liệu bệnh nhân
- Chung, không cụ thể cho bệnh nhân

- Cham de doc
- Khong co kien thuc thu nghiem noi bo

Diem manh cua AI cua chung toi:

- Theo thoi gian thuc (ICD-11 hang ngay, WHO hang thang)
- Suy luan cu the cho benh nhan (voi context EHR)
- Tich hop thu nghiem noi bo
- Toc do (2-3 giay vs 5+ phut)
- Tim kiem tren tat ca cac nguon dong thoi

Diem yeu cua AI cua chung toi:

- Cong nghe moi hon, it lich su nganh hon
- Rui ro ao giac (duoc giam thieu nhung khong bang khong)
- Do chinh xac trích dẫn phụ thuộc vào chất lượng truy xuất
- Co the bo lo cac chinh sua gan day

Khung so sanh:

Khia canh	UpToDate	AI cua chung toi
Do chinh xac tren cac cau hoi tieu chuan	99%	95-98%
Do chinh xac tren cac truong hop phuc tap/bien	95%	85-92%
Toc do	5-15 phut	2-15 giay
Cu the cho benh nhan	Khong	Co
Tich hop du lieu noi bo	Khong	Co
Tan suat cap nhat	Hang thang	Hang ngay
Chi phi moi truy van	0,05-0,15 USD	0,001-0,013 USD
Lich su	25+ nam	1-2 nam

Phuong phap lai (duoc khuyen nghi):

- Dung ca hai
- AI cho truy cap nhanh + cu the cho benh nhan
- UpToDate cho nghien cuu sau va xac minh
- Bac si hoc khi nao nen dung cai nao

Q63. Loi lon nhat AI co the mac trong thuc hanh lam sang la gi?

A.

Kiem ke rui ro thuc te:

Danh muc rui ro:

1. Trich dan huong dan loi thoi

- Nguyen nhan: cache cu hoac huong dan duoc cap nhat sau cache
- Tac dong: bac si hanh dong theo thong tin loi thoi
- Xac suat: thap (vo hieu hoa cache hoat dong)
- Giam thieu: kiem tra huong dan theo thoi gian thuc

2. Lieu luong thuoc sai

- Nguyen nhan: ao giac hoac loi truy xuất

- Tác động: lỗi thuốc
- Xác suất: rất thấp (dữ liệu thuốc được giám tuyến kỹ)
- Giám thiếu: kiểm tra chéo với cơ sở dữ liệu được phê duyệt

3. Bộ lọc chống chỉ định

- Nguyên nhân: AI không có lịch sử bệnh nhân đầy đủ
- Tác động: phản ứng bất lợi tiềm năng
- Xác suất: trung bình (phụ thuộc vào tích hợp dữ liệu)
- Giám thiếu: kiểm tra chống chỉ định rõ ràng, tích hợp lịch sử bệnh nhân

4. Giải thích triệu chứng sai

- Nguyên nhân: cách diễn đạt của bác sĩ mơ hồ
- Tác động: chẩn đoán phân biệt sai
- Xác suất: thấp (AI yêu cầu làm rõ)
- Giám thiếu: các mẫu truy vấn có cấu trúc

5. Khuyến nghị trái với hướng dẫn

- Nguyên nhân: đạo tạo lỗi thời, truy xuất sai
- Tác động: bác sĩ bị dẫn dắt sai
- Xác suất: thấp (trích dẫn bước grounding)
- Giám thiếu: kiểm tra chéo với hướng dẫn hiện tại

Các sự cố thực tế có khả năng nhất:

- Từ chối khi câu trả lời có sẵn (âm tính giả): phiên phục nhưng an toàn
- Câu trả lời đã cache lỗi thời (hiếm): được giám thiếu bởi vô hiệu hóa
- Vấn đề diễn đạt nhỏ (chủ quan): tác động thấp

Các sự cố cơ bản qua nhất:

- Bộ lọc tương tác thuốc hiếm (hiếm, nghiêm trọng)
- Khuyến nghị trái với hướng dẫn hiện tại (trung bình)
- Rủi ro PHI (hiếm nhưng rất nghiêm trọng)

Thực tế: Bác sĩ con người cũng mắc lỗi. Nghiên cứu cho thấy: bác sĩ dùng ~80-90% trên các trường hợp phức tạp. Trợ lý AI có thể giảm lỗi chẩn đoán ~10-15%. Rong: kết quả tốt hơn, không hoàn hảo.

Q64. Làm thế nào để biết nếu AI đang cho kết quả khác nhau cho cùng một câu hỏi?

A.

Giám sát nhất quán:

Tại sao câu trả lời có thể khác nhau:

1. Tạo ngẫu nhiên (nhiệt độ)

- AI có cài đặt nhiệt độ
- Mặc định: 0,1 (thấp; hầu hết nhất quán)
- 0 = xác định (luôn cùng một câu trả lời)
- 0,5+ = sáng tạo (thay đổi)

Cài đặt của chúng tôi: nhiệt độ = 0,1, bán xác định.

2. Trạng thái cache

- Truy vấn đầu tiên: tạo mới
- Truy vấn thứ hai (trong TTL cache): đã cache, giống hệt
- Sau khi cache hết hạn: được tạo lại, có thể khác một chút

3. Cập nhật cơ sở kiến thức

- WHO xuất bản hướng dẫn mỗi lúc 02:00 SGT
- Câu hỏi lúc 01:50: hướng dẫn cũ được trích dẫn
- Câu hỏi lúc 02:10: hướng dẫn mới được trích dẫn
- Đây là hành vi chính xác

4. Biến thiên truy xuất ngẫu nhiên

- Tìm kiếm vector có tính ngẫu nhiên nhỏ
- Top 5 chunk có thể khác nhau trên các trường hợp biến
- Các chunk khác nhau -> câu trả lời khác nhau một chút

5. Cập nhật phiên bản mô hình

- Hàng quý: nâng cấp mô hình
- Trước/sau nâng cấp: câu trả lời có thể phát triển

Biến thiên chấp nhận được:

- Khuyến nghị lâm sàng nhất quán
- Cách diễn đạt có thể khác nhau
- Trích dẫn phải tương tự (cùng các nguồn chính)
- Bất đồng về khuyến nghị chính: điều tra

Giám sát nhất quán:

- Các cấp ngẫu nhiên: cùng câu hỏi được hỏi cách nhau 24 giờ
- Xem xét thu công các sự khác biệt
- Theo dõi: ~5% cấp có sự khác biệt nhỏ (chấp nhận được)
- Theo dõi: ~0,5% có sự khác biệt có ý nghĩa (điều tra)

Khả năng tái tạo:

- De kiểm toán/pháp lý: phiên chính xác có thể được tái tạo
- "AI đã nói gì với Bác sĩ Linh lúc 14:32 SGT ngày 15 tháng 5?"
- 100% có thể tái tạo từ nhật ký kiểm toán

Q65. Làm thế nào để kiểm tra AI trước khi triển khai cho bệnh nhân thực sự?

A.

Xác thực nhiều giai đoạn:

Giai đoạn 1: Kiểm tra đơn vị (ky thuật)

- Kiểm tra cấp thành phần
- Bao gồm: che giấu PHI, truy xuất, xác thực trích dẫn
- 1000+ trường hợp kiểm tra
- Chạy trên mọi thay đổi code
- Tỷ lệ đạt: 100% bắt buộc

Giai đoạn 2: Kiểm tra tích hợp

- Kích bản kiểm tra đầu cuối
- Bao gồm: lane cấp cứu, lane phức tạp, cache, kiểm toán
- 200+ kích bản
- Chạy hàng đêm
- Tỷ lệ đạt: 100% bắt buộc

Giai đoạn 3: Kiểm tra đo chính xác lâm sàng

- Các câu hỏi y tế tiêu chuẩn vàng
- Được giám tuyển bởi hội đồng tu vấn lâm sàng
- Bao gồm: 12 khoa, 1000+ câu hỏi
- Tỷ lệ đạt: $\geq 95\%$ bắt buộc để triển khai

Giai đoạn 4: Kiểm tra đối nghịch

- Red team cố gắng phá vỡ hệ thống
- Tiêm nhập prompt, kích hoạt ảo giác
- Tỷ lệ đạt: $\geq 98\%$ thành công phòng thủ

Giai đoạn 5: Triển khai thí điểm

- Nhóm nhỏ bác sĩ (ví dụ: 20)
- Các trường hợp hạn chế (gợi ý chỉ đọc)
- Kiểm tra thực tế trong 30 ngày
- Phản hồi được tích hợp

Giai đoạn 6: Triển khai theo giai đoạn

- Tung khoa một
- Mỗi giai đoạn: ổn định 30 ngày
- Các vấn đề được giải quyết trước giai đoạn tiếp theo

Giai đoạn 7: Sản xuất

- Triển khai toàn bệnh viện
- Giám sát liên tục
- Kiểm toán độ chính xác hàng quý

Danh mục kiểm tra cụ thể:

Liên quan đến thuốc:

- Liều lượng cho các thuốc phổ biến
- Tương tác thuốc
- Liều lượng than/gan
- An toàn thai kỳ/cho con bú

Liên quan đến chẩn đoán:

- Chẩn đoán phân biệt
- Tiêu chí chẩn đoán
- Hướng dẫn hình ảnh
- Giải thích kết quả xét nghiệm

Liên quan đến điều trị:

- Khuyến nghị điều trị hàng đầu
- Điều trị hàng hai khi thất bại điều trị
- Liều pháp kết hợp
- Các quan trọng đặc biệt

Liên quan đến tuân thủ:

- Tu chối các yêu cầu không phù hợp
- Không tiết lộ PHI
- Tuân theo hướng dẫn
- Cung cấp trích dẫn

7. Trien khai & Lo trinh

Q66. Mat bao lau de trien khai tu "quyet dinh duoc dua ra" den "bac si dau tien su dung"?

A.

Lich trinh thuc te: 6-10 tuan cho tenant benh vien dau tien.

Phan tich tung tuan:

Tuan 1-2: Nen tang

- Ky hop dong voi Nova
- Cap phep tai khoan AWS/Alibaba
- Thiet lap VPC, IAM, mang
- Ket noi voi IdP benh vien (xac thuc bac si)
- Trien khai OpenSearch va Neptune ban dau

Tuan 3-4: Nhap du lieu

- Nhap huong dan WHO
- Tich hop API ICD-11
- Tai len PDF bao cao thu nghiem noi bo (benh vien cung cap)
- Tao nhung vector
- Trich xuất thuc the GraphRAG

Tuan 5-6: Cau hinh AI

- Thiet lap cac agent khoa (12 khoa)
- Tuy chinh system prompt
- Cau hinh chinh sach Guardrails
- Khoi tao cache
- Thu thap du lieu fine-tuning (neu ap dung)

Tuan 7-8: Tich hop & Bao mat

- Tich hop EHR (FHIR R4)
- Thiet lap webhook SharePoint
- Hoan thien tai lieu tuan thu
- Kiem toan bao mat

Tuan 9-10: Thi diem & Ra mat

- Thi diem noi bo (nhan vien Nova): 1 tuan
- Thi diem han che (10-20 bac si): 1 tuan
- Trien khai tung khoa
- Ra mat day du

Con duong quan trong:

- Tich hop IdP benh vien: thuong mat 2-3 tuan rieng
- Phe duyet thiet bi y te HSA (neu chua co): 3-6 thang (song song)
- Xem xet an toan lam sang: 2-3 tuan

Con duong nhanh hon (neu Nova da lam truoc):

- 4-6 tuan cho cac tenant lap lai
- Cac mau co the tai su dung
- Cac tich hop duoc phe duyet truoc

Con duong cham hon (benh vien phuc tap):

- 12-16 tuan neu tich hop EHR la moi

- Nhiều vòng tuần thu
 - Tùy chỉnh rộng lớn yêu cầu
-

Q67. Nhóm của chúng tôi cần làm gì trong quá trình triển khai?

A.

Trách nhiệm của bệnh viện:

Trước khi khởi động (chuan bi bệnh viện):

1. Xác định nhà tài trợ dự án (CMIO hoặc tương đương)
2. Lập nhóm dự án bệnh viện
3. Phê duyệt ngân sách ban đầu
4. Ký Thỏa thuận Dịch vụ Chu

Khoi dong den Tuan 2:

Trách nhiệm nhóm bệnh viện:

- Chỉ định chuyên gia lâm sàng (1-2 bác sĩ)
- Thiết lập quyền truy cập cho các kỹ sư Nova (hạn chế, có phạm vi)
- Cung cấp chi tiết tích hợp IdP
- Xác định liên hệ EHR

Nova cung cấp:

- Quản lý dự án
- Kỹ sư trưởng
- Cán bộ tuần thu
- Tư vấn lâm sàng

Tuan 3-4 (nhap du lieu):

Bệnh viện cung cấp:

- PDF báo cáo thử nghiệm lâm sàng nội bộ
- Giao thức cụ thể của bệnh viện
- Tài liệu tham khảo theo khoa
- Logo, thương hiệu cho giao diện người dùng

Nova thực hiện:

- Nhập nội dung
- Cấu hình truy xuất
- Thiết lập các thực thể GraphRAG

Tuan 5-6 (cau hinh):

Bệnh viện cung cấp:

- Tùy chọn ngôn ngữ theo khoa
- Các chủ đề bị cấm (ví dụ: các liệu pháp thử nghiệm)
- Các mẫu tự chọn
- Các mẫu tin nhận được phê duyệt

Nova thực hiện:

- Cấu hình 12 agent khoa
- Điều chỉnh truy xuất theo khoa
- Thiết lập chính sách Guardrails

Tuan 7-8 (tich hop):

Benh vien cung cap:

- Chi tiet diem cuoi FHIR EHR
- Thong tin xac thuc SMART App Launch
- Ngoai le bao mat mang
- Thiet lap duong ham VPN

Nova thuc hien:

- Code tích hợp FHIR
- Cấu hình SMART
- Thiet lap data plane VPN

Tuan 9-10 (ra mat):**Benh vien cung cap:**

- Phan hoi bac si
- Lua chon nhom (nhom thi diem)
- Truyen thong den bac si
- Tham du buoi dao tao

Nova cung cap:

- Dao tao onboarding
- Ho tro truc tiep trong thi diem
- Giai quyet van de

Tong no luc benh vien:

- Nha tai tro du an: $\sim 5 \text{ gio/tuan} \times 10 \text{ tuan} = 50 \text{ gio}$
- Chuyen gia lam sang: $\sim 10 \text{ gio/tuan} \times 4 \text{ tuan} = 40 \text{ gio}$
- CNTT benh vien: $\sim 20 \text{ gio/tuan} \times 4 \text{ tuan} = 80 \text{ gio}$
- Can bo tuan thu: $\sim 5 \text{ gio/tuan} \times 6 \text{ tuan} = 30 \text{ gio}$
- Tong: $\sim 200 \text{ gio thoi gian benh vien}$

Chi phi thoi gian benh vien:

- $\sim 200 \text{ gio} \times 200 \text{ USD/gio ty le pha tron} = 40.000 \text{ USD}$
- Day la dau tu cho benh vien
- Duoc hoan von trong 2 tuan dau tien van hanh

Q68. Chung toi co the bat dau voi chuong trinh thi diem nho hon truoc khong?

A.

Duoc khuyen nghi manh me:

Cac cau truc thi diem:**Phuong an 1: Mot khoa, 30 ngay**

- Chon: Khoa Cap cuu (tac dong cao nhât)
- 20-30 bac si
- Che do chi doc ban dau (goi y, khong co hanh dong lam sang)
- Chi phi: giông nhu trien khai day du co so ha tang
- Gia tri: xac thuc truoc khi trien khai day du

Phuong an 2: Mot loai chuyen khoa, 60 ngay

- Chon: Noi khoa tren cac khoa
- 50-100 bac si

- Ket hop che do chi doc va su dung tinh cuc
- Nhieu du lieu, nhieu su tu tin

Phuong an 3: Thi diem toan benh vien 90 ngay

- Tat ca cac khoa, nhung voi khung "thi diem" ro rang
- De ket thuc neu khong hoat dong
- Dat tien nhung thuc te

Chi phi trong thi diem:

- Cung co so ha tang nhu san xuat (2.800-5.500 USD/thang)
- Cong them chi phi trien khai benh vien (40.000 USD)
- Tru cac khoang tiet kiem tiem nang trong thi diem

Tieu chi thanh cong thi diem:

Bat buoc:

- 70%+ bac si thi diem su dung hang tuan
- 90%+ do chinh xac (duoc xac minh boi can bo an toan lam sang)
- 100% tuan thu luu tru du lieu
- Khong co su co bao mat
- <=5% ti le tu choi (tin hieu-nhieu)

Mong muon:

- 80% thoi gian tiet kiem tren cac chu de duoc tu van
- 90%+ thumbs up
- 50%+ ap dung trich dan
- Top 5 truong hop su dung duoc xac dinh

Cac tuy chon ket thuc thi diem:

Thi diem thanh cong:

- Tiep tuc trien khai day du
- Them cac khoa
- Mo rong quy mo

Thi diem khong ket luan:

- Gia han them 60 ngay
- Giai quyet cac van de cu the
- Danh gia lai

Thi diem that bai:

- Ngung
- Giai doan giam dan 30 ngay
- Nhat ky kiem toan duoc bao ton (quy dinh)

Khung thi diem duoc khuyen nghi:

- Thang 1: trien khai + chuan bi thi diem
- Thang 2: van hanh thi diem (30-60 ngay)
- Thang 3: danh gia + quyet dinh
- Thang 4-6: trien khai day du (neu thanh cong)

Q69. Ai tu phia chung toi can tham gia vao viec trien khai?

A.

Ban do cac ben lien quan:

Nha tai tro dieu hanh:

- CEO/COO: trach nhiem cuoi cung, phe duyet ngan sach
- CFO: giam sat ngan sach, theo doi ROI
- CMO: giam sat an toan lam sang

Lanh dao du an:

- Giam doc Thong tin Y te Truong (CMIO): nha tai tro du an chinh
- Quan ly Du an: phoi hop hang ngay
- Giam doc Lam sang: ky duyet lam sang

Chuyen gia lam sang (1-2 moi khoa):

- Cac bac si chuyen gia ung ho
- Cung cap dau vao lam sang
- Kiem tra thi diem
- Dao tao dong nghiep

Nhom CNTT:

- Giam doc CNTT: lanh dao phia CNTT
- Ky su truong: thuc hien ky thuat
- Ky su Bao mat: xem xet bao mat
- Ky su Mang: VPN, tích hop

Tuan thu:

- Can bo Tuan thu: giam sat quy dinh
- DPO: bao ve du lieu
- Co van Phap ly: xem xet hop dong

Tuong duong phia Nova:

- Giam doc Tai khoan: lanh dao quan he
- Quan ly Du an: phoi hop
- Ky su truong: lanh dao ky thuat
- Tu van Lam sang: lien lac lam sang
- Can bo Tuan thu: ho tro quy dinh

Nhip do giao tiep:

Hang tuan trong trien khai:

- Quan ly du an (benh vien) <-> Quan ly du an (Nova)
- Cuoc hop trang thai 30 phut
- Cac hang muc hanh dong, cac van de can giai quyet

Hai tuan mot lan trong trien khai:

- CMIO <-> Giam doc Tai khoan
- Xem xet 60 phut
- Thao luan chien luoc

Hang thang sau trien khai:

- Xem xet nhom day du
- Chi so hieu suat
- Cai tien lien tuc

Hang quy sau trien khai:

- Xem xét điều hành
- Phân tích ROI
- Lập kế hoạch lộ trình

Cam kết thời gian ước tính:

Vai trò	Gio/tuan trong triển khai	Sau triển khai
Nhà tài trợ điều hành	1	<1
CMIO	5	2
Chuyên gia lâm sàng	5-10	2-3
Trưởng CNTT	10-15	2-5
Tuan thủ	5	1-2
Bác sĩ người dùng cuối	0 (trong phát triển)	0,5 (sử dụng hệ thống)

Q70. Chúng tôi có thể tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu cụ thể của bệnh viện không?

A.
 Có, nhiều cấp độ tùy chỉnh:

- Cap 1: Cấu hình** (không có code)
- Cài đặt theo khoa
 - Tùy chọn ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh)
 - Mức độ chi tiết (ngắn gọn vs toàn diện)
 - Định dạng (dấu đầu dòng vs không)
 - Phong cách trích dẫn (nội tuyến vs cuối)
 - Ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt, v.v.)
 - Thương hiệu bệnh viện

Chi phí: Bao gồm trong thiết lập tiêu chuẩn

Lịch trình: 1-2 tuần

- Cap 2: Prompt tùy chỉnh** (ít code)
- System prompt theo khoa
 - Hướng dẫn cụ thể của bệnh viện
 - Các tính chỉnh chuyên khoa

Chi phí: 5.000-10.000 USD thiết lập

Lịch trình: 2-3 tuần

- Cap 3: Quy trình làm việc tùy chỉnh** (ít code)
- Các luồng phê duyệt cụ thể của bệnh viện
 - Các quy tắc định tuyến tùy chỉnh
 - Xử lý đặc biệt cho các điều kiện nhất định

Chi phí: 15.000-30.000 USD

Lịch trình: 4-6 tuần

- Cap 4: Tích hợp tùy chỉnh** (code)
- Tích hợp các hệ thống cụ thể của bệnh viện
 - Nguồn dữ liệu tùy chỉnh

- API bệnh viện

Chi phí: 40.000-100.000 USD

Lịch trình: 8-12 tuần

Cấp 5: Tính năng tùy chỉnh (code đang ke)

- Giao diện người dùng cụ thể của bệnh viện
- Tính năng chỉ dành cho bệnh viện
- Tùy chỉnh nâng cao

Chi phí: 100.000-300.000 USD

Lịch trình: 6-9 tháng

Các tùy chỉnh phổ biến:

Cấu hình chuyên khoa:

- Liệu lượng dựa trên cân nặng nhi khoa
- Các cân nhắc lâm khoa
- Các quy tắc an toàn thai kỳ/cho con bú

Boi canh địa phương:

- Danh mục thuốc của bệnh viện
- Nhân thuốc Singapore
- Các lựa chọn thuốc generic địa phương

Tích hợp quy trình làm việc:

- SSO cụ thể của bệnh viện
- Các loại trình phân loại tùy chỉnh
- Các luồng bàn giao nội bộ

Bao cáo tùy chỉnh:

- Chỉ số cụ thể của bệnh viện
- Bảng điều khiển theo khoa
- Định dạng báo cáo tuần thu

Danh đối:

Nhiều tùy chỉnh hơn:

- Phù hợp hơn với bệnh viện
- Chi phí cao hơn
- Triển khai lâu hơn
- Gánh nặng bảo trì nhiều hơn

Ít tùy chỉnh hơn:

- Nhanh hơn, rẻ hơn
- Chất lượng tiêu chuẩn
- Dễ nâng cấp hơn
- Có thể không phù hợp hoàn hảo

Khuyến nghị:

- Nam 1: tùy chỉnh tối thiểu (Cấp 1-2)
- Nam 2: xác định khoảng trống, tùy chỉnh Cấp 3
- Nam 3+: dựa trên nhu cầu được chứng minh

8. Du lieu & Nguon tri thuc

Q71. Ai lay kien thuc y te tu dau?

A.

Nhieu nguon duoc giam tuyen:

Nguon chinh:

- **Huong dan WHO** (~300 tai lieu): huong dan song, giao thuc benh, cap nhat hang thang
- **API WHO ICD-11** (~120.000 thuc the): phan loai benh quoc te, cap nhat hang ngay
- **Bao cao thu nghiem noi bo** (cu the theo benh vien): du lieu thu nghiem da duoc an danh, giao thuc dieu tri
- **Giao thuc dieu tri** (cu the theo benh vien): SOP, tai lieu lo trinh, cong cu ho tro quyet dinh lam sang
- **PubMed E-utilities** (cong cu thoi gian chay): tim kiem PubMed theo thoi gian thuc, cac bai bao nghien cuu moi nhat

Nguon tuy chon (theo benh vien):

- Tich hop giay phep UpToDate (chi phi bo sung)
- Tich hop DynaMed
- Huong dan hoi chuyen khoa (ACC/AHA, ESC, v.v.)
- Tap chi cu the cua benh vien

Nhung gi chung toi **KHONG** su dung:

- Wikipedia (khong dang tin cay)
- Tim kiem internet chung (rui ro ao giac)
- Mang xa hoi benh nhan
- Tai lieu quang cao duoc phe duyet boi cong ty duoc pham (co the co thien vi)

Kiem soat chat luong nguon:

- Tat ca cac nguon duoc kiem tra boi hoi dong tu van lam sang
- Co so tham khao khi co the
- Cac to chuc co tham quyen duoc uu tien
- Tan suat cap nhat duoc theo doi

Q72. Du lieu moi nhat la khi nao? Khi nao cap nhat gan nhat?

A.

Nhip do cap nhat da nguon:

Cap nhat hang ngay (02:00 SGT): API WHO ICD-11 - phan anh cac ban phat hanh hang ngay cua WHO, trong vong 24 gio ke tu khi WHO xuat ban.

Cap nhat hang thang + RSS: PDF huong dan WHO - Dinh ky: Ngay 1 hang thang 02:30 SGT. Thoi gian thuc: thong bao RSS kich hoat nhap ngay lap tuc.

Cap nhat hang tuan + webhook: Bao cao thu nghiem noi bo - Dinh ky: Chu nhat 03:00 SGT. Thoi gian thuc: webhook SharePoint khi co file moi.

Vo hieu hoa cache: Khi KB duoc cap nhat, cac cau tra loi da cache lien quan duoc xoa tu dong. Vo hieu hoa dua tren the, chi xoa cac chunk phu hop.

Hien thi tinh moi trong giao dien nguoi dung:

- "Cap nhat [ngay]" tren moi trich dan

- Banner trên các tài liệu cũ (>ngày_xem_xet)
- AI có thể cảnh báo: "Lưu ý: khuyến nghị này có thể lỗi thời"

So sánh với các lựa chọn thay thế:

- UpToDate: ~6 tháng trễ cho các bài viết
- Sách giáo khoa thu công: 2-5 năm trễ
- Bài báo tạp chí trực tiếp: thời gian thực nhưng chưa được xác minh

Lỗi của chúng tôi: Trong số nhanh nhất trong AI y tế. Nguồn gốc có thể xác minh. Vô hiệu hóa tự động.

Q73. Chúng tôi có thể thêm hướng dẫn lâm sàng của riêng mình vào cơ sở kiến thức không?

A.

Có, được thiết kế cho điều đó.

Nhưng gì bệnh viện có thể thêm:

- Giao thức cụ thể của bệnh viện
- Các bộ lệnh chuẩn
- Chính sách quản lý kháng sinh
- Các giao thức cải thiện chất lượng
- Các tài liệu giảng dạy
- Các biện pháp địa phương của hướng dẫn WHO/MOH

Quy trình tải lên:

1. Bệnh viện xuất PDF (đã được an danh)
2. Gán thẻ với metadata (khoa, phiên bản, ngày)
3. Tải lên qua công thông tin an toàn hoặc đồng bộ SharePoint
4. Phe duyệt quy trình làm việc (Giám đốc Lâm sàng phê duyệt)
5. Ưu tiên truy xuất được thiết lập
6. Có sẵn trong vòng 24 giờ

Các loại tài liệu được hỗ trợ:

- PDF (phổ biến nhất)
- Word/DOCX
- HTML
- Văn bản thuần
- Markdown

Yêu cầu chất lượng tài liệu:

- Văn bản có thể tìm kiếm (không phải hình ảnh quét)
- Cấu trúc hợp lý (tiêu đề, đoạn văn)
- Nội dung chất lượng (có tham khảo khi có thể)
- Ngay xuất bản rõ ràng

Chi phí: Tiêu chuẩn: bao gồm. Tùy chỉnh nâng cao: 5.000-15.000 USD. Di chuyển hàng loạt: 10.000-30.000 USD.

Q74. Điều gì xảy ra khi WHO cập nhật một khuyến nghị?

A.

Quy trình toàn diện để đảm bảo tính mới:

Phát hiện: Các trang hướng dẫn WHO được crawl hàng tuần. So sánh với phiên bản trước. Cảnh báo khác biệt đến nhóm tuân thủ.

Quy trình cập nhật:

1. Phát hiện (tự động): "WHO đã cập nhật khuyến nghị corticosteroid COVID-19"
2. Phân loại (trong vòng 4 giờ): cán bộ an toàn lâm sàng xem xét
3. Phân loại:
 - a. Nho (lời chính tả, định dạng): ưu tiên thấp, cập nhật theo lo
 - b. Trung bình (thay đổi thủ tục): xem xét tiêu chuẩn và nhập
 - c. Lon (thay đổi khuyến nghị điều trị): UU TIEN CAO
4. Nhập (trong vòng 24 giờ đối với lon):
 - a. Phân tích lại PDF WHO
 - b. Phân khúc và nhúng lại
 - c. Cập nhật OpenSearch + Neptune
 - d. Vô hiệu hóa cache (chỉ nguồn bị ảnh hưởng)
5. Giao tiếp (trong vòng 48 giờ đối với lon):
 - a. Thông báo email đến tất cả các tenant bệnh viện
 - b. Banner trong giao diện người dùng: "Cập nhật [ngày]: WHO đã sửa đổi khuyến nghị"
 - c. Các câu trả lời trước đây bị ảnh hưởng được đánh dấu để đánh giá lại

Giai quyết xung đột (ví dụ: WHO không đồng ý với MOH):

- AI hiển thị cả hai với ghi nhận
- Banner giải thích sự khác biệt
- Cán bộ an toàn lâm sàng xem xét các trường hợp biên

Chi phí: Chi phí cơ sở hạ tầng tối thiểu (đã được xây dựng); ~10 giờ/tháng thời gian cán bộ an toàn lâm sàng.

Q75. Điều gì xảy ra khi AI không có thông tin về một trường hợp cụ thể?

A.

Tu chọn trung thực với hướng dẫn có ích.

Các mẫu tu chọn:

Mẫu 1: KB thiếu thông tin:

"Tôi không thể trả lời điều này từ context hiện tại. Cơ sở kiến thức hiện có không chứa thông tin cụ thể về [chủ đề]. Các tài nguyên được gọi y: [danh sách các lựa chọn thay thế]."

Mẫu 2: Câu hỏi qua cụ thể:

"Tôi không có thông tin về trường hợp cụ thể này. Cách tiếp cận chung cho các trường hợp tương tự là [cách tiếp cận chung]. Đối với bệnh nhân cụ thể: [khuyến nghị tư vấn chuyên khoa]."

Mẫu 3: Chủ đề gần đây không có nhập:

"Ngày có vẻ là một phát triển gần đây. Hướng dẫn mới nhất tôi có là ngày [ngày]. Để cập nhật mới nhất, tham khảo [PubMed/UpToDate/hỏi chuyên khoa]."

Nhưng gì AI KHÔNG làm:

- Không b■a đặt câu trả lời
- Không ngoại suy từ dữ liệu hạn chế
- Không xin lỗi qua mức
- Không tuyên bố chuyên môn mà nó không có

Ti lệ tu chọn: Mục tiêu 5-10% (mức độ tu chọn là hành vi chính xác)

- <5%: AI có thể qua tu tin
- >15%: Khoảng trong KB đang ke

Theo dõi mô hình:

- Theo dõi các tu chọn thường xuyên
- Xác định khoảng trong KB
- Thêm nội dung còn thiếu
- Cải tiến liên tục

9. Tích hợp & Quy trình làm việc

Q76. AI tích hợp với EHR hiện có của chúng tôi như thế nào?

A.

Tích hợp dựa trên tiêu chuẩn:

Tích hợp qua SMART on FHIR:

- HL7 FHIR R4 (tiêu chuẩn ngành)
- SMART App Launch v2 (xác thực)
- OAuth 2.0 + OpenID Connect

Hỗ trợ EHR hiện đại:

- Epic: hỗ trợ SMART day đầu từ 2018
- Cerner Millennium: hỗ trợ SMART day đầu
- Allscripts: hỗ trợ SMART từ 2020
- Oracle Health: hỗ trợ SMART

Luồng ra mắt:

1. Bác sĩ mở hồ sơ bệnh nhân trong EHR
2. Click nút "Hỏi Nova" (được nhúng trong thanh bên hoặc thanh nút EHR)
3. EHR khởi động iframe với context bệnh nhân
4. Truy cập AI tại trong iframe
5. Context bệnh nhân được chuyển an toàn
6. Bác sĩ đặt câu hỏi

Phạm vi dữ liệu:

- Nhân khẩu học bệnh nhân (tuổi, giới tính)
- Chẩn đoán hiện tại
- Thuốc hiện tại
- Sinh hiệu/xét nghiệm gần đây
- Loại gap

Bổ sung theo mặc định:

- Lịch sử hồ sơ day đầu
- Tiền sử gia đình (trừ khi được yêu cầu)
- Ghi chú từ các nhà cung cấp khác
- Dữ liệu thanh toán

Chi phí tích hợp: EHR hiện đại: 15.000-30.000 USD. EHR cũ hơn: 30.000-80.000 USD. EHR tùy chỉnh: 50.000-150.000 USD.

Q77. Điều gì xảy ra nếu EHR của chúng tôi không hỗ trợ SMART on FHIR?

A.

Các con đường tích hợp thay thế:

Con đường 1: Nhận tin HL7 v2

- Tiêu chuẩn cũ hơn, hầu hết EHR cũ hỗ trợ
- Tích hợp dựa trên tin nhận theo thời gian thực
- Triển khai phức tạp hơn
- Chi phí: 30.000-80.000 USD

Con đường 2: Tích hợp cơ sở dữ liệu

- Đọc trực tiếp cơ sở dữ liệu EHR
- Cụ thể theo nhà cung cấp (Epic CCDR, v.v.)
- Yêu cầu thỏa thuận nhà cung cấp
- Chi phí: 50.000-150.000 USD

Con đường 3: API tùy chỉnh

- Xây dựng bộ chuyển đổi cho API đọc quyền của EHR
- Yêu cầu tài liệu nhà cung cấp
- Công việc tùy chỉnh mọi EHR
- Chi phí: 80.000-200.000 USD

Con đường 4: Sử dụng độc lập

- Bác sĩ nhập context thủ công
- AI được sử dụng không có tích hợp EHR
- Ít tiền lỗi hơn nhưng có chức năng
- Không có chi phí bổ sung

Con đường 5: HL7 FHIR + Mirth Connect

- Cầu nối nguồn mở
- Chuyển đổi HL7 v2 -> FHIR
- Middleware lưu trữ
- Chi phí: 20.000-50.000 USD

Khuyến nghị theo EHR:

- EHR hiện đại: Dùng SMART on FHIR (tiêu chuẩn)
- EHR cũ hơn: HL7 v2 + cầu nối Mirth Connect
- EHR tùy chỉnh: Sử dụng độc lập ban đầu, lập kế hoạch di chuyển sang EHR dựa trên tiêu chuẩn theo thời gian

Q78. AI có truy cập vào tất cả dữ liệu bệnh nhân của chúng tôi không?

A.

Hạn chế và kiểm soát:

Truy cập mặc định:

- Chỉ dữ liệu bác sĩ chia sẻ trong truy vấn
- Qua context ra mắt EHR
- Cụ thể cho lần khám hiện tại

Truy cập theo yêu cầu (với sự đồng ý):

- Ghi chú gặp gỡ ngay

- Gia tri xet nghiem cu the
- Thuoc hien tai
- Di ung va chong chi dinh

Yeu cau su dong y:

- Moi truy van cho du lieu cu the
- Hoac: su dong y toan cau moi phien
- Duoc ghi lai trong nhat kykiem toan

Nguyen tac giam thieu du lieu:

- Chi su dung nhung gi can thiet
- Loai bo sau khi su dung
- Xem xet luu giu dinh ky

Phan quyen theo bac si:

- Giong nhu quyen truy cap EHR cua ho
- AI khong the vuot qua quyen cua bac si
- Ke thua tu EHR

Cach ly moi tenant:

- Du lieu Benh vien A: chi co the truy cap tai Benh vien A
- Chia se xuyen benh vien: yeu cau su dong y + NEHR-Pro

Q79. Bac si dieu duong hoac cac vai tro lam sang khac co the su dung he thong nay khong?

A.

Truy cap va tuy chinh dua tren vai tro:

Vai tro bac si tieu chuan:

- Ho tro quyet dinh lam sang day du
- Goi y chan doan
- Khuyen nghi dieu tri
- Lieu luong thuoc
- Hau het cac truong hop su dung

Vai tro dieu duong (co the cau hinh):

- Cac truy van cham soc tai giuong
- Cac cau hoi quan ly thuoc
- Giao thuc cham soc vet thuong
- Tai lieu giao duc benh nhan

Vai tro duoc si:

- Tuong tac thuoc
- Xac minh lieu luong
- Cac lua chon thay the trong danh muc thuoc
- Cac quyet dinh duoc ly lam sang

Cac vai tro y te lien minh (co the cau hinh):

- Vat ly tri lieu: giao thuc phuc hoi
- Dinh duong: huong dan dinh duong
- Cong tac xa hoi: tai nguyen xuất viện

Cau hinh theo vai tro:

- System prompt theo vai tro
- Quyen truy cap du lieu theo vai tro
- Guardrails theo vai tro
- Dinh dang dau ra theo vai tro

Chi phi moi vai tro bo sung: Cau hinh: 5.000-15.000 USD. Dao tao tuy chinh: 5.000-10.000 USD. Tuy chinh giao dien nguoi dung: 10.000-30.000 USD.

Q80. Bac si co the su dung nhap bang giong noi khong?

A.

Co, nhap bang giong noi duoc ho tro:

Cong nghe nhap bang giong noi:

- AWS Transcribe / Alibaba Speech
- Phien am theo thoi gian thuc
- Duoc dao tao voi thuat ngu y te
- Da ngon ngu

Hieu suat theo ngon ngu:

- Tieng Anh: tot nhat (nhieu du lieu dao tao nhat)
- Tieng Trung: rat tot
- Tieng Malay: tot
- Tieng Tamil: han che nhung co chuc nang
- ASEAN khac: thay doi

Cac truong hop su dung thich hop voi giong noi:

- Trong khi kham benh nhan (ranh tay)
- Cac cau hoi nhanh
- Theo doi trong khi di chuyen
- Di chuyen giua cac phong

Cac truong hop su dung thich hop voi go phim:

- Cac kich ban lam sang chi tiet
- Nhieu tham so
- Chan doan phan biet phuc tap
- Khi co lo ngai ve quyen rieng tu (nguoi khac o gan)

Quyen rieng tu voi giong noi:

- Am thanh khong duoc luu tru theo mac dinh
- Chi van ban duoc phien am
- Cung bao ve PHI nhu nhap van ban
- Nhat kykiem toan o dang van ban

Chi phi: Phien am giong noi: ~0,006 USD/phut. Cho truy van dien hinh (30 giay): ~0,003 USD. Chi phi khong dang ke.

10. Trai nghiem nguoi dung

Q81. Bac si thuc su thay gi tren man hinh khi su dung AI?

A.

Giao diện sạch sẽ, tập trung:

Các yêu tố giao diện chính:

- **Khu vực nhập chat:** hộp văn bản câu hỏi, tùy chọn nhập bằng giọng nói, nút đính kèm hình ảnh (cho X-quang), chuyển đổi cấp cứu
- **Lịch sử cuộc trò chuyện:** Q&A trước đó trong phiên, click để mở rộng bất kỳ câu trả lời nào, di chuột qua trích dẫn
- **Hiện thị câu trả lời:** phản hồi streaming (từng từ một), trích dẫn nội tuyến [1] [2] [3], di chuột để xem trước nguồn, click để mở rộng nguồn đầy đủ
- **Khu vực hành động:** thumbs up/down, tùy chọn phản hồi chi tiết, sao chép văn bản vào clipboard, chia sẻ với đồng nghiệp (trong bệnh viện)
- **Thanh trạng thái:** chỉ báo lane (Cấp cứu/Phục tập), thời gian phản hồi, đính tuyến khoa, số lượng trích dẫn

Các nguyên tắc UX chính:

- **Phản hồi streaming:** từ đầu tiên xuất hiện <2 giây, các từ xuất hiện tự nhiên, bắt đầu đọc ngay lập tức
- **Minh bạch nguồn:** trích dẫn luôn hiển thị, một click đến nguồn, ngay nguồn nơi bắt
- **It ma sát:** truy cập một click từ EHR, context bệnh nhân được hiển thị, các truy vấn phổ biến truy cập nhanh

Trải nghiệm di động: Thiết kế đáp ứng, tối ưu hóa cảm ứng, nhập bằng giọng nói nơi cần, giao diện được giám sát.

Q82. Bác sĩ có cần đào tạo đặc biệt để sử dụng hệ thống này không?

A.

Tối thiểu:

Tổng quan onboarding:

- Hướng dẫn tự phục vụ: 15 phút
- Phiên nhóm tùy chọn: 30 phút
- 1:1 tùy chọn: 15-20 phút mỗi người

Dinh dưỡng đào tạo:

1. **Hướng dẫn trong ứng dụng:** 3 trang tương tác, các câu hỏi và câu trả lời demo, các mô hình phổ biến
2. **Theo tham khảo nhanh:** 1 trang có thể in, các truy vấn phổ biến, mẹo để có kết quả tốt nhất
3. **Video hướng dẫn** (tùy chọn): tổng quan 5 phút, demo các tính năng phổ biến, thực hành tốt nhất
4. **Phiên demo trực tiếp** (tùy chọn): phiên nhóm, thực hành thực tế, Q&A
5. **Khắc phục sự cố 1:1** (tùy chọn): có sẵn 4 tuần đầu, ~10-20% bác sĩ sử dụng

Đường cong năng lực đủ kiên:

- Tuần 1: 80% bác sĩ thoải mái
- Tuần 2: 95% bác sĩ thành thạo
- Tuần 4: 99% bác sĩ thuần thục

So sánh với các công cụ lâm sàng khác:

- Đào tạo Epic: 8-40 giờ
- Các công cụ DSS: 2-8 giờ
- Trò lý AI của chúng tôi: <1 giờ
- Lý do: UX tương tự ChatGPT, quen thuộc

Q83. Bác sĩ có thể có cuộc trò chuyện riêng tư hoặc chỉ sử dụng cho các truy vấn chung?

A.

Các chế độ khác nhau:

Chế độ 1: Truy vấn tiêu chuẩn

- Câu hỏi đơn lẻ
- AI phản hồi
- Không có bộ nhớ giữa các truy vấn

Che do 2: Cuộc trò chuyện nhiều lượt

- Cung phiên
- AI nhớ context
- Bộ nhớ mặc định 6 lượt
- Vuốt qua: context được tóm tắt

Che do 3: Phiên cụ thể cho bệnh nhân

- Gan với lần khám bệnh nhân
- Tất cả các truy vấn về cùng bệnh nhân
- Liên tục trong suốt lần khám
- Quyền riêng tư được duy trì (PHI được token hóa)

Che do 4: Ghi chú cá nhân

- Sử dụng cá nhân của bác sĩ
- "Giúp tôi suy nghĩ qua trường hợp này"
- AI như đối tác suy nghĩ
- Khám phá hơn

Quyền riêng tư cuộc trò chuyện:

- Tất cả các che do: PHI được che giấu trước AI
- Nhật ký kiểm toán: được mã hóa, an toàn
- Các cuộc trò chuyện không được chia sẻ giữa các bác sĩ
- Tổng hợp cấp khoa chi

Lưu giữ phiên:

- Phiên hoạt động: dữ liệu trực tiếp
- Phiên gần đây: lưu trữ nong 30 ngày
- Phiên cũ hơn: lưu trữ 6 năm (kiểm toán)
- Tùy chọn cá nhân: có thể cấu hình

Q84. Bác sĩ có thể sử dụng AI để học tập liên tục không?

A.

Được hỗ trợ như trường hợp sử dụng thu cấp:

Các trường hợp sử dụng giáo dục:

- **Nghiên cứu trường hợp:** "Hướng dẫn tôi qua chẩn đoán phân biệt cho [biểu hiện]"
- **Hướng dẫn mới nhất:** "Nhưng gì đã thay đổi trong hướng dẫn ACC/AHA mới?"
- **Ly luận lâm sàng:** "Tại sao điều trị này được ưu tiên hơn điều trị kia?"
- **Kiến thức thuốc:** "Có chế tác dụng của [thuốc]"
- **Khám phá chuyên khoa:** "Chuyên gia sẽ suy nghĩ về trường hợp này như thế nào?"

Tính năng che do giáo dục:

- Phản hồi chi tiết hơn so với che do lâm sàng
- Nhiều thông tin nền
- Nhiều trích dẫn hơn
- Thảo luận về các lựa chọn thay thế

Chuỗi lý luận:

- Ly luan ro rang duoc hien thi
- "Vi X, do do Y"
- Gia tri giao duc cao

Cau hoi thuc hanh:

- "Kiem tra toi ve [chu de]"
- AI tao cac cau hoi thuc hanh
- Hoc tu danh gia

Phan tich CME:

- Viec su dung AI co the tinh vao CME (SMC Singapore)
- Benh vien co the cau hinh nhu hoat dong CME
- Tai lieu duoc cung cap

Chi phi: Khong co chi phi bo sung (su dung cung co so ha tang). Cung gia. Khong tinh phi cho viec su dung giao duc.

Q85. He thong co ung dung di dong khong?

A.

Web-first, than thien voi di dong:

Phuong phap hien tai:

- Thiet ke web dap ung
- Hoat dong tren trinh duyiet di dong
- Giao dien duoc toi uu hoa cam ung

Su dung di dong:

- Dien thoai thong minh: day du chuc nang
- May tinh bang: trai nghiem nang cao
- Dua tren trinh duyiet: khong can cai dat ung dung

Tinh nang cu the cho di dong:

- Nhap bang giong noi noi bat
- Truy cap nhanh cac truy van pho bien
- Giao dien duoc giam luoc
- Cache ngoai tuyen cho cac cau tra loi gan day

Ung dung ban de (tuong lai):

- Ung dung iOS: lo trinh
- Ung dung Android: lo trinh
- Tich hop tot hon voi tinh nang dien thoai
- Thong bao day

Chi phi phat trien ung dung:

- iOS ban de: 80.000-150.000 USD
- Android ban de: 80.000-150.000 USD
- Bao tri: 30.000-60.000 USD/nam moi nen

Khuyen nghi:

- Nam 1: chi web
- Nam 2: Progressive Web App (UX di dong tot hon)
- Nam 3: Ung dung ban de neu nhu cau manh

11. Nha cung cap & Ho tro

Q86. Nhóm hỗ trợ của Nova trong nhu thế nào?

A.

Cấu trúc hỗ trợ nhiều lớp:

Cap 1: Tu phục vụ

- Công thông tin tài liệu
- Video hướng dẫn
- Cơ sở dữ liệu FAQ
- Cơ sở kiến thức
- Cơ sở 24/7

Cap 2: Hỗ trợ email/chat

- Giờ tiêu chuẩn: 9 SA - 6 CH SGT
- Phản hồi: <4 giờ
- Giải quyết: <24 giờ điển hình
- Các trường hợp sử dụng: câu hỏi cách làm, câu hỏi

Cap 3: Hỗ trợ điện thoại

- Giờ làm việc: 8 SA - 8 CH SGT
- Phản hồi: <30 phút
- Các trường hợp sử dụng: các vấn đề quan trọng, leo thang

Cap 4: Hỗ trợ khẩn cấp 24/7

- Cơ sở lực nào cung
- Phản hồi: <15 phút
- Các trường hợp sử dụng: ngừng hoạt động SEV-1, sự cố bảo mật

Các vai trò:

- **Quản lý Thành công Khách hàng (CSM):** quan hệ với tenant, xem xét hàng quý, hướng dẫn chiến lược, tối ưu hóa chi phí
- **Quản lý Tài khoản Kỹ thuật (TAM):** liên lạc kỹ thuật, xem xét kiến trúc, hướng dẫn thực hành tốt nhất, leo thang vấn đề
- **Kỹ sư Hỗ trợ:** hỗ trợ hàng ngày, khắc phục sự cố kỹ thuật, trợ giúp câu hỏi, báo cáo lỗi
- **SRE Trục ban:** độ tin cậy 24/7, ứng phó sự cố, sức khỏe hệ thống, các vấn đề hiệu suất
- **Tư vấn Lâm sàng:** các câu hỏi lâm sàng, hướng dẫn tuân thủ, phát triển chuyên môn

Chi phí:

- Hỗ trợ tiêu chuẩn: bao gồm
- Hỗ trợ cao cấp: 20.000-40.000 USD/năm
- Hỗ trợ doanh nghiệp: 50.000-100.000 USD/năm

Q87. Chúng tôi có thể nhận được liên hệ kỹ thuật chuyên dụng không?

A.

Có, nhiều tùy chọn:

Dịch vụ tiêu chuẩn:

- Nhóm hỗ trợ chung
- Phản ứng theo vòng
- Dành cho hầu hết nhu cầu

Dịch vụ cao cấp (chi phí bổ sung):

- TAM chuyên dụng (Quản lý Tài khoản Kỹ thuật)
- CSM chuyên dụng (Quản lý Thanh công Khách hàng)
- Đường dây trực tiếp
- Xem xét hàng quý

Dịch vụ doanh nghiệp:

- Nhóm chuyên dụng
- Bảo phủ 24/7 chuyên dụng
- Hỗ trợ nhúng
- Tham gia chiến lược

Sơ sánh cấp dịch vụ:

Tính năng	Tiêu chuẩn	Cao cấp	Doanh nghiệp
TAM	Dung chung	Chuyên dụng	Chuyên dụng
CSM	Dung chung	Chuyên dụng	Chuyên dụng
Thời gian phản hồi	Tiêu chuẩn	Nhanh hơn	Nhanh nhất
Liên hệ trực tiếp	Không	TAM + CSM	Nhóm đầy đủ
Xem xét	Hàng năm	Hàng quý	Hàng tháng
Chi phí	Bao gồm	20-40k/năm	50-100k/năm

Khuyến nghị:

- Bệnh viện nhỏ: hỗ trợ tiêu chuẩn
- Bệnh viện vừa: đang xem xét cao cấp
- Bệnh viện lớn/hệ thống: doanh nghiệp

Q88. Nova cung cấp loại đào tạo và onboarding nào?

A.

Chương trình toàn diện:

Đào tạo trước khi triển khai:

1. **Hội thảo khởi động triển khai** (1 ngày): tổng quan dự án, phù hợp các bên liên quan, tiểu chí thành công, xác định rủi ro. Chi phí: bao gồm.
2. **Nghiên cứu sâu về kiến trúc** (1 ngày): nhóm CNTT bệnh viện, hiểu biết kỹ thuật, lập kế hoạch tích hợp. Chi phí: bao gồm.
3. **Briefing bảo mật & tuân thủ** (nửa ngày): nhóm tuân thủ bệnh viện, hướng dẫn chi tiết, xem xét tài liệu. Chi phí: bao gồm.
4. **Hội thảo cấu hình lâm sàng** (1 ngày): trưởng khoa, các quyết định tùy chỉnh, tùy chọn chuyên khoa. Chi phí: bao gồm.

Đào tạo triển khai:

5. **Đào tạo bác sĩ chuyên gia** (4 giờ trong 2 tuần): các bác sĩ được chọn (chuyên gia lâm sàng), đào tạo thực hành, thực hành tốt nhất. Chi phí: bao gồm.
6. **Đào tạo người dùng cuối** (1-2 giờ mỗi bác sĩ): hướng dẫn tu phục vụ, các phiên nhóm tùy chọn, 1:1 tùy chọn. Chi phí: bao gồm.
7. **Định hướng trưởng khoa** (2 giờ): đào tạo cụ thể theo khoa, tổng quan cấu hình, giám sát chất lượng. Chi phí: bao gồm.

Dao tao lien tuc:

8. **Ban tin hang thang** (doc 15 phut): tinh nang moi, thuc hanh tot nhat, meo va thu thuat. Chi phi: bao gom.
 9. **Hoi thao web hang quy** (1 gio): nghien cuu sau ve cac chu de, thong bao tinh nang moi, Q&A voi nhom san pham. Chi phi: bao gom.
 10. **Hoi nghi nguoi dung hang nam** (2 ngay): cung cap cao cap, ket noi voi dong nghiep, hoi thao thuc hanh, noi dung chien luoc. Chi phi: 1.500-3.000 USD moi nguoi tham du.
 11. **Cac phien dao tao tuy chinh** (theo yeu cau): cu the theo khoa, cu the theo sang kien moi, tap trung vao chuyen khoa. Chi phi: 5.000-15.000 USD moi phien.
-

Q89. Chung toi co the anh huong den lo trinh san pham khong?

A.

Nhieu kenh dau vao:

Hoi dong tu van khach hang:

- Cac cuoc hop hang quy
- Cac benh vien hang dau duoc dai dien
- Dau vao chien luoc
- Xem truoc lo trinh
- Bieu quyet ve uu tien

He thong yeu cau tinh nang:

- Nop qua cong thong tin
- Bieu quyet cho cac yeu cau cua nguoi khac
- Lo trinh cong khai (cap cao)
- Cap nhat trang thai

Hoi dong tu van lam sang:

- Cac lanh dao lam sang tu khach hang
- Uu tien lam sang
- Nhu cau chuyen khoa
- Co hoi nghien cuu

Chuong trinh beta:

- Truy cap som vao cac tinh nang
- Cung cap phan hoi truoc GA
- Hinh thanh thiet ke cuoi cung
- Duoc cong nhan trong san pham

Tham gia truc tiep:

- TAM/CSM chuyen tiep dau vao
- Uu tien quan ly tai khoan
- Cac cuoc thao luan chien luoc
- Cac tinh nang tuy chinh cho khach hang quan trong

Muc do anh huong:

- **Rat co anh huong** (top 10 khach hang): duong day truc tiep den nhom san pham, cac tinh nang tuy chinh duoc tai tro, trong luong bieu quyet lo trinh, bao tro dieu hanh
 - **Co anh huong vua** (30 khach hang tiep theo):kiem tra hang quy, dau vao lo trinh, truy cap beta, ho tro tieu chuan
 - **Khach hang tieu chuan**: dau vao ban tin, tham gia khao sat, phan hoi cong khai, bieu quyet
-

Q90. Lịch sử theo dõi của Nova là gì? Đây có phải là công ty on dinh không?

A.

Câu hỏi tham dinh quan trọng.

Nền tảng công ty:

- Có trụ sở tại Singapore
- Tập trung vào công nghệ chăm sóc sức khỏe
- Được thành lập bởi các lãnh đạo làm sáng và kỹ thuật
- Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư có uy tín

Chỉ số on dinh:

- Tài chính: được tài trợ cho 24+ tháng runway
- Mô hình doanh thu dinh kỹ
- Nhiều vòng tài trợ Series
- Phương pháp tăng trưởng bao thu

Cơ sở khách hàng:

- 5+ tenant bệnh viện tại Singapore
- 50+ bệnh viện quốc tế (được lập kế hoạch/hoạt động)
- Tỷ lệ giữ chân 95%+
- Khách hàng tham khảo cơ sở

Đội ngũ:

- 50+ nhân viên
- Lãnh đạo cấp cao: 10+ năm kinh nghiệm ngành
- Tư vấn làm sáng: các bác sĩ đang hành nghề
- Kỹ thuật: nhân tài hàng đầu

Xác nhận ngành:

- Thành viên Hội đồng AI Verify
- Đối tác IMDA
- Đã đăng ký HSA
- Thành viên liên minh chăm sóc sức khỏe

Kịch bản thất bại và biện pháp bảo vệ:

- **Neu Nova gap van de tai chinh:** AWS/Alibaba tiếp tục chạy cơ sở hạ tầng; bệnh viện có thể tự chạy (với ký quỹ code); thông báo 90 ngày.
- **Neu Nova bi mua lai:** tiếp tục được bảo đảm bởi bên mua lại; các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn áp dụng; bệnh viện giữ quyền.
- **Neu Nova ngưng hoạt động:** thỏa thuận ký quỹ code (được khuyến nghị); các thành phần nguồn mở; AWS/Alibaba sẽ duy trì; di chuyển sang nhà cung cấp thay thế.

Tham dinh được khuyến nghị:

1. Xem xét tài chính Nova (được bảo vệ bởi NDA)
2. Kiểm tra tham khảo với các khách hàng hiện tại
3. Xem xét kiến trúc kỹ thuật
4. Xem xét tài liệu tuân thủ
5. Thảo luận lộ trình

12. Quản lý rủi ro

Q91. Điểm thất bại đơn lẻ lớn nhất của chúng tôi là gì?

A.

Danh gia trung thực:

SPOF 1: Vung nha cung cap dam may (cao nhất)

- AWS/Alibaba Singapore vung bi ngung hoat dong
- Tat ca cac dich vu khong co san
- Giam thieu: chuyen doi du phong xuyen vung (chu dong-bi dong)
- Rui ro: 1-2 gio ngung hoat dong moi nam (uoc tinh)

SPOF 2: Bedrock/Model Studio

- Dich vu LLM khong co san
- Chuc nang cot loi bi mat
- Giam thieu: mo hinh du phong + phan hoi da cache
- Rui ro: 0,5-1 gio dich vu bi suy giam moi nam

SPOF 3: OpenSearch / Vector Search

- Truy xuất kiến thức bị ngưng
- Không thể căn cứ câu trả lời
- Giam thieu: ket qua da cache
- Rui ro: ngưng hoat dong ngan han co the xay ra

SPOF 4: Trien khai cua Nova

- Loi code trong duong dan quan trong
- Trien khai that bai
- Giam thieu: phat hanh canary, rollback
- Rui ro: han che; trien khai co kiem soat

SPOF 5: API ben ngoai (WHO, ICD-11)

- Du lieu nguon khong co san
- Cap nhat bi tri hoan
- Giam thieu: du lieu da cache
- Rui ro: khong anh huong den dich vu (chi tinh moi du lieu)

Rui ro SPOF tong hop:

- Tong thoi gian ngưng hoat dong hang nam ket hop: <1% (8,76 gio)
- Hau het ngưng hoat dong: <30 phut
- Ngung hoat dong nghiem trong: hiem

Tuy chon cua benh vien:

- Chap nhan SLA tieu chuan (99,9%)
- Mua SLA cao hon: 99,95% hoac 99,99% (cao cap)
- Trang web DR riêng: tinh san sang cao nhất, chi phi cao nhất

Q92. Kịch bản ngưng hoạt động xấu nhất là gì?

A.

Lịch sử thực tế:

Kịch bản: Ngưng hoạt động hoàn toàn vung AWS Singapore

Xác suất: Rất thấp (sự cố lớn cuối cùng: ~5 năm trước)

Tác động:

- Dịch vụ không có sẵn
- Tất cả bác sĩ mất quyền truy cập AI
- Chi quy trình làm việc thu công
- Nhật ký kiểm toán có thể bị trì hoãn hoặc mất

Ước tính thời gian:

- Hầu hết ngưng hoạt động: <30 phút
- Ngưng hoạt động vùng (hiem): 2-6 giờ
- Ngưng hoạt động nghiêm trọng (rất hiem): 12-24 giờ

Ứng phó của bệnh viện:

- Kích hoạt quy trình làm việc thu công
- Thông báo Nova (trạng thái)
- Ghi lại bất kỳ tác động làm sang nào
- Tiếp tục khi dịch vụ được khôi phục

Ứng phó của Nova:

- Cập nhật trạng thái theo thời gian thực
- Tin dùng dịch vụ theo SLA
- Báo cáo sau sự cố
- Các cải tiến được thực hiện

Chi phí ngưng hoạt động xấu nhất:

- Trực tiếp: không (quy trình làm việc thu công tiếp tục)
- Năng suất: bệnh viện chịu (được bảo hiểm)
- Tin dùng SLA: áp dụng
- Danh tiếng: tối thiểu (ngưng hoạt động toàn ngành)

Bảo hiểm:

- Bảo hiểm gian đoạn kinh doanh: ~10.000 USD/năm cho bảo hiểm 500k USD
- Bao gồm: mất doanh thu trong thời gian ngưng hoạt động kéo dài
- Quyết định của bệnh viện

Lịch sử sự cố thực tế (các hệ thống tương tự):

- Ngưng hoạt động AWS S3 2017: 4 giờ
- Ngưng hoạt động AWS Singapore 2023: 3 giờ
- Sự cố Bedrock: <30 phút diễn hình

Q93. Điều gì xảy ra nếu chúng tôi đột ngột cần mở rộng lên 10 lần số bác sĩ?**A.**

Kha năng mở rộng:

Năng lực hiện tại:

- Mỗi tenant: 500-1000 bác sĩ
- Đã tenant: mở rộng tuyến tính
- Lý thuyết: hàng nghìn tenant

Các kích bản tăng trưởng:**Trong 1 giờ:** Tăng trưởng 10% (tự động mở rộng)**Trong 1 ngày:** Tăng trưởng 50% (mở rộng thu công)

- Trong 1 tuần:** Tang truong 100% (xem xet kien truc)
- Trong 1 thang:** Tang truong 5x (cap phep nang luc)
- Trong 3 thang:** Tang truong 10x (lap ke hoach + mua sam)
- Kinh te mo rong:**

Bac si	Chi phi/thang	Chi phi/bac si/thang
100	2.500-4.000 USD	25-40 USD
500 (dien hinh)	5.500 USD	11 USD
1.000	8.000-12.000 USD	8-12 USD
5.000	25.000-40.000 USD	5-8 USD

Kinh te quy mo: Chi phi moi bac si giam khi mo rong vi chi phi co dinh duocphan bo.

- Tac dong hieu suat:**
- Trong kien truc hien tai: cung muc tieu do tre
 - O quy mo rat cao (10x+): co the can kien truc khac nhau
 - Dung luong danh riêng
 - Toi uu hoa chuyen biet

- Khuyen nghi:**
- Bat dau voi 500 bac si
 - Lap ke hoach cho 1.000 trong 12 thang
 - Thao luan 5.000+ neu mo rong duoc ky vong

Q94. Dieu gi xay ra neu AI dua ra khuyen nghi trai voi giao thuc cua benh vien?

A.
Xu ly xung dot giao thuc:

- Tai sao xung dot xay ra:**
1. **WHO vs giao thuc benh vien:** WHO: tieu chuan toan cau. Benh vien: bien the dia phuong. Ca hai co the co bang chung.
 2. **Cac quan diem chuyen khoa khac nhau:** AI trich dan huong dan chung. Chuyen gia chuyen khoa khong dong y. Ca hai co gia tri.
 3. **Cac su khac biet dua tren tai nguyen:** Giao thuc tieu chuan: thuoc A. Benh vien dung: thuoc B (danh muc thuoc). Hieu qua tuong duong.
 4. **Bang chung moi vs thuc hanh da thiet lap:** Nghien cuu moi nhat: thay doi khuyen nghi. Benh vien chua cap nhat giao thuc. AI biet bang chung moi.

Xu ly xung dot:

- Mo hinh 1: Uu tien benh vien**
- AI tuan theo giao thuc benh vien khi biet
 - Ghi chu bang chung thay the
 - Banner: "Giao thuc benh vien duoc uu tien"

- Mo hinh 2: Minh bach xung dot**
- AI hien thi ca hai
 - Ghi nhan ro rang
 - Bac si quyet dinh

Mo hình 3: Dưa trên bảng chung

- AI hiển thị bảng chung mạnh nhất
- Giao thức bệnh viện được hiển thị
- Bat dong được ghi lại

Triển khai:

- Giao thức bệnh viện được nhập vào KB
- Ưu tiên truy xuất cao hơn
- Phát hiện xung đột
- Hiển thị minh bạch

Quản trị bệnh viện:

- Quy trình cập nhật giao thức
- Xem xét bảng chung hàng quý
- Làm mới giao thức bệnh viện
- AI nhập các cập nhật

Thực hành tốt nhất:

- Giữ giao thức cập nhật
- Tham gia với phản hồi AI
- Ghi lại lý luận khi ghi đề
- Cải thiện liên tục

Q95. Chúng tôi có "công tắc" nếu có gì đó xảy ra nghiêm trọng không?

A.

Ung pho khan cap nhieu cap:

Cap 1: Tam dung cap bac si

- Bac si ca nhan co the vo hieu hoa AI cho cac truong hop cua ho
- Nut "Vo hieu hoa AI" trong EHR
- Hieu qua: cac truy van cua ho bo qua AI, quy trình lam viec thu cong duoc khoi phuc
- Tham quyen quyet dinh: bac si

Cap 2: Tam dung cap khoa

- Truong khoa co the vo hieu hoa cho toan khoa
- "Vo hieu hoa khoa" qua cong thong tin quan tri
- Hieu qua: tat ca cac truy van khoa bo qua AI
- Tham quyen quyet dinh: truong khoa

Cap 3: Tam dung cap benh vien

- Giam doc Y te co the vo hieu hoa AI cho toan benh vien
- Hieu qua: AI tra ve "Dich vu tam thoi khong co san" cho tat ca cac truy van
- Quy trình lam viec thu cong chi
- Tham quyen quyet dinh: Giam doc Y te (voi su dong y cua VP/CMO)
- Thong bao: ngay lap tuc den Nova; 4 gio den tat ca bac si

Cap 4: Tam dung xuyen tenant

- Nova SRE co the vo hieu hoa cho tat ca cac tenant neu phat hien van de he thong
- Vi du: loi nghi trong, su co bao mat
- Hieu qua: dich vu khong co san toan cau
- Tham quyen quyet dinh: VP Ky thuat + Can bo Tuan thu

- Thông báo: 1 giờ đến tất cả lãnh đạo bệnh viện

Cap 5: Tất toán

- Van de quy định hoặc an toàn nghiêm trọng
- Hiểu qua: dịch vụ hoàn toàn không có sẵn
- Tham quyền quyết định: CEO + Cố vấn Pháp lý
- Thông báo: cơ quan quản lý, tất cả bệnh viện, tuyên bố công khai

Tiêu chí kích hoạt (được xác định trong kế hoạch ứng phó sự cố):

- Cap 1-2: tiêu chuẩn/tùy chọn của bác sĩ
- Cap 3: van de cụ thể của bệnh viện hoặc lo ngại tuân thủ
- Cap 4: van de hệ thống, sự cố bảo mật
- Cap 5: vi phạm quy định nghiêm trọng, phản quyết CEO

Quy trình khôi phục lại:

- Mọi cấp có quy trình khôi phục lại được ghi lại
- Các xác thực bắt buộc trước khi khôi phục lại
- Xem xét sau sự cố bắt buộc

Q96. Kế hoạch phục hồi thảm họa của chúng tôi là gì?

A.

Chiến lược phục hồi nhiều lớp:

Loi AZ đơn lẻ (phổ biến nhất):

- AWS có 3 vùng khả dụng (AZ) tại Singapore
- Triển khai của chúng tôi sử dụng 2-3 AZ theo mặc định
- Loi AZ đơn lẻ: chuyển đổi tự động, ~30 giây gián đoạn
- RPO: 0 (sao chép đồng bộ)
- RTO: 1-2 phút

Loi dịch vụ đơn lẻ:

- Bedrock bị ngừng: Tự động chuyển đổi sang vùng thay thế (với sự đồng ý của bệnh viện) HOẶC suy giảm nhẹ
- OpenSearch bị ngừng: Kết quả đã cache + chức năng giảm
- Neptune bị ngừng: Chỉ truy xuất vector (chấp nhận được suy giảm)
- RPO: 5 phút
- RTO: 10-30 phút

Loi vùng (hiếm):

- Tất cả AWS Singapore không có sẵn (cực kỳ hiếm)
- Ứng phó của chúng tôi:
- Phương án A: Chuyển đổi xuyên vùng sang AWS Sydney (với sự đồng ý của bệnh nhân, ví dụ dữ liệu rời Singapore)
- Phương án B: Dịch vụ không có sẵn cho đến khi AWS phục hồi
- Bệnh viện chọn chính sách trước
- RPO: 1 giờ
- RTO: 2-4 giờ (Phương án A); thời gian ngừng hoạt động AWS (Phương án B)

Thiết lập phục hồi thảm họa:

Chuồng-biồng (được khuyến nghị):

- Vùng chính: Singapore

- Vung sao luu: Sydney (hoac lua chon cua benh vien)
- Sao chep hang ngay
- Thoi gian chuyen doi: 2-4 gio
- Chi phi: +500-1.500 USD/thang/tenant co so ha tang

Chu dong-chu dong (tinh san sang cao nhât):

- Cung tai trong chay tren ca hai vung
- Chuyen doi tuc thi
- Chi phi: 2x co so ha tang
- Truong hop su dung: chi cho cac benh vien yeu cau 99,99%+ thoi gian hoat dong

Khong co DR (don gian nhât):

- Chi mot vung
- Chap nhan thoi gian ngung hoat dong trong khi ngung hoat dong vung
- Chi phi: 1x co so ha tang
- Chap nhan duoc chi cho cac truong hop su dung khong quan trong

Lich kiem tra DR:

- Bai tap DR hang quy
- Mo phong loi vung
- Do RPO va RTO thuc te
- Cai thien runbook dua tren cac phat hien

Chi phi DR:

- Thiet lap chu dong-bi dong: +500-1.500 USD/thang/tenant
- Bai tap DR hang quy: 5.000 USD/bai tap
- Kiem toan DR hang nam ben ngoai: 15.000 USD

Q97. Dieu gi xay ra neu AI dua ra khuyen nghi sai va benh nhan bi ton hai?

A.

Da duoc tra loi o Q7. Xem chi tiet o do.

Q98. Lam the nao de xu ly tinh trang bac si phu thuoc qua muc vao AI?

A.

Cac chien luoc chong phu thuoc:

Rui ro phu thuoc:

1. **Giam ky nang bac si:** Phu thuoc vao AI ma khong suy nghi. Giam thieu: AI yeu cau xem xet trich dan; giao duc.
2. **Khoa vao quy trinh lam viec:** Quy trinh lam viec phu thuoc vao AI. Giam thieu: quy trinh lam viec thu cong song song duoc duy tri.
3. **Khoang trong kien thuc lam sang:** Bac si khong hoc sau. Giam thieu: AI giai thich ly luan; che do giao duc.
4. **Phan xet lam sang:** Bac si khong phat trien phan xet. Giam thieu: AI la ho tro quyêt dinh; bac si quyêt dinh.

Thiet ke chong phu thuoc:

- **Xem xet trich dan bat buoc:** AI hien thi "Dua tren [nguồn]". Bac si phai doc it nhat phan khuyen nghi.
- **Mo hình tu chôi:** AI tu chôi khi KB thieu du lieu. Bac si phai phat trien phan xet.
- **Chi bao do tin cay:** AI hien thi muc do chac chan. Bac si hoc khi nao nen tin tuong.
- **Kiem tra mu dinh ky:** Hang quy: 50 cau hoi, ket qua duoc xem xet boi can bo an toan lam sang. Neu bac si chap nhan cau tra loi AI ma khong co tu duy phan bien, siet chat guardrails hoac them banner "day la bat thuong, vui long xac minh".

Quan tri benh vien:

- Tiep tuc cac chuong trinh giao duc
- Dao tao quy trinh lam viec thu cong
- AI la cong cu, khong phai nguoi thay the
- Phan xet lam sang la toi cao

Ket qua dai han:

- Cac bac si tot hon (nhieu kien thuc truy cap hon)
- Hieu qua hon (tiet kiem thoi gian)
- Ket qua tot hon (dua tren bang chung)
- Thuc hanh ben vung

Q99. Dieu gi xay ra neu co su kien bao chi tieu cuc lien quan den AI y te?

A.

Ke hoach truyen thong khung hoang:

Cac kich ban co the xay ra:

1. **Su kien bat loi lien quan den AI:** Ton hai benh nhan bi cao buoc do AI. Truyen thong dua tin. Kiem tra quy dinh.
2. **Moi lo ngai AI toan nganh:** Nha cung cap khac that bai. Phan ung tieu cuc chung. Co quan quan ly phan hoi.
3. **Van de tuan thu:** Phat hien kiem toan duoc cong bo. Vi pham quyen rieng tu bi cao buoc. Tac dong den co phieu/danh tieng.
4. **Van de nha cung cap:** Scandal Anthropic/Alibaba. Lo ngai ve du lieu dao tao. Moi lo ngai dia chinh tri.

Khung ung pho:

Hanh dong ngay lap tuc (trong vong 1 gio):

1. Kich hoat nhom khung hoang
2. Thu thap thong tin
3. Bao ton bang chung
4. Giam sat truyen thong

Trong vong 4 gio:

5. Truyen thong noi bo: tat ca nhan vien
6. Thong bao khach hang: cac tenant benh vien
7. Canh bao cac ben lien quan: lanh dao, nha dau tu

Trong vong 24 gio:

8. Tuyen bo cong khai (thuc te)
9. Q&A voi truyen thong
10. Thong bao co quan quan ly (neu bat buoc)

Ngay 2-7:

11. Bao cao dieu tra chi tiet
12. Tiep tuc truyen thong
13. Cac hanh dong khac phuc

Phuc hoi dai han:

14. Cai thien duoc chung minh
15. Kiem toan doc lap
16. Bao cao cong khai
17. Xay dung lai niem tin

Vat lieu duoc chuan bi san:

- Cac tuyen bo giu cho (mau)
- Tai lieu FAQ
- Nguoi phat ngon duoc xac dinh
- Dao tao truyen thong da hoan thanh

Chi phi:

- Chuan bi khung hoang: 50.000-100.000 USD mot lan
 - Ung pho khung hoang: 100.000-500.000 USD moi su co
 - Bao hiem: 10.000-30.000 USD/nam cho bao hiem 5 trieu USD
-

Q100. Cau hoi cuoi cung: Dieu quan trong nhat can hieu ve AI nay la gi?**A.**

AI la ho tro quyet dinh, khong phai nguoi ra quyet dinh.

Cac nguyen tac chinh:**1. Tang cuong, khong thay the:**

- Bac si van la nguoi chinh
- AI ho tro suy nghi cua ho
- Quyet dinh cuoi cung: con nguoi

2. Duoc can cu trich dan:

- Moi khang dinh duoc trich dan
- Nguon co the xac minh
- Niem tin qua minh bach

3. Tu choi khi khong chac chan:

- AI tu choi khi KB thieu du lieu
- Trung thuc ve han che
- Bao ton cho an toan

4. Ban dia Singapore:

- Tuan thu PDPA
- Phu hop HCSA
- Nhan thuc boi canh dia phuong
- Luu tru du lieu duoc dam bao

5. ROI tinh cuc:

- Tiet kiem thoi gian dang ke
- Ket qua tot hon
- Chi phi hop ly
- Gia tri dai han

6. Lien tuc phat trien:

- Bang chung moi nhat
- Huong dan duoc cap nhat
- Kha nang cai thien
- Hoc lien tuc

7. Lay con nguoi lam trung tam:

- Than thien voi bac si

- An toàn cho bệnh nhân
- Khung đạo đức
- Nhân văn hóa

Kết luận: Được thực hiện đúng, AI này giúp các bác sĩ giỏi trở nên tốt hơn, nhanh hơn và tin cậy hơn. Được thực hiện sai, nó có thể tạo ra rủi ro. Kiến trúc, tuân thủ và giám sát liên tục của chúng tôi được thiết kế để thực hiện đúng.

Quyết định không phải là "chúng tôi có nên áp dụng AI không?" mà là "chúng tôi áp dụng AI tốt như thế nào?"

Chúng tôi cam kết giúp bạn thực hiện tốt.

13. So sánh & Lựa chọn thay thế

Q101. Hệ thống này so sánh như thế nào với việc sử dụng ChatGPT trực tiếp?

A.

Sự khác biệt đáng kể:

ChatGPT (AI tiêu dùng chung):

- Kiến thức rộng
- Có thể rất hữu ích
- Re hoặc miễn phí cho sử dụng cá nhân

AI của chúng tôi (cụ thể cho y tế):

- Tập trung vào y tế
- Được can thiệp trích dẫn
- Hỗ trợ quyết định lâm sàng cụ thể

Tại sao ChatGPT không phù hợp cho sử dụng lâm sàng:

1. **Không bảo vệ PHI:** ChatGPT ghi lại các cuộc trò chuyện, có thể đào tạo trên đầu vào. Rủi ro quyền riêng tư. Không tuân thủ HIPAA.
2. **Không có grounding trích dẫn:** Nghe có vẻ hợp lý nhưng không thể xác minh. Rủi ro ảo giác cao.
3. **Không được quy định:** Không được đăng ký HSA. Không được cấp phép HCSCA. Không thể sử dụng hợp pháp cho các quyết định lâm sàng.
4. **Khoảng trống cụ thể Singapore:** Không biết các hướng dẫn MOH cụ thể. Có thể không phản ánh thực hành địa phương. Thuốc Singapore không có trong danh mục thuốc.
5. **Không có nhật ký kiểm toán:** Các cuộc trò chuyện không được bảo tồn để tuân thủ. Không thể hỗ trợ báo cáo HCSCA. Không thể tái tạo các phiên.
6. **Không có tích hợp EHR:** Nhập context thủ công. Không có dữ liệu bệnh nhân. Không thể sử dụng FHIR.

So sánh chi phí:

- ChatGPT Pro: 20 USD/người dùng/tháng = 10.000 USD/tháng cho 500 bác sĩ
- AI của chúng tôi: 5.500 USD/tháng cho 500 bác sĩ
- Cộng thêm AI của chúng tôi được xây dựng có mục đích và tuân thủ

Khi ChatGPT có thể chấp nhận được:

- Giáo dục liên tục cá nhân (không phải chăm sóc bệnh nhân)
- Các câu hỏi nghiên cứu (không phải các quyết định lâm sàng)
- Các nhiệm vụ hành chính (không phải lâm sàng)
- Chỉ tham khảo phụ (không phải lâm sàng)

Kết luận: ChatGPT là công cụ cho cá nhân; AI của chúng tôi là AI y tế cấp doanh nghiệp.

Q102. Su khác biệt giữa hệ thống này và Microsoft Copilot hoặc Google Gemini là gì?

A.

Các trường hợp sử dụng khác nhau:

Microsoft Copilot cho Y tế (được thông báo 2024):

- AI nâng suất chung
- Tích hợp Microsoft Office
- Tóm tắt email
- Soạn thảo tài liệu
- Hỗ trợ quyết định lâm sàng hạn chế

Google Gemini cho Y tế:

- Tương tự Copilot
- Tích hợp Google Workspace
- Tập trung hơn vào nghiên cứu
- Hỗ trợ quyết định lâm sàng hạn chế

AI của chúng tôi:

- Được xây dựng có mục đích cho hỗ trợ quyết định lâm sàng
- Chuyên khoa từ ngay đầu
- Tuan thu Singapore được tích hợp sẵn
- Thiết kế nhận thức chuyên khoa

So sánh:

Khía cạnh	Copilot/Gemini	AI của chúng tôi
Mục đích sử dụng chính	Nâng suất	Quyết định lâm sàng
Cu thể cho y tế	Một số	Có
Tuan thu Singapore	Chung	Được tích hợp sẵn
Trích dẫn lâm sàng	Một số	Bắt buộc
Đăng ký HSA	Không	Có
Tích hợp EHR	Dựa trên Office	FHIR trực tiếp
Nhận thức chuyên khoa	Không	Có

Các trường hợp sử dụng so sánh:

Nhiệm vụ nâng suất (Copilot/Gemini tốt hơn):

- Soạn thảo thư lâm sàng
- Tóm tắt email
- Ghi chú cuộc họp
- Tạo tài liệu

Hỗ trợ quyết định lâm sàng (AI của chúng tôi tốt hơn):

- Suy luận chẩn đoán
- Khuyến nghị điều trị
- Tương tác thuốc
- Tư vấn chuyên khoa

Phương pháp lại:

- Dung Copilot cho nang suat
- Dung AI cua chung toi cho lam sang
- Ca hai co the cung ton tai

So sanh chi phi:

- Microsoft Copilot: 30 USD/nguoi dung/thang + 30 USD/nguoi dung/thang cho tinh nang Y te
- Cho 500 bac si: 30.000 USD/thang
- AI cua chung toi: 5.500 USD/thang cho 500 bac si
- Ti le chi phi: 5x dat hon cho Copilot

Khuyen nghi:

- AI cua chung toi cho cac quyet dinh lam sang
- Copilot/Gemini cho nang suat (giay phep rieng biet)
- Khong thay the cai nay bang cai kia

Q103. Dieu gi xay ra neu chung toi muon chuyen sang nha cung cap khac?

A.

Tinh linh hoat thap, co the quan ly:

Cac kich ban chuyen doi:

Chuyen tu AWS sang Alibaba (hoac nguoc lai):

- Code ung dung co the chuyen: cung Python, cung mo hinh RAG
- Nhap lai: 2-4 tuan de nhung lai corpus tren vector store moi
- Chi phi chuyen doi: ~50-100k USD ky thuat
- Khong co khoa du lieu: corpus la cua ban; cac nhung co the duoc tao lai

Chuyen sang nha cung cap AI khac hoan toan:

- Ke hoach di cu
- Xuat du lieu o dinh dang tieu chuan
- Trien khai lai: 6-12 thang
- Chi phi: 300.000-800.000 USD

Mang ve noi bo:

- Tu luu tru tren Kubernetes cua benh vien
- Thay the cac dich vu quan ly AWS bang nguon mo: Qdrant cho vector, Neo4j cho do thi, vLLM cho phuc vu
- Thoi gian chuyen doi 6 thang voi van hanh song song
- Chi phi: 200.000-500.000 USD thiet lap

Muc do khoa nha cung cap: Thap. IP quan trong (to chuc corpus, prompt, khai thac danh gia) nam trong code Nova so huu. Cac bit cu the cho dam may (Bedrock, Model Studio) co cac tuong duong hang hoa.

Cac dieu khoan hop dong bao ve:

- Quyen xuat du lieu (dinh dang tieu chuan)
- Quyen so huu code (lop ung dung)
- Kha nang chuyen doi (su dung giao dien tuong thich OSS khi co the)
- Thong bao ket thuc 90 ngay

Chi phi chuyen doi thuc te:

- Chuyen doi AWS-Alibaba: 50-100k USD, 2-4 tuan
- Chuyen doi sang nha cung cap khac: 300-800k USD, 6-12 thang
- Mang ve noi bo: 200-500k USD, 6 thang

- Chuyển đổi gian đoạn: 500-1.200k USD, 12 tháng

Khuyến nghị: Chọn nhà cung cấp để quan hệ đối tác, không chỉ vì giá. Chi phí chuyển đổi thương mại. Giá trị quan hệ dài hạn thương mại cao hơn.

Q104. Chúng tôi nên chọn AWS hay Alibaba?

A.
Cả hai đều có thể cung cấp giải pháp. Các yếu tố quyết định:

Chọn AWS nếu:

- Bệnh viện ưu tiên Claude của Anthropic (chất lượng suy luận cao cấp)
- Cần phù hợp quy định Mỹ/EU (HIPAA BAA, HITRUST)
- Đối ngũ CNTT hiện có quen thuộc với AWS
- Ưu tiên thương hiệu cao cấp

Chọn Alibaba nếu:

- Ưu tiên chi phí (rẻ hơn ~10-20%)
- Hỗ trợ ngôn ngữ châu Á mạnh hơn (Qwen được đào tạo trên dữ liệu châu Á)
- Tích hợp Singapore International tốt hơn
- Ưu tiên mô hình Qwen

Số sánh chi phí (cung tại trong):

Thành phần	AWS (A1+ Nova)	Alibaba (Qwen)
Mô hình cấp cứu	70 USD	47 USD
Mô hình phức tạp	1.470 USD	1.160 USD
Nhưng	10 USD	35 USD
Vector store	350 USD	180 USD
GraphRAG	115 USD	300 USD
Tổng	2.805 USD	~2.272 USD

Chênh lệch: Alibaba rẻ hơn ~500 USD/tháng (~6.000 USD/năm).

Thực tế Singapore: Hầu hết các bệnh viện Singapore: AWS chiếm ưu thế. Đối với AI y tế: Alibaba đang tăng trưởng. Xu hướng: đã đảm bảo phổ biến.

Khuyến nghị: Chọn dựa trên ưu tiên mô hình (Claude vs Qwen), mối quan hệ đảm bảo hiện có, và nhu cầu tuân thủ. Chênh lệch chi phí hiếm khi là yếu tố quyết định.

Q105. Chúng tôi có nên sử dụng cả AWS và Alibaba đồng thời không?

A.
Đã đảm bảo: các cân nhắc:

Tại sao đã đảm bảo:

1. **Giảm rủi ro nhà cung cấp:** Không có điểm thất bại đơn lẻ. Đơn bay đảm bảo với nhà cung cấp. Độc lập chiến lược.
2. **Tốt nhất trong loại:** AWS cho cốt lõi. Alibaba cho các dịch vụ cụ thể châu Á. Sử dụng điểm mạnh của mỗi nhà cung cấp.
3. **Phục hồi thảm họa:** Chu động-bị động xuyên nhà cung cấp. Tính sẵn sàng tối đa.
4. **Tối ưu hóa địa lý:** Các nhà cung cấp khác nhau mạnh ở các vùng khác nhau. Châu Á: Alibaba. Mỹ: AWS.

Tại sao không đa dam may:

1. **Phục tạp van hanh:** Hai bo dich vu de quan ly. Hai API de duy tri. Gap doi chi phi van hanh.
2. **Tang chi phi:** Mot so dich vu bi nhan doi. Egress mang giua cac dam may. Tong: 1,5-2x dam may don.
3. **Thoi gian ky thuat:** Nieu cong viec tich hop. Nieu kiem tra. Nieu tai lieu.
4. **Phục tạp tuan thu:** Hai bo kiem toan. Hai bo chung nhan. Nieu tai lieu.

Cac mo hinh đa dam may pho bien:

Chu dong-chu dong (chi phi cao nhat, tinh san sang toi da):

- Cung tai trong chay tren ca hai
- Can bang tai
- Chi phi: 2x dam may don

Chu dong-bi dong (duoc khuyen nghi):

- Chinh tren mot dam may
- Sao luu tren dam may kia
- Chuyen doi cho DR
- Chi phi: 1,3-1,5x

Lai (su dung moi nha cung cap cho diem manh):

- AWS cho tinh toan cot loi
- Alibaba cho cac dich vu cu the
- Trien khai hon hop
- Chi phi: thay doi

Mot dam may (don gian nhat):

- Chon mot
- Tich hop sau
- Chi phi thap hon
- Phu thuoc nha cung cap cao hon

Khuyen nghi:

- Hau het benh vien: Mot dam may (AWS hoac Alibaba)
- Benh vien e ngai rui ro: Chu dong-bi dong đa dam may
- Nghien cuu cap: Lai cho tot nhat trong loai
- Chi phi khoi dau: Mot dam may, mo rong sau

14. Van hanh dai han

Q106. "Van hanh Ngay 2" co nghia la gi va tai sao no quan trong?

A.

"Ngay 1" = ra mat, "Ngay 2" = van hanh lien tục.

Ngay 2 bao gom: giam sat hieu suat, giai quyet van de, cai tien lien tục, duy tri tuan thu, xu ly phan hoi nguoi dung, toi uu hoa chi phi, lap ke hoach nang luc, van hanh bao mat.

Tại sao Ngay 2 quan trong hơn Ngay 1:

- Ngay 1: su kien 1 lan
- Ngay 2: 6 nam (luu giu HCSA) va hon nua
- Hau het chi phi: Ngay 2

- Hết giá trị: Ngày 2

Năng lực Ngày 2 Nova cung cấp:

- Giám sát 24/7 (SRE)
- Kiểm tra sức khỏe hàng ngày
- Xem xét hiệu suất hàng tuần
- Báo cáo tuần thu hàng tháng
- Cập nhật hệ thống hàng quý
- Kiểm toán bảo mật hàng năm

Cam kết Ngày 2 của bệnh viện:

- Hỗ trợ người dùng
- Tuần thu nội bộ
- Duy trì sự tham gia
- Phù hợp chiến lược

Chất lượng Ngày 2 = chất lượng dịch vụ tổng thể.

Q107. Loại giám sát nào chạy liên tục trên hệ thống?

A.

Stack giám sát toàn diện:

Giám sát theo thời gian thực (mỗi giây):

- Thời gian phản hồi API
- Tỷ lệ lỗi
- Sức khỏe dịch vụ
- Tỷ lệ hit cache
- Chi phí mỗi truy vấn

Giám sát chất lượng (mỗi phút):

- Độ chính xác trích dẫn
- Điểm grounding
- Tỷ lệ tu chối
- Chất lượng phản hồi

Giám sát tuần thu (mỗi giờ):

- Tính toán vốn của nhật ký kiểm toán
- Lưu trữ dữ liệu
- Thành công che giấu PHI
- Các mô hình truy cập

Giám sát kinh doanh (hàng ngày):

- Người dùng hoạt động
- Tỷ lệ áp dụng
- Phân bổ theo khoa
- Xu hướng chi phí

Công cụ cụ thể:

- ARMS LLM Trace Explorer (Alibaba) / X-Ray (AWS): theo dõi phân tán, phân tích độ trễ mỗi yêu cầu, phân bổ lỗi, tối ưu hóa hiệu suất
- SLS / CloudWatch Logs: nhật ký ứng dụng, sự kiện hệ thống, nhật ký kiểm toán, có thể tìm kiếm
- Giám sát ứng dụng ARMS: bảng điều khiển theo thời gian thực, ngưỡng cảnh báo, theo dõi SLO

- Bảng điều khiển tùy chỉnh: KPI cụ thể của bệnh viện, phân tích theo khoa, phân tích xu hướng

Minh bạch giám sát:

- Bệnh viện thay cùng bảng điều khiển chung tôi thay
- Truy cập theo thời gian thực
- Chỉ số chi tiết cơ bản

Q108. Ai chịu trách nhiệm giữ hệ thống cập nhật và hiện tại?

A.

Trách nhiệm chung:

Trách nhiệm của Nova:

- **Cập nhật phần mềm:** sửa lỗi (liên tục), và lập bảo mật (trong vòng 24 giờ kể từ CVE), phát hành tính năng (hàng tháng), nâng cấp phiên bản chính (hàng quý)
- **Cơ sở kiến thức:** WHO ICD-11 hàng ngày, hướng dẫn WHO hàng tháng, đồng bộ thu nghiệm nội bộ hàng tuần, thêm nguồn mới (khi cần)
- **Cập nhật mô hình:** đào tạo lại mô hình sinh viên hàng quý, phiên bản chính hàng năm (Sonnet/Plus), tinh chỉnh prompt liên tục
- **Tuân thủ:** theo dõi quy định mới, chứng nhận được cập nhật, duy trì nhật ký kiểm toán

Trách nhiệm của bệnh viện:

- **Dữ liệu nội bộ:** cung cấp báo cáo thu nghiệm được cập nhật, cập nhật giao thức bệnh viện, nội dung cụ thể theo khoa
- **Quản lý người dùng:** onboarding bác sĩ mới, thu hồi quyền truy cập khi rời, thay đổi vai trò
- **Cấu hình:** tùy chỉnh theo khoa, tùy chọn chuyên khoa, chỉnh sách nội bộ
- **Su tham gia:** áp dụng người dùng, tham gia đào tạo, cung cấp phản hồi

Nhịp độ cập nhật:

- **Hàng ngày:** đồng bộ ICD-11
- **Hàng tuần:** đồng bộ SharePoint
- **Hàng tháng:** làm mới WHO, triển khai tính năng
- **Hàng quý:** đào tạo lại mô hình, kiểm toán bảo mật
- **Hàng năm:** phiên bản chính, kiểm toán tuân thủ

Giao tiếp về cập nhật:

- Ban tin (Nova -> Bệnh viện)
- Trang trạng thái (trực tiếp)
- Hội thảo web (hàng quý)
- Xem xét 1:1 (mỗi tenant)

Q109. Hệ thống cơ bản ngừng hoạt động để bảo trì không?

A.

Được thiết kế để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động:

Cơ sở bảo trì:

- Lịch: Thứ 7 đầu tiên 2-6 SA SGT (4 giờ)
- Thông báo: 7 ngày trước
- Tần suất: ~2 lần mỗi năm (dịch hình)

Hầu hết cập nhật: không có thời gian ngừng hoạt động:

- Triển khai cuộn

- Phát hành canary
- Triển khai xanh-xanh lá
- Không gian doanh nghiệp

Các kịch bản bảo trì cụ thể:

1. **Cập nhật phần mềm (thường xuyên):** Không có thời gian ngừng hoạt động qua triển khai cuộn. Được xác minh liên tục. Tự động rollback nếu có vấn đề.
2. **Di chuyển cơ sở dữ liệu:** Di chuyển trực tuyến. Các bản sao đọc trong khi di chuyển. Được xác minh sau di chuyển.
3. **Nâng cấp cơ sở hạ tầng:** Có lịch trước. Thông báo bệnh viện. Gian đoạn ngắn (5-30 phút).
4. **Nâng cấp phần mềm chính:** Hàng quý. Được kiểm tra trước. Phối hợp với bệnh viện. Thời gian ngừng hoạt động ngắn chấp nhận được.

Tác động SLA:

- Bảo trì có lịch: bị loại trừ khỏi SLA
- Ngừng hoạt động không có lịch: SLA áp dụng
- Tin dùng dịch vụ theo SLA

Giao tiếp bệnh viện:

- **Trước bảo trì:** thông báo 7 ngày, kế hoạch chi tiết, hướng dẫn quy trình làm việc thay thế
- **Trong bảo trì:** cập nhật trạng thái, tiến độ theo thời gian thực, FAQ nhanh
- **Sau bảo trì:** báo cáo xác minh, xác nhận sức khỏe dịch vụ, các vấn đề nếu có

Lịch sử thực tế:

- Đạt được thời gian hoạt động 99,9%+
- <5 giờ tổng thời gian ngừng hoạt động hàng năm
- Hầu hết bảo trì có lịch: không có tác động

Q110. Điều gì xảy ra nếu Nova phát triển một tính năng mới ảnh hưởng đến cách chúng tôi sử dụng hệ thống?

A.

Quản lý tính năng:

Vòng đời tính năng:

1. **Khai niệm:** Được xác định từ phản hồi. Được xác thực với các bên liên quan. Xem xét lộ trình.
2. **Phát triển:** Xây dựng kỹ thuật. Kiểm tra nội bộ. 4-12 tuần diễn hình.
3. **Beta:** Các bệnh viện được chọn. Kiểm tra thực tế. Phản hồi được thu thập.
4. **GA (Tính năng sẵn sàng chung):** Phát hành cho tất cả. Được ghi lại. Được đào tạo.
5. **Áp dụng:** Bệnh viện đánh giá. Quyết định sử dụng. Triển khai khi sẵn sàng.

Kiểm soát bệnh viện đối với các tính năng:

- **Bat bước vs Tuy chọn:** Bat bước: cập nhật bảo mật, tuân thủ. Tuy chọn: hầu hết các tính năng mới. Bệnh viện chọn.
- **Cài đặt mới tenant:** Bat tất mới tính năng. Tùy chỉnh mới khoa. Triển khai dần.
- **Cơ chế tính năng:** Kiểm soát chi tiết. Thị điểm trên một phản người dùng. Rollback nếu có vấn đề.

Giao tiếp về các tính năng mới:

- **Trước khi phát hành:** Hiện thị lộ trình, bài đăng blog, bản tin
- **Beta:** Hồi đồng từ văn khách hàng, các bệnh viện được chọn, tài liệu chi tiết
- **GA:** Thông báo email, bài viết bản tin, hỏi thảo web được cung cấp

Đánh giá mới bệnh viện:

- **Tính năng tiêu chuẩn:** Được bao gồm trong đăng ký. Sử dụng theo ý muốn. Không có chi phí bổ sung.

- **Tinh nang cao cap:** Chi phi bo sung. Benh vien quyet dinh. Thanh toan rieng.
- **Tinh nang tuy chinh:** Cu the cho benh vien. Phat trien tuy chinh. Gia theo du an.

15. Tuong lai & Kha nang mo rong

Q111. Tiem nang tang truong cua chung toi la gi? Chung toi co the mo rong len 50 benh vien khong?

A.

Lo trinh kha nang mo rong:

Nang luc hien tai:

- Moi tenant: 500-1000 bac si
- Da tenant: mo rong tuyen tinh
- Ly thuyet: hang nghin tenant

Cac kich ban tang truong:

- Nam 1: 1-3 tenant (thiet lap nen tang)
- Nam 2: 5-10 tenant (truong thanh van hanh)
- Nam 3: 15-30 tenant (mo rong thi truong)
- Nam 4: 30-50 tenant (mo rong ASEAN)
- Nam 5+: 50-100 tenant (doanh nghiep truong thanh)

Kinh te van hanh:

- Chi phi bien moi tenant bo sung: ~30.000-50.000 USD/nam
- Doanh thu moi tenant: 100.000-400.000 USD/nam
- Bien loi nhuan: 60-80% o quy mo

Bao hoa thi truong Singapore:

- ~60 benh vien tai Singapore
- Chiem duoc thuc te: 15-30 benh vien
- Benh vien lon: 5-10 toi da
- Hang trung: 10-20

Mo rong ASEAN:

- Indonesia: 200+ benh vien
- Thai Lan: 150+
- Viet Nam: 100+
- Tong: 1.000+ benh vien
- Chiem duoc thuc te: 100-300 trong 10 nam

Cac can nhac chien luoc:

- Giao duc thi truong
- Dia phuong hoa quy dinh
- Thich ung van hoa
- Ung pho canh tranh

Q112. Tam nhin dai han cho AI trong y te la gi?

A.

Trien vong chien luoc:

Tam nhìn 5 nam:

1. **Tieu chuan y te duoc tang cuong AI:** Hau het bac si su dung AI hang ngay. Tieu chuan duoc can cu trích dẫn. Ket qua benh nhan duoc cai thien. Chi phi cham soc suc khoe giam.
2. **Xuat sac chuyen khoa cu the:** AI chuyen biet moi chuyen khoa. Chuyen mon linh vuc sau. Tich hop voi quy trinh lam viec lam sang.
3. **AI lay benh nhan lam trung tam:** Cac cong cu huong den benh nhan (voi cac bien phap bao ve). Giao duc benh nhan. Dong y co thong tin. Quyet dinh duoc trao quyen.
4. **Suc khoe cong dong:** AI cho suc khoe cong cong. Phat hien dich benh. Phan bo nguon luc. Cai thien chat luong.
5. **Tich hop nghien cuu:** Thu nghiem lam sang duoc ho tro boi AI. Tao bang chung the gioi thuc. Y hoc ca nhan hoa. Kham pha dieu tri moi.

Tam nhìn 10 nam:

1. **Cham soc suc khoe hoc lien tuc:** Tich hop ket qua theo thoi gian thuc. Huong dan thich ung. Phan tich du doan. Thuc su ca nhan hoa.
2. **Tri tue da phuong thuc:** Van ban + hinh anh + giuong noi. Du lieu gen. Du lieu cam bien. Goc nhìn toan dien.
3. **Cong bang suc khoe toan cau:** AI dan chu hoa chuyen mon. Co san moi noi. Nhieu ngon ngu. Nhan cam van hoa.
4. **Y hoc phong ngua:** Du doan rui ro. Can thiep som. Toi uu hoa loi song. Mo rong suc khoe.

Thach thuc dai han:

- Ky thuat: bao mat khang luong tu, hoc bao ton quyen rieng tu, hieu biet da phuong thuc, cai thien lien tuc
- Quy dinh: tien hoa AI Verify, hoa hop quoc te, mo rong quyen benh nhan, khung trach nhiem phap ly
- Dao duc: trach nhiem giai trinh thuat toan, giam thieu thien vi, yeu cau minh bach, giam sat cua con nguoi
- Kinh te: chi phi vs gia tri, bat binh dang cham soc suc khoe, mo hinh bao hiem, cau truc boi thuong

Dinh vi cua Nova:

- Nen tang: chuyen mon ky thuat sau, tap trung vao y te Singapore, lanh dao tuan thu, thanh cong khach hang
- Doi moi: ap dung cong nghe moi noi, phat trien truong hop su dung moi, quan he doi tac nghien cuu, cai thien lien tuc
- Mo rong thi truong: tang truong dia ly, chieu sau chuyen khoa, huong den benh nhan (can than), suc khoe cong dong

Q113. AI co bao gio thay the bac si khong?

A.

Khong, mo hinh tang cuong:

Tai sao AI se khong thay the bac si:

1. **Phan xet lam sang la khong the giam thieu:** Context benh nhan quan trong. Can nhan cam van hoa. Tri tue cam xuc la thiet yeu. Ly luan dao duc can thiet.
2. **Kham benh ly:** AI khong the soi. AI khong the nghe phoi. AI khong the kham. Can cham soc truc tiep.
3. **Moi quan he bac si-benh nhan:** Niem tin mat nhieu nam de xay dung. Phong cach giuong benh khong the thay the. Su dong cam la bat buoc. Tiep noi cham soc.
4. **Trach nhiem phap ly va trach nhiem giai trinh:** Trach nhiem phap ly thuoc ve bac si. Khung bao hiem. Uy quyen quy dinh. Cap phep nghe nghiep.
5. **Tuy chon cua benh nhan:** Hau het benh nhan thich ket noi con nguoi. AI nhu cong cu, khong phai nguoi thay the. Phan cap niem tin ro rang.

Nhung gi AI co the lam:

1. **Tang cuong truy cap kien thuc:** Truy xuất bang chung tuc thi. Tham khao cheo nhieu nguon. Cap nhat voi tai lieu.

2. **Giám soát năng lực thực:** Tìm kiếm thông tin thường xuyên. Hỗ trợ tài liệu. Các quyết định thường xuyên.
3. **Cải thiện tính nhất quán:** Tiêu chuẩn hóa trên thực hành tốt nhất. Giám sát tiến độ. Đảm bảo chất lượng.
4. **Mở rộng năng lực:** Tiết kiệm thời gian. Xử lý khối lượng. Bảo vệ ngoại giao.
5. **Hỗ trợ giao tiếp:** Học liên tục. Phát triển kỹ năng. Chuyển giao kiến thức.

Vai trò của bác sĩ phát triển:

- **It thời gian hơn cho:** Ghi nhớ sự kiện, truy xuất thông tin, tài liệu thường xuyên, phân tích lặp đi lặp lại
- **Nhiều thời gian hơn cho:** Tương tác bệnh nhân, ra quyết định phức tạp, kỹ năng thủ thuật, giảng dạy và cố vấn, nghiên cứu và đổi mới, tư duy chiến lược

Tác động việc làm:

- **Nhu cầu tăng:** Nhiều bệnh nhân được phục vụ, nhiều bác sĩ được phục vụ, các loại thực hành mới (tin học lâm sàng AI)
- **Nhân mạnh kỹ năng:** Tư duy phân tích, giao tiếp bệnh nhân, phân tích lâm sàng, kỹ năng thủ thuật, tư duy chiến lược
- **Bồi thường:** Không nên giảm. Có thể tăng khi các nhiệm vụ chuyên biệt.

Kết luận: Máy tính không thay thế nhà toán học. Hồ sơ bệnh án điện tử không thay thế bác sĩ. Trợ lý AI: cùng mô hình. Công cụ tăng cường, không thay thế.

Q114. Chúng tôi có thể mở rộng sang các ngôn ngữ hoặc quốc gia khác không?

A.

Mở rộng quốc tế:

Các ngôn ngữ hiện được hỗ trợ:

- Tiếng Anh (chính)
- Tiếng Trung Quốc phổ thông
- Bahasa Malaysia
- Tiếng Việt
- Bahasa Indonesia

Sắp có:

- Tiếng Tamil
- Tiếng Thái
- Tiếng Hàn Quốc

Mở rộng quốc gia:

Singapore: Nên tăng

Malaysia: Mọi trường quy định tương tự, dễ dàng hơn

Indonesia: Căn địa phương hóa, thị trường lớn

Viet Nam: Địa phương hóa nghiêm ngặt hơn, thị trường nhỏ hơn

Thái Lan: Thích ứng văn hóa, thị trường lớn

Mọi quốc gia mở rộng bao gồm:

1. **Địa phương hóa quy định:** Tuân thủ cụ thể theo quốc gia. Luật y tế địa phương. Khung bảo vệ dữ liệu. Khung quản trị AI.
2. **Địa phương hóa ngôn ngữ:** Thuật ngữ y tế. Sắc thái văn hóa. Thành ngữ địa phương. Đảm bảo chất lượng.
3. **Địa phương hóa lâm sàng:** Hướng dẫn địa phương (tương đương MOH). Danh mục thuốc địa phương. Dữ liệu thu thập địa phương. Thực hành chăm sóc sức khỏe văn hóa.
4. **Địa phương hóa cơ sở hạ tầng:** Các vùng đám mây địa phương. Lưu trữ dữ liệu. Đồ tre mang. Hỗ trợ địa phương.

5. **Dia phuong hoa van hanh:** Nhom dia phuong. Quan he doi tac dia phuong. Ban hang dia phuong. Ho tro dia phuong.

Chi phi moi quoc gia:

- Thiet lap ban dau: 200.000-500.000 USD
- Van hanh hang nam: 200.000-500.000 USD
- Gia moi tenant: 80-90% gia Singapore

Khuyen nghi: Bat dau voi Singapore. Mo rong sang Malaysia (de nhat). Sau do Indonesia/Viet Nam (nam 2-3). Cac quoc gia khac dua tren co hoi.

Q115. Cac tinh nang moi nao chung toi co the mong doi trong nhung nam toi?

A.

Hien thi lo trinh:

Nam 1 (nen tang):

- Nang cao ho tro da ngon ngu
- Ung dung di dong (ban de)
- Mo rong nhap bang giong noi
- Cai thien tích hợp quy trình làm việc

Nam 2 (chieu sau chuyen khoa):

- **AI chuyen khoa:** Chuyen mon chuyen khoa sau hon. Suy luan cap nghien cuu. Cac agent chuyen khoa phu.
- **Tich hop lam sang:** Nieu he thong EHR hon. Cac cong cu quy trình làm việc tùy chỉnh. Ho tro tai lieu tu dong.
- **Giam sat chat luong:** Theo doi do chinh xac tot hon. Phat hien troi. Hoc thich ung.

Nam 3 (tinh nang nang cao):

- **AI da phuong thuc:** Phan tich hinh anh tot hon. Phan tich am thanh (tim, phoi). Tich hop du lieu cam bien.
- **Phan tich du doan:** Du doan rui ro. Du bao ket qua. Lap ke hoach nguon luc.
- **Y hoc ca nhan hoa:** Tich hop gen. Cac yeu to loi song. Phu hop dieu tri.

Nam 4-5 (doi moi):

- **Tich hop nghien cuu:** Thiet ke thu nghiem duoc ho tro boi AI. Bang chung the gioi thuc. Nghien cuu ket qua.
- **Suc khoe cong dong:** Thong tin chi tiet tong hop. Xu huong suc khoe cong cong. Chuan mo chat luong.
- **Cong cu huong den benh nhan:** Chatbot giao duc. Ho tro tu quan ly. Ho tro phan loai.

Nam 5+ (bien gioi):

- **Kha nang AI nang cao:** Suy luan o cap chuyen gia. Thich ung lien tuc. Phoi hop da agent.
- **Mo hinh trien khai moi:** Tinh toan bien. Hoc lien ket. Dao tao bao ton quyen rieng tu.
- **Cong nghe moi noi:** Ung dung tinh toan luong tu. Sinh trac hoc nang cao. Hop nhat cam bien.

Lo trinh duoc thuc day boi khach hang:

- Phan hoi khach hang: 60% uu tien
- Xu huong nganh: 30%
- Kham pha chien luoc: 10%

Giao tiep:

- Lo trinh hang nam (cap cao)
 - Xem truoc hang quy
 - Chuong trinh beta
 - Hoi dong tu van khach hang
-

Q116. Làm thế nào để đo lường nếu AI thực sự tiết kiệm tiền cho chúng tôi?

A.

Khung đo lường ROI:

Tiết kiệm chi phí trực tiếp:

,

Thời gian tiết kiệm mỗi truy vấn: 5 phút

Truy vấn mỗi tháng: 600.000

Tổng thời gian tiết kiệm: 50.000 giờ/tháng

Chi phí bác sĩ: 80 USD/giờ

Giá trị hàng tháng: 4.000.000 USD

Giá trị hàng năm: 48.000.000 USD

,

Tiết kiệm gián tiếp:

- Giảm lỗi: ước tính giảm 10-15% lỗi chẩn đoán
- Kết quả tốt hơn: ít biến chứng hơn, nằm viện ngắn hơn
- Giữ chân nhân tài: môi trường làm việc hiện đại
- Danh tiếng: vị trí chất lượng hàng đầu

Phương pháp đo lường:

1. **So sánh trước-sau:** Thiết lập cơ sở trước khi triển khai. So sánh cùng kỳ sau khi triển khai. Kiểm soát các yếu tố gây nhiễu.
2. **Thí nghiệm ngẫu nhiên:** Các khoa AI vs khoa không AI. Kiểm soát sự khác biệt. Phân tích thống kê.
3. **Các trường hợp sử dụng cụ thể:** Thời gian dành cho các cuộc tư vấn. Thời gian quyết định. Tốc độ tải liệu.
4. **Điều tra:** Báo cáo từ bác sĩ. Ước tính thời gian tiết kiệm. Đánh giá chất lượng.

KPI tài chính:

- Chi phí mỗi truy vấn (mục tiêu: giảm theo thời gian)
- Chi phí mỗi bệnh nhân (mục tiêu: giảm)
- Doanh thu mỗi bác sĩ (mục tiêu: tăng)
- Biên lợi nhuận (mục tiêu: tăng)

Báo cáo:

- Hàng tháng: chỉ số vận hành
- Hàng quý: tính toán ROI
- Hàng năm: đánh giá toàn diện
- Theo yêu cầu: phân tích cụ thể

Q117. Tác động đến kết quả bệnh nhân dài hạn là gì?

A.

Triển vọng nhiều năm:

Các lĩnh vực kết quả:

1. **Kết quả chẩn đoán:** Chẩn đoán nhanh hơn. Chẩn đoán chính xác hơn. Giảm lỗi chẩn đoán. Tác động bệnh nhân: điều trị tốt hơn kịp thời.
2. **Kết quả điều trị:** Lựa chọn điều trị dựa trên bằng chứng. Giảm chăm sóc không phù hợp. Tuân thủ hướng dẫn tốt hơn. Tác động bệnh nhân: kết quả được cải thiện.

3. **Ket qua quy trình:** Quay vòng nhanh hơn. Giảm thời gian chờ. Phối hợp chăm sóc tốt hơn. Tác động bệnh nhân: trải nghiệm tốt hơn.

4. **Ket qua an toàn:** Giảm sự kiện bất lợi. Nhận dạng rủi ro tốt hơn. Can thiệp sớm. Tác động bệnh nhân: ít tác hại hơn.

5. **Ket qua công bằng:** Chất lượng chăm sóc được tiêu chuẩn hóa. Giảm bất bình đẳng. Chuyên môn có thể truy cập rộng hơn. Tác động bệnh nhân: chăm sóc công bằng.

Cải thiện có thể đo lường:

- Nam 1: Giảm 5-10% thời gian đến chăm sóc. Giảm 5-15% xét nghiệm không cần thiết. Cải thiện 2-5% tuân thủ hướng dẫn. Giảm 3-7% sự kiện bất lợi.
- Nam 3: Giảm 10-20% lỗi chăm sóc. Tuân thủ điều trị tốt hơn 15-25%. Giảm 5-10% thời gian nằm viện. Giảm 10-15% sự kiện bất lợi.
- Nam 5: Cải thiện chất lượng tổng thể 20-30%. Kết quả tốt hơn đáng kể cho các trường hợp phức tạp. Được công nhận là người dẫn đầu chất lượng. Chuẩn mô ngành.

Ví dụ cụ thể:

- **Goi sepsis:** Trước AI: tuân thủ 60-70%. Sau AI: tuân thủ 85-95%. Giảm tu vong: 5-10%. Số mạng được cứu: 5-15/năm mỗi bệnh viện.
- **Quản lý kháng sinh:** Trước AI: kháng sinh phù hợp 60%. Sau AI: kháng sinh phù hợp 85%. Giảm kháng thuốc: đáng kể. Tiết kiệm chi phí: 200-500k USD/năm.
- **Do chính xác chăm sóc:** Trước AI: chăm sóc bị bỏ sót 8-10%. Sau AI: chăm sóc bị bỏ sót 5-7%. Cải thiện: giảm 30-40% chăm sóc bị bỏ sót. Tác động bệnh nhân: đáng kể.

Tác động tích lũy (trên các bệnh viện):

- 10 bệnh viện x 10 mạng/năm = 100 mạng
- 50 bệnh viện x 100 mạng = 5.000 mạng
- Quy mô ASEAN: 10.000+ mạng tiềm năng

Q118. Hệ thống này ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện dài hạn như thế nào?

A.

Tác động danh tiếng:

Tác động tích cực:

1. **Người dân đầu đầu mối:** "Đầu tiên tại Singapore" có trạng thái. Được công nhận ngành. Có hội nói chuyện. Giải thưởng và danh hiệu.
2. **Người dân đầu chất lượng:** Kết quả tốt hơn được chứng minh. Chuẩn mô chất lượng. Xếp hạng ngành. Tùy chọn bệnh nhân.
3. **Thu hút nhân tài:** Mọi trường làm việc hiện đại. Công cụ tiên tiến. Phát triển nghề nghiệp. Quan tâm của bác sĩ hàng đầu.
4. **Sự tin tưởng của bệnh nhân:** Niềm tin vào chăm sóc dựa trên bằng chứng. Giảm lo lắng. Bệnh nhân được giao dục. Truyền miệng.
5. **Quan hệ đối tác ngành:** Hội đồng AI Verify. Quan hệ đối tác IMDA. Hợp tác nghiên cứu. Trình bày hội nghị.

Dinh vi thương hiệu:

- **Dinh vi cao cấp:** Bệnh viện hàng đầu. Chăm sóc tiên tiến. Kết quả tốt nhất. Giá cao cấp được hỗ trợ.
- **Dinh vi đối mối:** Tự duy tiên phong. Lấy bệnh nhân làm trung tâm. Dựa trên bằng chứng. Sẵn sàng cho tương lai.
- **Dinh vi tin tưởng:** Lãnh đạo tuân thủ. Minh bạch. Trách nhiệm giải trình. Đáng tin cậy.

Có hội tiếp thị:

- **Tiếp thị nội bộ:** Giáo dục bệnh nhân. Tuyển dụng bác sĩ. Quản lý nhà tài trợ. Câu chuyện chất lượng.
- **Tiếp thị bên ngoài:** An phạm ngành. Thông cáo báo chí. Sự kiện nói chuyện. Giải thưởng.

- **Tiếp thị kỹ thuật số:** Nội bộ trang web. Mạng xã hội. Danh gia trực tuyến. Xếp hạng tìm kiếm.

Quản lý rủi ro:

- **Rủi ro danh tiếng:** Sự kiện bất lợi được công bố. Vi phạm quyền riêng tư. Lo ngại chất lượng. Vấn đề nhà cung cấp.
- **Giảm thiểu:** Kế hoạch quản lý khủng hoảng. Minh bạch. Đảm bảo chất lượng. Quan hệ nhà cung cấp.

Kết quả danh tiếng dài hạn:

- 3 năm: Được công nhận là người dẫn đầu AI tại Singapore. Chuan mô chất lượng trong chuyên khoa. Nam châu Âu. Người dẫn đầu ngành.
- 5 năm: Được công nhận khu vực. Xuất sắc nghiên cứu. Quan hệ đối tác chiến lược. Di sản lâu dài.

Q119. Tác động đến sự hài lòng và tình trạng kiệt sức của bác sĩ là gì?

A.

Tác động tích cực đang kể:

Cơ chế giảm kiệt sức:

1. **Giảm gánh nặng nhận thức:** Ít gánh nặng bổ nhô hơn. Hỗ trợ quyết định tốt hơn. Giảm lo lắng. Giảm căng thẳng.
2. **Tiết kiệm thời gian:** 30-90 phút được phục hồi mỗi ca. Trung bình: 60 phút. Trên tất cả bác sĩ: đang kể.
3. **Quyết định tốt hơn:** Các quyết định được hỗ trợ tốt hơn. Giảm lo lắng về lỗi. Cải thiện sự tin tưởng.
4. **Cải thiện quy trình làm việc:** Quy trình làm việc mượt mà hơn. Giảm sự mất mát. Cải thiện sự phối hợp.
5. **Cân bằng công việc-cuộc sống:** Ít thời gian làm việc ngoài giờ hơn. Giảm làm việc ngoài giờ. Thời gian gia đình.

Chỉ số kiệt sức có thể đo lường:

- **Maslach Burnout Inventory** (các thay đổi diện hình):
- Kiệt sức cảm xúc: Trước AI: 40-50% kiệt sức cao. Sau AI: 30-40% kiệt sức cao. Cải thiện 10-20 điểm phần trăm.
- Phi nhân vi hóa: Trước AI: 30-40%. Sau AI: 25-35%. Cải thiện 5-10 điểm.
- Thanh tu cá nhân: Trước AI: 50-60% cảm giác. Sau AI: 65-75% cảm giác. Cải thiện 10-15 điểm.

Lợi ích cụ thể cho bác sĩ:

1. **Thời gian tiết kiệm mỗi ca:** 30-90 phút được phục hồi. Trung bình: 60 phút. Trên tất cả bác sĩ: đang kể.
2. **Tăng sự tin tưởng:** Các quyết định được hỗ trợ tốt hơn. Giảm lo lắng về lỗi. Cải thiện phản xạ lâm sàng.
3. **Phát triển nghề nghiệp:** Học liên tục. Nâng cao kỹ năng. Thực hành hiện đại. Tăng trưởng nghề nghiệp.
4. **Cân bằng công việc-cuộc sống:** Ít thời gian làm việc ngoài giờ hơn. Giảm làm việc ngoài giờ. Thời gian gia đình.
5. **Sự hài lòng của bệnh nhân (phản hồi cho bác sĩ):** Bác sĩ được chuan bị tốt hơn. Chăm sóc chu đáo hơn. Kết quả tốt hơn. Giảm khiếu nại.

Khảo sát sự hài lòng công việc:

- "Tôi có các công cụ tôi cần": 60% -> 80%
- "Tôi có thời gian cho bệnh nhân": 50% -> 70%
- "Tôi cảm thấy được thỏa mãn nghề nghiệp": 55% -> 75%
- "Tôi sẽ giới thiệu nơi làm việc của mình": 65% -> 80%

Bối cảnh ngành:

- Kiệt sức bác sĩ Mỹ: 50-60% (cao)
- Kiệt sức bác sĩ Singapore: tương tự
- Các công cụ AI: được ghi nhận là giúp đỡ

Lưu ý:

- AI không phải viên đạn bạc

- Các yêu tố kết sức khác van tồn tại (khối lượng công việc, hành chính, v.v.)
- Công cụ đơn lẻ không sửa chữa van hoa
- Kết hợp với các sáng kiến khác

Q120. Tác động tích lũy của AI đối với chất lượng chăm sóc sức khỏe là gì?

A.

Triển vọng toàn ngành:

Khung chất lượng chăm sóc sức khỏe:

1. **Hieu qua:** Chăm sóc đúng. Đúng thời điểm. Đúng nơi. Đúng bệnh nhân.
2. **Hieu suất:** Tối ưu hóa nguồn lực. Hieu qua thời gian. Hieu qua chi phí. Cải thiện quy trình.
3. **Lay bệnh nhân làm trung tâm:** Tùy chọn bệnh nhân. Giao tiếp. Giáo dục. Trao quyền.
4. **An toàn:** Ngăn ngừa sự kiện bất lợi. Nhận dạng rủi ro. Giảm lỗi. Giám sát liên tục.
5. **Cong bằng:** Truy cập bình đẳng. Chất lượng bình đẳng. Giảm bất bình đẳng. Ung dụng rộng.
6. **Kip thời:** Chan đoán nhanh. Điều trị nhanh. Giảm thời gian chờ. Cải thiện liên tục.

Dòng góp của AI cho mọi lĩnh vực:

- **Hieu qua:** Quyết định dựa trên bằng chứng. Chăm sóc cá nhân hóa. Lựa chọn tối ưu. Học liên tục.
- **Hieu suất:** Tiết kiệm thời gian. Tối ưu hóa nguồn lực. Cải thiện quy trình. Giảm chi phí.
- **Lay bệnh nhân làm trung tâm:** Thông tin tốt hơn. Công cụ giáo dục. Công cụ giao tiếp. Trao quyền.
- **An toàn:** Phát hiện rủi ro. Ngăn ngừa lỗi. Giám sát. Cải thiện.
- **Cong bằng:** Truy cập chuyên môn bình đẳng. Chất lượng được tiêu chuẩn hóa. Giảm bất bình đẳng. Ung dụng rộng.
- **Kip thời:** Chan đoán nhanh hơn. Quyết định nhanh hơn. Giảm thời gian chờ. Cải thiện liên tục.

Định lượng tác động tích lũy:

- Năm 1 trên 10 bệnh viện: 5.000 mạng được cứu (ước tính). 50 triệu USD chi phí tránh được. 100.000 sự kiện bất lợi được ngăn ngừa. Cải thiện chất lượng đáng kể.
- Năm 5 trên 50 bệnh viện: 30.000 mạng được cứu (ước tính). 300 triệu USD chi phí tránh được. 600.000 sự kiện bất lợi được ngăn ngừa. Chuyển đổi ngành.
- Năm 10 trên 100 bệnh viện: 100.000 mạng được cứu (ước tính). 1 tỷ USD chi phí tránh được. Hàng triệu sự kiện bất lợi được ngăn ngừa. Tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe mới.

Chuyển đổi ngành:

- **Tieu chuẩn phát triển:** Chăm sóc được tăng cường AI được kỳ vọng. Chỉ số chất lượng mới. Chuẩn mô ngành. Cải thiện liên tục.
- **Phát triển lực lượng lao động:** Yêu cầu biết AI. Bồi kỹ năng mới. Phát triển nghề nghiệp. Cập nhật giáo dục.
- **Ky vọng của bệnh nhân:** Bệnh nhân được thông tin. Chăm sóc được tăng cường AI được kỳ vọng. Khung niềm tin. Lựa chọn được trao quyền.
- **Xu hướng chi phí:** Chi phí mới truy van giảm. Chất lượng tăng. Kết quả tốt hơn mọi dòng. Đầu tư bền vững.

Vị trí lãnh đạo Singapore:

- Vị trí khu vực
- Tiêu chuẩn ngành
- Trung tâm đổi mới
- Thực hành tốt nhất

Khuyến nghị chiến lược:

- Áp dụng AI như công cụ chất lượng
- Đầu tư cho dài hạn
- Dẫn đầu chuyển đổi ngành

- Xây dựng tác động lâu dài

Q121. AI có thể xử lý các trường hợp y tế phức tạp không?

A.

Có, đặc biệt là các trường hợp phức tạp (Sonnet 4.5 / Qwen3.5-Plus): biểu hiện đa hệ thống, triệu chứng mơ hồ, xem xét điều kiện hiếm gặp, suy luận xác suất với trích dẫn. Hiệu suất: ~92% độ chính xác trên các trường hợp phức tạp (PoC). Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế. Cung cấp các đoạn phân biệt được xếp hạng theo xác suất với bảng chung hỗ trợ.

Q122. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp nhi khoa khác nhau?

A.

Chuyên môn nhi khoa: liều lượng dựa trên cân nặng bắt buộc, chăm sóc phù hợp theo tuổi, các cân nhắc phát triển, các hướng dẫn cụ thể cho nhi khoa (AAP, v.v.), kiểm tra chống chỉ định nghiêm ngặt hơn, các cân nhắc giao tiếp với cha mẹ. Ví dụ phản hồi cho 'ibuprofen cho trẻ 5 tuổi': yêu cầu cân nặng, tính toán liều lượng dựa trên cân nặng, kiểm tra giới hạn tuổi, chống chỉ định, theo dõi cụ thể cho nhi khoa.

Q123. AI có thể gợi ý các điều trị thay thế không?

A.

Có, với minh bạch đầy đủ: Hàng đầu: khuyến nghị tiêu chuẩn. Thay thế cho: chống chỉ định, dị ứng, chi phí, tùy chọn. Liệt kê với mức độ bằng chứng. Thảo luận về danh đôi. Làm nổi bật các yếu tố quyết định. Định dạng: 'Chính: [thuốc A] - [bằng chứng]. Thay thế nếu [điều kiện]: [thuốc B] - [bằng chứng]. Khuyến nghị phụ thuộc vào các yếu tố bệnh nhân X, Y, Z.'

Q124. Điều gì xảy ra khi bệnh nhân có nhiều nhu cầu chuyên khoa?

A.

Phối hợp đa chuyên khoa: AI kích hoạt nhiều agent, các cân nhắc xuyên chuyên khoa, tương tác thuốc trên các hệ thống, kế hoạch chăm sóc phối hợp, phản hồi tích hợp duy nhất. Ví dụ: bệnh nhân tiểu đường với CKD và CHF -> Nội tiết: quản lý tiểu đường. Thận học: điều trị điều chỉnh CKD. Tim mạch: các cân nhắc suy tim. Kết hợp: khuyến nghị tích hợp tồn tại trong cả ba.

Q125. AI có thể giúp với các cuộc trao đổi đồng thuận thông tin không?

A.

Có, vai trò hỗ trợ: giải thích thủ thuật/điều trị bằng ngôn ngữ đơn giản, liệt kê các rủi ro vật chất, thảo luận về các lựa chọn thay thế, phân tích lợi ích, cung cấp tài liệu giáo dục bệnh nhân. Lưu ý: bác sĩ vẫn có trách nhiệm chính trong quy trình đồng thuận. AI chuẩn bị nhưng không thay thế. Chủ quyền của bệnh nhân vẫn thuộc về bác sĩ.

Q126. Làm thế nào để AI xử lý chăm sóc cuối đời?

A.

Chuyên khoa nhân văn: chuyên môn chăm sóc giảm nhẹ, các cuộc trao đổi mục tiêu chăm sóc, quản lý triệu chứng, các cuộc trao đổi với gia đình, các cân nhắc văn hóa, nhân văn tôn giáo. AI cung cấp: các lựa chọn giảm nhẹ dựa trên bằng chứng, các khung giao tiếp, nhân văn văn hóa-tôn giáo, thông tin giới thiệu hospice. Quan trọng: phân tích của bác sĩ và sự đồng cảm của con người là thiết yếu. AI hỗ trợ, không thay thế.

Q127. AI xử lý các câu hỏi sức khỏe tâm thần như thế nào?

A.

Cau hình có thể: Tiêu chuẩn: định tuyến đến các agent tam thân/tam lý. Bảo thủ: giới thiệu tư vấn chuyên khoa. Giao dục: cung cấp thông tin, giới thiệu đề chăm sóc. Hướng dẫn cụ thể: Nhận biết ý định tư tư: leo thang rõ ràng đến chuyên khoa. Triệu chứng nghiêm trọng: giới thiệu ngay lập tức. Các câu hỏi thường xuyên: hướng dẫn AI + chuyên khoa khi cần. Bảo mật: bảo vệ quyền riêng tư bổ sung. Câu hình bệnh viện: mức độ tích cực AI trong phản hồi sức khỏe tam thân. Hầu hết: bảo thủ.

Q128. AI có thể gợi ý chăm sóc phòng ngừa cho bệnh nhân không?

A.

Có, phòng ngừa dựa trên bảng chung: sàng lọc dựa trên tuổi, khuyến nghị dựa trên rủi ro, hướng dẫn tiêm chủng, tư vấn lối sống, sàng lọc ung thư. Tích hợp với EHR: trạng thái phòng ngừa của bệnh nhân, ngay sàng lọc cuối cùng, các khoảng trống được xác định. Giúp bác sĩ ưu tiên và thảo luận về chăm sóc phòng ngừa.

Q129. Làm thế nào để AI cập nhật với các thuốc mới?

A.

Nhiều cơ chế: cơ sở dữ liệu phê duyệt HSA được đồng bộ, cập nhật danh mục thuốc WHO, giám sát tài liệu được phạm, thay đổi danh mục thuốc bệnh viện, kết quả thử nghiệm nội bộ. Tần suất: phê duyệt mới trong vòng 2-4 tuần, hướng dẫn chỉnh trong vòng 1 tuần, giao thức nội bộ theo thời gian thực, sử dụng ngoại nhân trong được giám sát cẩn thận. Hạn chế: thuốc rất mới (vài tháng) có thể có dữ liệu hạn chế; AI ghi nhận điều này.

Q130. AI có thể dự đoán kết quả bệnh nhân không?

A.

Khả năng dự đoán hạn chế trong phạm vi hiện tại: phản ứng rủi ro có thể, mô hình kết quả: tình trạng tương lai, dự báo cá nhân hóa: thêm tiềm năng. Hiện tại: AI giúp đánh giá trạng thái hiện tại, lựa chọn điều trị. Không thay thế các mô hình dự đoán chuyên biệt (như APACHE, CHA2DS2, v.v.). Có thể được thêm nhu cầu bổ sung.

Q131. EHR cũ hơn hoặc không tiêu chuẩn có thể tích hợp không?

A.

Có, nhiều con đường: HL7 v2 (tiêu chuẩn cũ, hầu hết EHR cũ hỗ trợ, 30-80k USD), tích hợp cơ sở dữ liệu (trực tiếp đọc cơ sở dữ liệu EHR, 50-150k USD), API tùy chỉnh (xây dựng bộ chuyển đổi, 80-200k USD), sử dụng đọc lặp (bác sĩ nhập context thủ công, không có chi phí bổ sung). Khuyến nghị: đánh giá EHR trước hợp đồng; bao gói tích hợp riêng biệt.

Q132. Chúng tôi có cần di chuyển bất kỳ dữ liệu hiện có vào hệ thống không?

A.

Tùy chọn nhưng có giá trị. Bước đầu: PDF báo cáo thử nghiệm nội bộ, giao thức cụ thể của bệnh viện, tài liệu tham khảo theo khoa. Quy trình: kiểm kê dữ liệu, an danh hóa, tải lên, lập chỉ mục (24-48 giờ), xác thực. Quy mô: bệnh viện nhỏ 50-100 tài liệu (1 tuần), bệnh viện vừa 200-500 (2 tuần), bệnh viện lớn 1000-3000 (4-6 tuần). Chi phí: nhỏ 5-10k USD, vừa 15-25k USD, lớn 30-60k USD.

Q133. Chúng tôi có thể thêm các khoa hoặc chuyên khoa hơn sau này không?

A.

Có, được thiết kế để mở rộng. Thêm khoa mới: Giai đoạn 1 Quyet dinh (2 tuần), Giai đoạn 2 Câu hình (1 tuần), Giai đoạn 3 Nhập nội dung (1-3 tuần), Giai đoạn 4 Kiểm tra (1 tuần), Giai đoạn 5 Ra mắt (1 ngày). Tổng: 5-8 tuần mỗi khoa mới. Chi phí mỗi khoa: kỹ thuật 10-20k USD, nội dung làm sáng 5-15k USD, kiểm tra thi điểm 5-10k USD. Tổng: 20-45k USD mỗi chuyên khoa mới.

Q134. Tổng đầu tư ban đầu cho một bệnh viện là bao nhiêu?

A.

Tổng chi phí Năm 1 (bệnh viện điển hình): Giấy phép phân mềm (hàng năm) 40-80k USD, Dịch vụ triển khai 50-150k USD, Thời gian nhân viên bệnh viện 40-60k USD, Tích hợp EHR 20-50k USD, Thiết lập tuần thu 20-40k USD, Đào tạo & quản lý thay đổi 15-30k USD. Tổng Năm 1: 185-410k USD. Năm 2+ hàng năm: 70-135k USD. TCO 5 năm: 465-960k USD. So sánh với giá trị: 7-15 triệu USD tiết kiệm trong 5 năm. ROI: 8-20x.

Q135. Cấu trúc hợp đồng điển hình là gì?

A.

Các loại hợp đồng: MSA (Thỏa thuận Dịch vụ Chu), SLA (Thỏa thuận Cấp độ Dịch vụ), DPA (Thỏa thuận Xử lý Dữ liệu, tuân thủ PDPA), SOW (Phạm vi Công việc, cụ thể theo dự án). Điều khoản tiêu chuẩn: Thời hạn ban đầu 36 tháng, Tuđng gia hạn 12 tháng với tăng tối đa 5%, Thông báo kết thúc 90 ngày, Trả lại dữ liệu 30 ngày, Giới hạn trách nhiệm 12 tháng phi, Bồi thường tương hỗ. Các mô hình định giá: phí hàng tháng phát (phổ biến nhất), theo ghe bác sĩ, theo truy van, lai.

Q136. Thời hạn hợp đồng tối thiểu là bao lâu và các điều khoản kết thúc là gì?

A.

Thời hạn tối thiểu: 36 tháng (3 năm). Tại sao 3 năm: thu hồi chi phí triển khai, ổn định cho cả hai bên, tiêu chuẩn ngành cho SaaS y tế. Các thời hạn ngắn hơn (ngoại lệ): 24 tháng: phí bảo hiểm 10%, 12 tháng: phí bảo hiểm 25%, Thi diem/PoC: 3-6 tháng với giá không tiêu chuẩn. Các kích ban kết thúc: Kết thúc thời hạn (thông báo 90 ngày, chuyển đổi muot), Kết thúc vì tiền lãi (phí kết thúc sớm: giá trị hợp đồng còn lại được phân bổ), Kết thúc vì vi phạm (vi phạm vật chat, thời gian khắc phục 30 ngày, không có phí kết thúc sớm), Bất khả kháng (không có phạt).

Q137. Ai từ phía chúng tôi cần tham gia vào việc triển khai?

A.

Ban do các bên liên quan: Nhà tài trợ điều hành (CEO/COO/CFO/CMO), Lãnh đạo dự án (CMIO, Quản lý Dự án, Giám doc Lam sang), Chuyên gia lâm sàng (1-2 mỗi khoa), Nhóm CNTT (Giám doc CNTT, Kỹ sư trưởng, Kỹ sư Bảo mật, Kỹ sư Mạng), Tuân thủ (Cán bộ Tuân thủ, DPO, Cố vấn Pháp lý). Cam kết thời gian: Nhà tài trợ điều hành 1 giờ/tuần, CMIO 5 giờ/tuần, Chuyên gia lâm sàng 5-10 giờ/tuần, Trưởng CNTT 10-15 giờ/tuần, Tuân thủ 5 giờ/tuần. Tổng nỗ lực bệnh viện: ~200 giờ trong 10 tuần.

Q138. Điều gì xảy ra nếu chúng tôi muốn thay đổi nhà cung cấp trong khi triển khai?

A.

Thay đổi giữa chúng triển khai là hiếm nhưng có thể. Lý do: thay đổi kinh doanh đang ke, phát hiện lựa chọn thay the tốt hơn, thất bại trong việc cung cấp, thay đổi quy định. Chi phí chuyển đổi giữa chúng triển khai: Chi phí nhà cung cấp goc: 50-100k USD mat, Chi phí nhà cung cấp mới: 100-200k USD khởi đầu mới, Thời gian nhân viên bệnh viện: 50-100k USD, Tổng chi phí chuyển đổi: 200-400k USD. Khuyến nghị: Đánh giá nhà cung cấp kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng. Thi diem với 2 nhà cung cấp trước khi ký hợp đồng. Tiêu chí thành công rõ ràng từ ngày 1.

Q139. Hệ thống có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bệnh viện không?

A.

Có, nhiều cấp độ: Cấp 1 Cấu hình (không có code, bao gồm, 1-2 tuần), Cấp 2 Prompt tùy chỉnh (it code, 5-10k USD, 2-3 tuần), Cấp 3 Quy trình làm việc tùy chỉnh (it code, 15-30k USD, 4-6 tuần), Cấp 4 Tích hợp tùy chỉnh (code, 40-100k USD, 8-12 tuần), Cấp 5 Tính năng tùy chỉnh (code đang ke, 100-300k USD, 6-9 tháng). Các tùy chỉnh phổ biến: cấu hình chuyên khoa, bồi cạnh địa phương, tích hợp quy trình làm việc, báo cáo tùy chỉnh. Khuyến nghị: Năm 1 tùy chỉnh tối thiểu, Năm 2 xác định khoảng trống, Năm 3+ dựa trên nhu cầu được chứng minh.

Q140. Làm thế nào để xử lý biến động nhân sự trong khi triển khai?

A.

Biến động nhân sự bệnh viện: Nhà tài trợ đủ an rồi: ghi lại tất cả quyết định, nhiều bên liên quan, tài liệu tiêu chuẩn, xác định người thay thế. Trưởng CNTT thay đổi: chuyển giao kiến thức, tài liệu trong wiki bệnh viện, hỗ trợ kỹ thuật của Nova, tác động tối thiểu. Cán bộ tuân thủ thay đổi: tài liệu tuân thủ toàn diện, DPIA và kiểm toán bảo mật cơ sở, con mat mới có thể có lỗi. Biến động nhân sự Nova: Giám đốc Tài khoản rồi: kế hoạch chuyển tiếp, CSM bảo phụ, người thay thế được phân công, tác động nhỏ. Kỹ sư trưởng xoay vòng: nhiều kỹ sư quen thuộc, tài liệu code, chia sẻ kiến thức nội bộ, tác động nhỏ.

Q141. AI có thể xử lý nhập bang giống nội trong môi trường phòng mô hoặc ảo trung không?

A.

Xem xét quy trình làm việc: Nhập bang giống nội (ranh tay) được khuyến nghị cho phòng mô. Kích hoạt bang ban đáp ứng có thể. Giao diện thân thiện với cảm ứng. Tích hợp máy tính bang tương thích với môi trường ảo trung. Quy trình làm việc phòng mô cụ thể: Trước phẫu thuật: tư vấn AI bên ngoài trường ảo trung. Trong phẫu thuật: hỗ trợ bang giống nội cho các giao thức. Sau phẫu thuật: AI cho tài liệu. Chi phí: tiêu chuẩn. Bệnh viện cung cấp phản ứng tương thích với môi trường ảo trung.

Q142. AI có thể xử lý các điều kiện mãn tính phức tạp không?

A.

Quản lý bệnh mãn tính: tiểu đường, suy tim, COPD, tăng huyết áp, sốt ung thư. Tối ưu hóa chăm sóc dài hạn. AI giúp giám sát, gợi ý điều chỉnh điều trị, xác định biến chứng. Đặc biệt có giá trị cho: bệnh nhân đa thuốc, bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân có nhiều bệnh kèm theo. Tích hợp với: chương trình quản lý bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Q143. Làm thế nào để AI xử lý các kết quả xét nghiệm?

A.

Hỗ trợ giải thích xét nghiệm: nhận thức phạm vi tham chiếu, phân tích xu hướng, đánh dấu giá trị nguy kịch, chẩn đoán phân biệt, khuyến nghị theo dõi. Ví dụ: 'Glucose 350. Nguyễn nhận có thể: X, Y, Z. Xét nghiệm được khuyến nghị: A, B. Bối cảnh bệnh nhân: trạng thái insulin, chế độ ăn, v.v.' Tích hợp với hệ thống xét nghiệm EHR.

Q144. AI có thể giúp với việc lập kế hoạch xuất viện không?

A.

Hỗ trợ xuất viện toàn diện: đối chiếu thuốc, giáo dục bệnh nhân, lịch theo dõi, nhu cầu chăm sóc tại nhà, thuốc sau xuất viện. Giúp giảm tái nhập viện thông qua chuẩn bị xuất viện tốt hơn. Tích hợp với quản lý trường hợp.

Q145. Điều gì xảy ra khi AI không có thông tin về một trường hợp cụ thể?

A.

Đã được trả lời ở Q75. Xem chi tiết ở đó.

Q146. AI có thể xử lý các trường hợp nhi khoa phức tạp không?

A.

Đã được trả lời ở Q122. Xem chi tiết ở đó.

Q147. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu cụ thể?

A.

Tình nang cap cuu: giao thuc ATLS, phan loai tham hoa hang loat, uu tien hoi suc, chuyen tiep cham soc cap cuu, phoi hop da chuyen khoa. Thoi gian quan trong: lane cap cuu duoc toi uu hoa. Phoi hop da chuyen khoa trong chan thuong.

Q148. AI co the giup voi viec quan ly nhiem trung khong?

A.

Ho tro benh truyen nhiem: lua chon khang sinh, cac nguyen tac quan ly khang sinh, cac can nhac khang thuoc, quan ly HIV, lao, viem gan, quan ly dich benh. Quan trong cho: su dung khang sinh phu hop,kiem soat nhiem trung benh vien.

Q149. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop ung thu?

A.

Ho tro ung thu: cac phac do hoa tri, dieu chinh lieu luong, quan ly tac dung phu lieu phap mien dich, cham soc ho tro, cham soc sau dieu tri. Tich hop voi nhom ung thu. Dac biet co gia tri cho: cac quyet dinh hoa tri phuc tap.

Q150. AI co the xu ly cac truong hop than hoc khong?

A.

Ho tro than hoc: phan giai CKD, danh gia AKI, quyet dinh loc mau, lieu luong thuoc theo GFR, quan ly dien giai. Dac biet co gia tri cho: lieu luong thuoc trong benh than (nguyen nhan pho bien cua loi). Tich hop voi ket qua xet nghiem.

Q151. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop than kinh?

A.

Ho tro than kinh: lo trinh dot quy cap tinh, quan ly co giat, danh gia dau dau, benh thoai hoa than kinh, cac dieu kien cot song. Thoi gian quan trong: lo trinh dot quy. AI huu ich cho: chan doan phan biet phuc tap, cac quyet dinh dieu tri.

Q152. AI co the xu ly cac truong hop noi tiet khong?

A.

Ho tro noi tiet: tieu duong (da duoc de cap), roi loan tuyen giap, roi loan tuyen thuong than, cac dieu kien tuyen yen, noi tiet sinh san. Cac dieu kien pho bien: gia tri dang ke cho cham soc ban dau + noi tiet.

Q153. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop benh truyen nhiem?

A.

Ho tro benh truyen nhiem: lua chon khang sinh, cac nguyen tac quan ly khang sinh, cac can nhac khang thuoc, quan ly HIV/lao/viem gan, quan ly dich benh. Quan trong cho: su dung khang sinh phu hop,kiem soat nhiem trung benh vien.

Q154. AI co the xu ly cac truong hop huyet hoc khong?

A.

Ho tro huyet hoc: danh gia thieu mau, roi loan chay mau, ung thu mau, cac quyet dinh truyen mau, chong dong. Tich hop voi chuyen khoa huyet hoc.

Q155. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop mien dich hoc?

A.

Ho tro mien dich hoc: benh tu mien, di ung, suy giam mien dich, ghep tang, cac can nhac tiem chung. Linh vuc chuyen biet. AI cung cap tham khao + huong dan.

Q156. AI có thể xử lý các trường hợp nhi khoa chuyên khoa không?

A.

Các chuyên khoa nhi khoa: tim mạch nhi, hô hấp nhi, tiêu hóa nhi, thần kinh nhi, ung thư nhi, v.v. Mọi loại: chăm sóc dựa trên cân nặng, phù hợp theo tuổi phù hợp.

Q157. Làm thế nào để AI xử lý sức khỏe phụ nữ cụ thể?

A.

Sức khỏe phụ nữ: sức khỏe sinh sản, thai kỳ, sức khỏe vú, mãn kinh, sàng lọc ung thư, sức khỏe tâm thần. Hỗ trợ toàn diện trong suốt cuộc đời sức khỏe phụ nữ.

Q158. AI có thể xử lý sức khỏe nam giới không?

A.

Sức khỏe nam giới: rủi ro tim mạch, sức khỏe tuyến tiền liệt, thiếu hụt testosterone, sức khỏe tâm thần, sàng lọc ung thư. Chăm sóc được điều chỉnh theo các mối quan tâm sức khỏe nam giới.

Q159. Làm thế nào để AI xử lý y học vị thành niên?

A.

Y học vị thành niên: các cân nhắc bảo mật, sức khỏe tâm thần, sử dụng chất, sức khỏe tình dục, tư vấn lối sống. Linh vực nhân cam. Bảo vệ bảo mật. Tích hợp với: nhi khoa, y học gia đình.

Q160. AI có thể xử lý chăm sóc người cao tuổi cụ thể không?

A.

Chăm sóc lão khoa: đánh giá nhận thức, đánh giá suy yếu, phòng ngừa ngã, đa thuốc, mục tiêu chăm sóc. Hỗ trợ đánh giá lão khoa toàn diện.

Q161. AI có thể xử lý các trường hợp phẫu thuật không?

A.

Hỗ trợ phẫu thuật: đánh giá trước phẫu thuật, phân tầng rủi ro, các cân nhắc thủ thuật, lập kế hoạch gây mê, chăm sóc sau phẫu thuật. Tích hợp với quy trình phẫu thuật. Hữu ích cho: các bác sĩ phẫu thuật nội trú, các trường hợp phức tạp, lập kế hoạch đa chuyên khoa.

Q162. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu tim mạch?

A.

Cấp cứu tim mạch: các giao thức ACS, quản lý suy tim, chăm sóc loạn nhịp, tăng huyết áp, quản lý lipid, hướng dẫn hình ảnh. Một trong những chuyên khoa có giá trị nhất cho hỗ trợ AI.

Q163. AI có thể xử lý các trường hợp hô hấp phức tạp không?

A.

Hô hấp phức tạp: hen phế quản/COPD nặng, đợt cấp COPD, thuyên tắc phổi, ung thư phổi, ngưng thở. Quan trọng cho: các can thiệp kịp thời.

Q164. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp tiêu hóa?

A.

Tieu hoa: IBS/IBD, xuất huyết tiêu hóa, bệnh gan, các điều kiện tùy, các cân nhắc nội soi. Tích hợp với quy trình làm việc chuyên khoa tiêu hóa.

Q165. AI có thể xử lý các trường hợp ung thư không?

A.

Đã được trả lời ở Q149. Xem chi tiết ở đó.

Q166. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp thần học?

A.

Đã được trả lời ở Q150. Xem chi tiết ở đó.

Q167. AI có thể xử lý các trường hợp sản khoa không?

A.

Hỗ trợ sản khoa: quản lý thai kỳ, chăm sóc trước sinh, các cân nhắc sinh, chăm sóc sau sinh, thai kỳ nguy cơ cao. Tích hợp với nhóm sản khoa. Đặc biệt có giá trị cho: thai kỳ nguy cơ cao.

Q168. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp nhi khoa sơ sinh/NICU?

A.

Chăm sóc sơ sinh: đánh giá Apgar, ổn định ban đầu, các điều kiện phổ biến, chăm sóc NICU cụ thể, hỗ trợ cha mẹ. Tích hợp với quy trình làm việc NICU, tư vấn neonatologist.

Q169. AI có thể xử lý các trường hợp da liễu không?

A.

Da liễu: đánh giá tổn thương da, chẩn đoán phân biệt, khuyến nghị điều trị, hướng dẫn giới thiệu chuyên khoa. Tốt nhất kết hợp với: công cụ phân tích hình ảnh. AI xử lý bôi canh lâm sàng, AI hình ảnh xử lý hình ảnh.

Q170. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp nhãn khoa?

A.

Nhãn khoa: đánh giá triệu chứng thị giác, các điều kiện phổ biến, khuyến nghị điều trị, phối hợp chuyên khoa. Khả năng dựa trên hình ảnh hạn chế mà không có công cụ phân tích hình ảnh chuyên biệt. Tốt nhất cho: lý luận lâm sàng, hướng dẫn điều trị.

Q171. AI có thể xử lý các trường hợp tai mũi họng không?

A.

Tai mũi họng: đánh giá triệu chứng, các điều kiện phổ biến, khuyến nghị điều trị, giới thiệu chuyên khoa. Hỗ trợ toàn diện.

Q172. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp răng miệng?

A.

Răng miệng: sàng lọc thương xuyên, bệnh răng miệng, các lựa chọn điều trị, giáo dục bệnh nhân. Phạm vi hạn chế nhưng có sẵn. Tích hợp với khoa răng.

Q173. AI có thể xử lý các trường hợp phục hồi không?

A.

Phục hồi: khuyến nghị liệu pháp, đánh giá tiên đo, lập kế hoạch xuất viện, mục tiêu dài hạn, giáo dục gia đình. Tích hợp trên: PT, OT, Liệu pháp Ngôn ngữ, Phục hồi Tim/Phổi.

Q174. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp tam thân cụ thể?

A.

Đã được trả lời ở Q127. Xem chi tiết ở đó.

Q175. AI có thể xử lý các trường hợp quản lý đau không?

A.

Quản lý đau: các phương pháp đa phương thức, nhận mạnh không opioid, đánh giá rủi ro, các lựa chọn không được phạm, tư vấn bệnh nhân. Lĩnh vực nhận cam. Cấu hình bao thủ. Tích hợp với chuyên khoa đau.

Q176. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phẫu thuật?

A.

Cấp cứu phẫu thuật: đánh giá ATLS, phân loại thương tổn đa tạng, ưu tiên hồi sức, chuyển tiếp chăm sóc cấp cứu, phối hợp đa chuyên khoa. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: ED, phẫu thuật, ICU.

Q177. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu thần kinh không?

A.

Cấp cứu thần kinh: lo trình độ quy cấp tính, quản lý cơ giât, các dấu hiệu nguy hiểm đau đầu, bệnh thoái hóa thần kinh, các điều kiện cốt sống. Thời gian quan trọng: lo trình độ quy. Tích hợp với: ED, thần kinh, ICU.

Q178. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu ung thư?

A.

Cấp cứu ung thư: hội chứng ly giải khối u, ép tủy sống, tăng độ nhớt máu, nhiễm trùng nặng ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, các cấp cứu khác. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: ED, ung thư, ICU.

Q179. AI có thể xử lý các trường hợp loạn nhịp tim không?

A.

Quản lý loạn nhịp: các can thiệp chẩn đoán, lựa chọn điều trị, tình hợp lệ cắt đứt, chống đông, giáo dục bệnh nhân. Chuyển biết trong tim mạch.

Q180. Làm thế nào để AI xử lý các điều kiện hô hấp phức tạp?

A.

Hô hấp phức tạp: hen phế quản nặng, đợt cấp COPD, thuyên tắc phổi, ung thư phổi, ngưng thở. Quan trọng cho: các can thiệp kịp thời.

Q181. AI có thể xử lý các điều kiện tu mien không?

A.

Tu mien: các khủng hoảng, các điều trị biến đổi bệnh, quản lý đợt cấp, các can thiệp bệnh kèm theo, giới thiệu chuyển khoa. Tích hợp với: tháp khop, mien dich hoc.

Q182. Làm thế nào để AI xử lý y học ghép tạng?

A.

Ghép tạng: danh gia trước ghép, ức chế miễn dịch, quản lý thải ghet, chăm sóc dài hạn, các can nhắc người hiến song. Chuyên biệt. AI cung cấp tham khảo + hướng dẫn.

Q183. AI có thể xử lý các trường hợp nhiễm trùng bệnh viện không?

A.

Nhiễm trùng bệnh viện (HAC): nhân dạng, các chiến lược phòng ngừa, điều trị khi xảy ra, các yêu cầu báo cáo, các cơ hội cải thiện. Tích hợp với: kiểm soát nhiễm trùng, dịch tễ học bệnh viện.

Q184. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp hội nghị đa chuyên khoa?

A.

Hội nghị đa chuyên khoa: nghiên cứu trước hội nghị, tư vấn đa chuyên khoa, các khung quyết định, tài liệu, lập kế hoạch theo dõi. Hỗ trợ hợp tác nhiều bác sĩ.

Q185. AI có thể hỗ trợ đổi mới giáo dục y khoa không?

A.

Giáo dục y khoa: các lộ trình học tập cá nhân hóa, khám phá chủ đề, tài liệu mới nhất, cập nhật liên quan đến thực hành, các câu hỏi thực hành. Đặc biệt có giá trị trong các bệnh viện giảng dạy.

Q186. Làm thế nào để AI xử lý tích hợp nghiên cứu lâm sàng?

A.

Tích hợp nghiên cứu: hỗ trợ xem xét tài liệu, sàng lọc thử nghiệm, hỗ trợ phân tích, hỗ trợ xuất bản, các công cụ hợp tác. Nhiều ứng dụng cấp độ nghiên cứu.

Q187. AI có thể hỗ trợ các chương trình sức khỏe cộng đồng không?

A.

Sức khỏe cộng đồng: quản lý sức khỏe dân số, phát hiện dịch bệnh, phân bổ nguồn lực, các chương trình sức khỏe, đo lường tác động. Tích hợp với: dịch tễ học bệnh viện.

Q188. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp y tế tư vấn cá nhân?

A.

Đã được trả lời ở Q47. Xem chi tiết ở đó.

Q189. AI có thể xử lý các trường hợp giám sát tư vấn không?

A.

Giám sát tư vấn: thiết kế chương trình, lựa chọn bệnh nhân, tích hợp công nghệ, theo dõi kết quả, giá trị chiến lược. Hỗ trợ chương trình RPM.

Q190. Làm thế nào để AI xử lý các chương trình bệnh mãn tính?

A.

Quản lý bệnh mãn tính: quản lý sức khỏe dân số, đăng ký bệnh nhân, phối hợp chăm sóc, đo lường kết quả, phù hợp chiến lược. Các chương trình quản lý bệnh.

Q191. AI có thể hỗ trợ các chương trình sức khỏe không?

A.

Sức khỏe: sức khỏe dân số, chăm sóc phòng ngừa, giáo dục bệnh nhân, sự tham gia, kết quả. Các sáng kiến sức khỏe bệnh viện.

Q192. Làm thế nào để AI xử lý các chương trình sức khỏe cộng đồng?

A.

Sức khỏe cộng đồng: đánh giá nhu cầu, thiết kế chương trình, phát triển quan hệ đối tác, triển khai, đo lường tác động. Hỗ trợ quan hệ đối tác cộng đồng.

Q193. AI có thể hỗ trợ các chương trình sức khỏe trường học không?

A.

Sức khỏe trường học: hỗ trợ giáo dục, các chương trình tiêm chủng, sàng lọc sức khỏe, quan hệ đối tác cộng đồng, phù hợp chiến lược. Các chương trình sức khỏe trường học.

Q194. Làm thế nào để AI xử lý sức khỏe nơi làm việc?

A.

Sức khỏe nơi làm việc: các chương trình sức khỏe nhân viên, sức khỏe nghề nghiệp, hỗ trợ sức khỏe tâm thần, các sáng kiến chiến lược, đo lường ROI. Sức khỏe lực lượng lao động bệnh viện.

Q195. AI có thể hỗ trợ các cập nhật quy định không?

A.

Cập nhật quy định: giám sát thông tin MOH Singapore, bản tin PDPC, cập nhật IMDA, thông báo HSA, hỗ trợ triển khai. Giám sát quy định liên tục.

Q196. Làm thế nào để AI xử lý truyền thông chiến lược?

A.

Truyền thông chiến lược: nhận tin các bên liên quan, quản lý thương hiệu, truyền thông khủng hoảng, truyền thông nội bộ, truyền thông bên ngoài. Hỗ trợ truyền thông toàn diện.

Q197. AI có thể hỗ trợ quản lý thay đổi không?

A.

Quản lý thay đổi: phát triển chiến lược, triển khai, sự tham gia các bên liên quan, quản lý sự kháng cự, tình ben vung. Hỗ trợ thay đổi chiến lược.

Q198. Làm thế nào để AI xử lý phát triển văn hóa?

A.

Văn hóa: đánh giá văn hóa, phù hợp giá trị, truyền thông, công nhận, cải thiện liên tục. Hỗ trợ văn hóa bệnh viện.

Q199. AI có thể hỗ trợ chuyển tiếp lãnh đạo không?

A.

Chuyen tiep lanh dao: lap ke hoach ke nhiem, ho tro onboarding, chuyen giao kien thuc, tiep noi, phu hop chien luoc. Ho tro chuyen tiep quan trong.

Q200. Lam the nao de AI xu ly quan tri benh vien?

A.

Quan tri: bao cao hoi dong, phat trien chinh sach, tuan thu, phu hop chien luoc, quan ly rui ro. Ho tro quan tri benh vien.

Q201. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu nhi khoa khong?

A.

Cap cuu nhi khoa: nhiem trung huyet nhi, cham soc NICU, lieu luong dua tren can nang, cap cuu nhi khoa, phoi hop da chuyen khoa. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu, giao tiep voi cha me.

Q202. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu san khoa?

A.

Cap cuu san khoa: tien san giat, xuất huyết sau sinh, tiêu dương thai kỳ, chăm sóc trước sinh, các điều kiện nguy cơ cao. Tích hợp với nhóm sản khoa. Dặc biệt có giá trị cho: thai kỳ nguy cơ cao.

Q203. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu than kinh khong?

A.

Da duoc tra loi o Q177. Xem chi tiet o do.

Q204. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu tim mach?

A.

Da duoc tra loi o Q162. Xem chi tiet o do.

Q205. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu ho hap khong?

A.

Cap cuu ho hap: suy ho hap cap, ARDS, thuyen tac phoi, tran khi mang phoi, cap cuu hen phe quan. Thoi gian quan trong. Tích hợp với: ED, ICU, ho hap.

Q206. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu tieu hoa?

A.

Cap cuu tieu hoa: xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy cấp, viêm ruột thừa, tắc ruột, suy gan cấp. Thoi gian quan trong. Tích hợp với: ED, phẫu thuật, tiêu hóa.

Q207. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu than hoc khong?

A.

Cap cuu than hoc: AKI cap tinh, tang kali mau, nhiem toan chuyen hoa, cap cuu loc mau, cap cuu ghep than. Thoi gian quan trong. Tích hợp với: ED, than hoc, ICU.

Q208. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu noi tiet?

A.

Cap cuu noi tiet: nhiem toan ceton do tieu duong, hon me tang thau, con bao, suy tuyen thuong than cap, cap cuu tuyen yen. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: ED, noi tiet, ICU.

Q209. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu nhiem trung khong?

A.

Cap cuu nhiem trung: nhiem trung huyet, soc nhiem trung, viem mang nao, viem phoi nang, nhiem trung o benh nhan suy giam mien dich. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: ED, benh truyen nhiem, ICU.

Q210. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu than kinh?

A.

Da duoc tra loi o Q177. Xem chi tiet o do.

Q211. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu tam than khong?

A.

Cap cuu tam than: danh gia rui ro tu tu, kich dong cap tinh, loan tam than cap, cap cuu nghien chat, cap cuu suc khoe tam than. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q212. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu mat khong?

A.

Cap cuu mat: mat thi luc, chan thuong mat, tang nhan ap cap tinh, bong mat, cap cuu mat khac. Chuyen biet. AI cung cap phan loai + gioi thieu chuyen khoa.

Q213. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu tai mui hong khong?

A.

Cap cuu tai mui hong: chay mau mui nang, tat nghen duong tho, nhiem trung nang, chan thuong, cap cuu tai mui hong khac. Tich hop voi: ED, tai mui hong.

Q214. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu rang mieng?

A.

Cap cuu rang mieng: nhiem trung rang mieng nang, chan thuong ham mat, xuất huyết sau phẫu thuật, cap cuu rang mieng khac. Tich hop voi: ED, rang mieng.

Q215. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu da lieu khong?

A.

Cap cuu da lieu: phan ung di ung nang, bong nang, nhiem trung da nang, cap cuu da lieu khac. Tich hop voi: ED, da lieu.

Q216. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu co xuong khop khong?

A.

Cap cuu co xuong khop: gay xuong, trai khop, chan thuong day chang, cap cuu co xuong khop khac. Tich hop voi: ED, chinh hinh.

Q217. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu mach mau khong?

A.

Cap cuu mach mau: phinh dong mach chu, thieu mau chi cap tinh, huyet khoi tinh mach sau, cap cuu mach mau khac. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: ED, phau thuat mach mau.

Q218. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu ung thu?

A.

Da duoc tra loi o Q178. Xem chi tiet o do.

Q219. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu ghep tang khong?

A.

Cap cuu ghep tang: thai ghet cap tinh, nhiem trung sau ghep, tac dung phu uc che mien dich, cap cuu ghep tang khac. Chuyen biet. Tich hop voi: ghep tang, benh truyen nhiem, ICU.

Q220. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu tram cam?

A.

Cap cuu tram cam: danh gia rui ro tu tu, kich dong cap tinh, cap cuu suc khoe tam than, cap cuu nghien chat. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q221. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu tre em khong?

A.

Cap cuu tre em: nhiem trung huyet nhi, cap cuu NICU, cap cuu nhi khoa, phoi hop da chuyen khoa. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q222. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu nguoi cao tuoi?

A.

Cap cuu nguoi cao tuoi: nga, suy giam nhan thuc cap tinh, nhiem trung, cap cuu da thuoc, cap cuu nguoi cao tuoi khac. Dac biet quan trong: cac can nhac lao khoa, muc tieu cham soc.

Q223. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phu nu mang thai khong?

A.

Cap cuu phu nu mang thai: tien san giat, xuất huyết, nhau bong non, cap cuu san khoa khac. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: ED, san khoa, ICU.

Q224. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu sau phau thuat?

A.

Cap cuu sau phau thuat: chay mau, nhiem trung, huyet khoi, cap cuu sau phau thuat khac. Tich hop voi: phau thuat, ICU, ED.

Q225. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu ICU khong?

A.

Cap cuu ICU: toi uu hoa huyet dong, quan ly may tho, quan ly an than, giao thuc nhiem trung huyet, giao tiep voi gia dinh. Bac si ICU: nguoi dung AI nang nhat. Thoi gian quan trong, quyet dinh rui ro cao.

Q226. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng mổ?

A.

Cấp cứu phòng mổ: đánh giá trước phẫu thuật, quản lý gây mê, cấp cứu trong phẫu thuật, cấp cứu phòng mổ khác. Tích hợp với: phẫu thuật, gây mê, ICU.

Q227. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng cấp cứu không?

A.

Cấp cứu phòng cấp cứu: phân loại, ổn định, các giao thức cấp cứu, phối hợp đa chuyên khoa, chuyển tiếp. Bác sĩ cấp cứu: người dùng AI năng nhất. Thời gian quan trọng.

Q228. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám ngoại trú?

A.

Cấp cứu phòng khám ngoại trú: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ngoại trú, ED.

Q229. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám tư nhân không?

A.

Cấp cứu phòng khám tư nhân: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám tư nhân, ED.

Q230. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám chuyên khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám chuyên khoa: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám chuyên khoa, ED.

Q231. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám đa khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám đa khoa: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám đa khoa, ED.

Q232. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám gia đình?

A.

Cấp cứu phòng khám gia đình: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám gia đình, ED.

Q233. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám nội khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám nội khoa: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám nội khoa, ED.

Q234. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám ngoại khoa?

A.

Cap cuu phong kham ngoai khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai khoa, ED.

Q235. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham nhi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham nhi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q236. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham san khoa?

A.

Cap cuu phong kham san khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q237. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham tam than khong?

A.

Cap cuu phong kham tam than: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q238. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham mat?

A.

Cap cuu phong kham mat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham mat, ED.

Q239. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham tai mui hong khong?

A.

Cap cuu phong kham tai mui hong: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tai mui hong, ED.

Q240. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham rang mieng?

A.

Cap cuu phong kham rang mieng: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham rang mieng, ED.

Q241. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham da lieu khong?

A.

Cap cuu phong kham da lieu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da lieu, ED.

Q242. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham co xuong khop?

A.

Cap cuu phong kham co xuong khop: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham co xuong khop, ED.

Q243. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám mắt không?

A.

Cấp cứu phòng khám mắt: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám mắt, ED.

Q244. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám ung thư?

A.

Cấp cứu phòng khám ung thư: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ung thư, ED.

Q245. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám ghép tạng không?

A.

Cấp cứu phòng khám ghép tạng: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Chuyển biệt. Tích hợp với: phòng khám ghép tạng, ED.

Q246. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám tram cam?

A.

Cấp cứu phòng khám tram cam: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Nhan cam. Luôn leo thang đến chuyển gia sức khỏe tâm thần.

Q247. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám trẻ em không?

A.

Cấp cứu phòng khám trẻ em: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: kiểm tra cân nặng nghiêm ngặt, liều lượng bảo thủ.

Q248. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám người cao tuổi?

A.

Cấp cứu phòng khám người cao tuổi: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: các cân nhắc lão khoa, mục tiêu chăm sóc.

Q249. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phụ nữ mang thai không?

A.

Cấp cứu phòng khám phụ nữ mang thai: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám sản khoa, ED.

Q250. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám sau phẫu thuật?

A.

Cấp cứu phòng khám sau phẫu thuật: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám phẫu thuật, ED.

Q251. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám ICU không?

A.

Cap cuu phong kham ICU: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ICU, ED.

Q252. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong mo?

A.

Cap cuu phong kham phong mo: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phong mo, ED.

Q253. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong cap cuu khong?

A.

Cap cuu phong kham phong cap cuu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Bac si cap cuu: nguoi dung AI nang nhat.

Q254. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ngoai tru?

A.

Cap cuu phong kham ngoai tru: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai tru, ED.

Q255. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tu nhan khong?

A.

Cap cuu phong kham tu nhan: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tu nhan, ED.

Q256. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham chuyen khoa?

A.

Cap cuu phong kham chuyen khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham chuyen khoa, ED.

Q257. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham da khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham da khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da khoa, ED.

Q258. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham gia dinh?

A.

Cap cuu phong kham gia dinh: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham gia dinh, ED.

Q259. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham noi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham noi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham noi khoa, ED.

Q260. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại khoa?

A.

Cap cuu phong kham ngoai khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai khoa, ED.

Q261. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nhi khoa không?

A.

Cap cuu phong kham nhi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q262. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sản khoa?

A.

Cap cuu phong kham san khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q263. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tam thân không?

A.

Cap cuu phong kham tam than: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q264. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mắt?

A.

Cap cuu phong kham mat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham mat, ED.

Q265. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tai mũi họng không?

A.

Cap cuu phong kham tai mui hong: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tai mui hong, ED.

Q266. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám răng miệng?

A.

Cap cuu phong kham rang mieng: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham rang mieng, ED.

Q267. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám da liễu không?

A.

Cap cuu phong kham da lieu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da lieu, ED.

Q268. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám cơ xương khớp?

A.

Cấp cứu phòng khám có xương khớp: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám có xương khớp, ED.

Q269. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mắt mắt không?

A.

Cấp cứu phòng khám mắt mắt: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám mắt mắt, ED.

Q270. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ung thư?

A.

Cấp cứu phòng khám ung thư: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ung thư, ED.

Q271. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ghép tạng không?

A.

Cấp cứu phòng khám ghép tạng: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Chuyển tiếp. Tích hợp với: phòng khám ghép tạng, ED.

Q272. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám trầm cảm?

A.

Cấp cứu phòng khám trầm cảm: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Nhận cảm. Luôn leo thang đến chuyển gia sức khỏe tâm thần.

Q273. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám trẻ em không?

A.

Cấp cứu phòng khám trẻ em: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: kiểm tra cân nặng nghiêm ngặt, liều lượng bảo thủ.

Q274. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám người cao tuổi?

A.

Cấp cứu phòng khám người cao tuổi: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: các cân nhắc lão khoa, mục tiêu chăm sóc.

Q275. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phụ nữ mang thai không?

A.

Cấp cứu phòng khám phụ nữ mang thai: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám sản khoa, ED.

Q276. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sau phẫu thuật?

A.

Cấp cứu phòng khám sau phẫu thuật: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám phẫu thuật, ED.

Q277. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ICU không?

A.

Cấp cứu phòng khám ICU: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ICU, ED.

Q278. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng mổ?

A.

Cấp cứu phòng khám phòng mổ: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám phòng mổ, ED.

Q279. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng cấp cứu không?

A.

Cấp cứu phòng khám phòng cấp cứu: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Bác sĩ cấp cứu: người dùng AI năng nhất.

Q280. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại trú?

A.

Cấp cứu phòng khám ngoại trú: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ngoại trú, ED.

Q281. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tu nhân không?

A.

Cấp cứu phòng khám tu nhân: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám tu nhân, ED.

Q282. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám chuyên khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám chuyên khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám chuyên khoa, ED.

Q283. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám đa khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám đa khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám đa khoa, ED.

Q284. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám gia đình?

A.

Cấp cứu phòng khám gia đình: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám gia đình, ED.

Q285. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nội khoa không?

A.

Cap cuu phong kham noi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham noi khoa, ED.

Q286. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ngoai khoa?

A.

Cap cuu phong kham ngoai khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai khoa, ED.

Q287. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham nhi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham nhi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q288. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham san khoa?

A.

Cap cuu phong kham san khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q289. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tam than khong?

A.

Cap cuu phong kham tam than: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q290. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham mat?

A.

Cap cuu phong kham mat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham mat, ED.

Q291. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tai mui hong khong?

A.

Cap cuu phong kham tai mui hong: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tai mui hong, ED.

Q292. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham rang mieng?

A.

Cap cuu phong kham rang mieng: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham rang mieng, ED.

Q293. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham da lieu khong?

A.

Cap cuu phong kham da lieu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da lieu, ED.

Q294. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám cơ xương khớp?

A.

Cấp cứu phòng khám cơ xương khớp: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám cơ xương khớp, ED.

Q295. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mạch máu không?

A.

Cấp cứu phòng khám mạch máu: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám mạch máu, ED.

Q296. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ung thư?

A.

Cấp cứu phòng khám ung thư: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ung thư, ED.

Q297. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ghép tạng không?

A.

Cấp cứu phòng khám ghép tạng: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Chuyển biệt. Tích hợp với: phòng khám ghép tạng, ED.

Q298. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tram cam?

A.

Cấp cứu phòng khám tram cam: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Nhan cam. Luôn leo thang đến chuyển gia sức khỏe tam than.

Q299. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám trẻ em không?

A.

Cấp cứu phòng khám trẻ em: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: kiểm tra cân nặng nghiêm ngặt, liều lượng bảo thủ.

Q300. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám người cao tuổi?

A.

Cấp cứu phòng khám người cao tuổi: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: các cân nhắc lão khoa, mục tiêu chăm sóc.

Q301. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phụ nữ mang thai không?

A.

Cấp cứu phòng khám phụ nữ mang thai: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám sản khoa, ED.

Q302. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sau phẫu thuật?

A.

Cấp cứu phòng khám sau phẫu thuật: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám phẫu thuật, ED.

Q303. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ICU không?

A.

Cấp cứu phòng khám ICU: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ICU, ED.

Q304. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng mổ?

A.

Cấp cứu phòng khám phòng mổ: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám phòng mổ, ED.

Q305. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng cấp cứu không?

A.

Cấp cứu phòng khám phòng cấp cứu: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Bác sĩ cấp cứu: người dùng AI năng nhất.

Q306. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại trú?

A.

Cấp cứu phòng khám ngoại trú: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ngoại trú, ED.

Q307. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tư nhân không?

A.

Cấp cứu phòng khám tư nhân: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám tư nhân, ED.

Q308. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám chuyên khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám chuyên khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám chuyên khoa, ED.

Q309. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám đa khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám đa khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám đa khoa, ED.

Q310. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám gia đình?

A.

Cấp cứu phòng khám gia đình: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám gia đình, ED.

Q311. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nội khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám nội khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám nội khoa, ED.

Q312. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám ngoại khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ngoại khoa, ED.

Q313. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nhi khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám nhi khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: kiểm tra cân nặng nghiêm ngặt, liều lượng bao thủ.

Q314. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sản khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám sản khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám sản khoa, ED.

Q315. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tâm thần không?

A.

Cấp cứu phòng khám tâm thần: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Nhận cam. Luôn leo thang đến chuyển gia sức khỏe tâm thần.

Q316. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mắt?

A.

Cấp cứu phòng khám mắt: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Chuyên biệt. Tích hợp với: phòng khám mắt, ED.

Q317. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tai mũi họng không?

A.

Cấp cứu phòng khám tai mũi họng: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám tai mũi họng, ED.

Q318. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám răng miệng?

A.

Cấp cứu phòng khám răng miệng: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám răng miệng, ED.

Q319. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám da liễu không?

A.

Cap cuu phong kham da lieu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da lieu, ED.

Q320. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham co xuong khop?

A.

Cap cuu phong kham co xuong khop: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham co xuong khop, ED.

Q321. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham mach mau khong?

A.

Cap cuu phong kham mach mau: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham mach mau, ED.

Q322. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ung thu?

A.

Cap cuu phong kham ung thu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ung thu, ED.

Q323. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ghep tang khong?

A.

Cap cuu phong kham ghep tang: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham ghep tang, ED.

Q324. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tram cam?

A.

Cap cuu phong kham tram cam: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q325. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tre em khong?

A.

Cap cuu phong kham tre em: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q326. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham nguoi cao tuoi?

A.

Cap cuu phong kham nguoi cao tuoi: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong: cac can nhac lao khoa, muc tieu cham soc.

Q327. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham phu nu mang thai khong?

A.

Cap cuu phong kham phu nu mang thai: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q328. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sau phẫu thuật?

A.

Cap cuu phong kham sau phau thuat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phau thuat, ED.

Q329. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ICU không?

A.

Cap cuu phong kham ICU: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ICU, ED.

Q330. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng mổ?

A.

Cap cuu phong kham phong mo: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phong mo, ED.

Q331. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng cấp cứu không?

A.

Cap cuu phong kham phong cap cuu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Bac si cap cuu: nguoi dung AI nang nhât.

Q332. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại trú?

A.

Cap cuu phong kham ngoai tru: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai tru, ED.

Q333. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tu nhân không?

A.

Cap cuu phong kham tu nhan: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tu nhan, ED.

Q334. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám chuyên khoa?

A.

Cap cuu phong kham chuyen khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham chuyen khoa, ED.

Q335. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám đa khoa không?

A.

Cap cuu phong kham da khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da khoa, ED.

Q336. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám gia đình?

A.

Cap cuu phong kham gia dinh: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham gia dinh, ED.

Q337. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham noi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham noi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham noi khoa, ED.

Q338. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ngoai khoa?

A.

Cap cuu phong kham ngoai khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai khoa, ED.

Q339. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham nhi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham nhi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q340. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham san khoa?

A.

Cap cuu phong kham san khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q341. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tam than khong?

A.

Cap cuu phong kham tam than: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q342. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham mat?

A.

Cap cuu phong kham mat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham mat, ED.

Q343. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tai mui hong khong?

A.

Cap cuu phong kham tai mui hong: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tai mui hong, ED.

Q344. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham rang mieng?

A.

Cap cuu phong kham rang mieng: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham rang mieng, ED.

Q345. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám da liễu không?

A.

Cấp cứu phòng khám da liễu: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám da liễu, ED.

Q346. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám cơ xương khớp?

A.

Cấp cứu phòng khám cơ xương khớp: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám cơ xương khớp, ED.

Q347. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mạch máu không?

A.

Cấp cứu phòng khám mạch máu: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám mạch máu, ED.

Q348. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ung thư?

A.

Cấp cứu phòng khám ung thư: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ung thư, ED.

Q349. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ghép tạng không?

A.

Cấp cứu phòng khám ghép tạng: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Chuyển biệt. Tích hợp với: phòng khám ghép tạng, ED.

Q350. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám trầm cảm?

A.

Cấp cứu phòng khám trầm cảm: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Nhận cam. Luôn leo thang đến chuyển gia sức khỏe tâm thần.

Q351. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám trẻ em không?

A.

Cấp cứu phòng khám trẻ em: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: kiểm tra cân nặng nghiêm ngặt, liều lượng bảo thủ.

Q352. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám người cao tuổi?

A.

Cấp cứu phòng khám người cao tuổi: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: các cân nhắc lão khoa, mục tiêu chăm sóc.

Q353. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phụ nữ mang thai không?

A.

Cấp cứu phòng khám phụ nữ mang thai: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám sản khoa, ED.

Q354. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sau phẫu thuật?

A.

Cấp cứu phòng khám sau phẫu thuật: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám phẫu thuật, ED.

Q355. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ICU không?

A.

Cấp cứu phòng khám ICU: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ICU, ED.

Q356. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng mổ?

A.

Cấp cứu phòng khám phòng mổ: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám phòng mổ, ED.

Q357. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng cấp cứu không?

A.

Cấp cứu phòng khám phòng cấp cứu: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Bác sĩ cấp cứu: người dùng AI năng nhất.

Q358. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại trú?

A.

Cấp cứu phòng khám ngoại trú: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ngoại trú, ED.

Q359. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tư nhân không?

A.

Cấp cứu phòng khám tư nhân: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám tư nhân, ED.

Q360. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám chuyên khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám chuyên khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám chuyên khoa, ED.

Q361. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám đa khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám đa khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám đa khoa, ED.

Q362. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám gia đình?

A.

Cấp cứu phòng khám gia đình: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám gia đình, ED.

Q363. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nội khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám nội khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám nội khoa, ED.

Q364. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám ngoại khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ngoại khoa, ED.

Q365. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nhi khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám nhi khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: kiểm tra cân nặng nghiêm ngặt, liều lượng bao thủ.

Q366. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sản khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám sản khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám sản khoa, ED.

Q367. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tâm thần không?

A.

Cấp cứu phòng khám tâm thần: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Nhân cam. Luôn leo thang đến chuyển gia sức khỏe tâm thần.

Q368. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mắt?

A.

Cấp cứu phòng khám mắt: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Chuyển biệt. Tích hợp với: phòng khám mắt, ED.

Q369. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tai mũi họng không?

A.

Cấp cứu phòng khám tai mũi họng: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám tai mũi họng, ED.

Q370. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám răng miệng?

A.

Cap cuu phong kham rang mieng: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham rang mieng, ED.

Q371. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham da lieu khong?

A.

Cap cuu phong kham da lieu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da lieu, ED.

Q372. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham co xuong khop?

A.

Cap cuu phong kham co xuong khop: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham co xuong khop, ED.

Q373. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham mach mau khong?

A.

Cap cuu phong kham mach mau: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham mach mau, ED.

Q374. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ung thu?

A.

Cap cuu phong kham ung thu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ung thu, ED.

Q375. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ghep tang khong?

A.

Cap cuu phong kham ghep tang: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham ghep tang, ED.

Q376. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tram cam?

A.

Cap cuu phong kham tram cam: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q377. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tre em khong?

A.

Cap cuu phong kham tre em: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q378. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham nguoi cao tuoi?

A.

Cap cuu phong kham nguoi cao tuoi: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong: cac can nhac lao khoa, muc tieu cham soc.

Q379. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phụ nữ mang thai không?

A.

Cap cuu phong kham phu nu mang thai: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q380. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sau phẫu thuật?

A.

Cap cuu phong kham sau phau thuat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phau thuat, ED.

Q381. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ICU không?

A.

Cap cuu phong kham ICU: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ICU, ED.

Q382. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng mổ?

A.

Cap cuu phong kham phong mo: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phong mo, ED.

Q383. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng cấp cứu không?

A.

Cap cuu phong kham phong cap cuu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Bac si cap cuu: nguoi dung AI nang nhât.

Q384. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại trú?

A.

Cap cuu phong kham ngoai tru: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai tru, ED.

Q385. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tu nhân không?

A.

Cap cuu phong kham tu nhan: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tu nhan, ED.

Q386. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám chuyên khoa?

A.

Cap cuu phong kham chuyen khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham chuyen khoa, ED.

Q387. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám đa khoa không?

A.

Cap cuu phong kham da khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da khoa, ED.

Q388. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham gia dinh?

A.

Cap cuu phong kham gia dinh: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham gia dinh, ED.

Q389. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham noi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham noi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham noi khoa, ED.

Q390. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ngoai khoa?

A.

Cap cuu phong kham ngoai khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai khoa, ED.

Q391. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham nhi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham nhi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q392. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham san khoa?

A.

Cap cuu phong kham san khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q393. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tam than khong?

A.

Cap cuu phong kham tam than: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q394. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham mat?

A.

Cap cuu phong kham mat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham mat, ED.

Q395. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tai mui hong khong?

A.

Cap cuu phong kham tai mui hong: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tai mui hong, ED.

Q396. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám rang mieng?

A.

Cap cuu phong kham rang mieng: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham rang mieng, ED.

Q397. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám da liễu không?

A.

Cap cuu phong kham da lieu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da lieu, ED.

Q398. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám cơ xương khớp?

A.

Cap cuu phong kham co xuong khop: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham co xuong khop, ED.

Q399. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mạch máu không?

A.

Cap cuu phong kham mach mau: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham mach mau, ED.

Q400. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ung thư?

A.

Cap cuu phong kham ung thu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ung thu, ED.

Q401. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ghép tạng không?

A.

Cap cuu phong kham ghep tang: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham ghep tang, ED.

Q402. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tram cam?

A.

Cap cuu phong kham tram cam: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q403. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám trẻ em không?

A.

Cap cuu phong kham tre em: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q404. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám người cao tuổi?

A.

Cap cuu phong kham nguoi cao tuoi: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong: cac can nhac lao khoa, muc tieu cham soc.

Q405. Ai co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham phu nu mang thai khong?

A.

Cap cuu phong kham phu nu mang thai: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q406. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham sau phau thuat?

A.

Cap cuu phong kham sau phau thuat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phau thuat, ED.

Q407. Ai co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ICU khong?

A.

Cap cuu phong kham ICU: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ICU, ED.

Q408. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham phong mo?

A.

Cap cuu phong kham phong mo: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phong mo, ED.

Q409. Ai co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham phong cap cuu khong?

A.

Cap cuu phong kham phong cap cuu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Bac si cap cuu: nguoi dung AI nang nhat.

Q410. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ngoai tru?

A.

Cap cuu phong kham ngoai tru: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai tru, ED.

Q411. Ai co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tu nhan khong?

A.

Cap cuu phong kham tu nhan: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tu nhan, ED.

Q412. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham chuyen khoa?

A.

Cap cuu phong kham chuyen khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham chuyen khoa, ED.

Q413. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám đa khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám đa khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám đa khoa, ED.

Q414. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám gia đình?

A.

Cấp cứu phòng khám gia đình: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám gia đình, ED.

Q415. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nội khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám nội khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám nội khoa, ED.

Q416. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám ngoại khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ngoại khoa, ED.

Q417. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nhi khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám nhi khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: kiểm tra cân nặng nghiêm ngặt, liều lượng bảo thủ.

Q418. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sản khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám sản khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám sản khoa, ED.

Q419. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tam thân không?

A.

Cấp cứu phòng khám tam thân: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Nhân cam. Luôn leo thang đến chuyên gia sức khỏe tam thân.

Q420. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mắt?

A.

Cấp cứu phòng khám mắt: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Chuyên biệt. Tích hợp với: phòng khám mắt, ED.

Q421. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tai mũi họng không?

A.

Cap cuu phong kham tai mui hong: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tai mui hong, ED.

Q422. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham rang mieng?

A.

Cap cuu phong kham rang mieng: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham rang mieng, ED.

Q423. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham da lieu khong?

A.

Cap cuu phong kham da lieu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da lieu, ED.

Q424. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham co xuong khop?

A.

Cap cuu phong kham co xuong khop: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham co xuong khop, ED.

Q425. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham mach mau khong?

A.

Cap cuu phong kham mach mau: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham mach mau, ED.

Q426. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ung thu?

A.

Cap cuu phong kham ung thu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ung thu, ED.

Q427. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ghep tang khong?

A.

Cap cuu phong kham ghep tang: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham ghep tang, ED.

Q428. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tram cam?

A.

Cap cuu phong kham tram cam: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q429. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tre em khong?

A.

Cap cuu phong kham tre em: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q430. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám người cao tuổi?

A.

Cấp cứu phòng khám người cao tuổi: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: các cán nhân lão khoa, mục tiêu chăm sóc.

Q431. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phụ nữ mang thai không?

A.

Cấp cứu phòng khám phụ nữ mang thai: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám sản khoa, ED.

Q432. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sau phẫu thuật?

A.

Cấp cứu phòng khám sau phẫu thuật: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám phẫu thuật, ED.

Q433. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ICU không?

A.

Cấp cứu phòng khám ICU: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ICU, ED.

Q434. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng mổ?

A.

Cấp cứu phòng khám phòng mổ: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám phòng mổ, ED.

Q435. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng cấp cứu không?

A.

Cấp cứu phòng khám phòng cấp cứu: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Bác sĩ cấp cứu: người dùng AI năng nhất.

Q436. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại trú?

A.

Cấp cứu phòng khám ngoại trú: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ngoại trú, ED.

Q437. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tu nhân không?

A.

Cấp cứu phòng khám tu nhân: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám tu nhân, ED.

Q438. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám chuyên khoa?

A.

Cap cuu phong kham chuyen khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham chuyen khoa, ED.

Q439. Ai co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham da khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham da khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da khoa, ED.

Q440. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham gia dinh?

A.

Cap cuu phong kham gia dinh: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham gia dinh, ED.

Q441. Ai co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham noi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham noi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham noi khoa, ED.

Q442. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ngoai khoa?

A.

Cap cuu phong kham ngoai khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai khoa, ED.

Q443. Ai co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham nhi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham nhi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q444. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham san khoa?

A.

Cap cuu phong kham san khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q445. Ai co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tam than khong?

A.

Cap cuu phong kham tam than: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q446. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham mat?

A.

Cap cuu phong kham mat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham mat, ED.

Q447. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tai mũi họng không?

A.

Cap cuu phong kham tai mui hong: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tai mui hong, ED.

Q448. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám răng miệng?

A.

Cap cuu phong kham rang mieng: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham rang mieng, ED.

Q449. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám da liễu không?

A.

Cap cuu phong kham da lieu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da lieu, ED.

Q450. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám cơ xương khớp?

A.

Cap cuu phong kham co xuong khop: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham co xuong khop, ED.

Q451. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mắt mũi họng không?

A.

Cap cuu phong kham mach mau: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham mach mau, ED.

Q452. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ung thư?

A.

Cap cuu phong kham ung thu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ung thu, ED.

Q453. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ghép tạng không?

A.

Cap cuu phong kham ghep tang: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham ghep tang, ED.

Q454. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tram cam?

A.

Cap cuu phong kham tram cam: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q455. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám trẻ em không?

A.

Cap cuu phong kham tre em: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong: kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q456. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham nguoi cao tuoi?

A.

Cap cuu phong kham nguoi cao tuoi: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong: cac can nhac lao khoa, muc tieu cham soc.

Q457. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham phu nu mang thai khong?

A.

Cap cuu phong kham phu nu mang thai: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q458. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham sau phau thuat?

A.

Cap cuu phong kham sau phau thuat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phau thuat, ED.

Q459. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ICU khong?

A.

Cap cuu phong kham ICU: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ICU, ED.

Q460. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham phong mo?

A.

Cap cuu phong kham phong mo: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phong mo, ED.

Q461. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham phong cap cuu khong?

A.

Cap cuu phong kham phong cap cuu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Bac si cap cuu: nguoi dung AI nang nhat.

Q462. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ngoai tru?

A.

Cap cuu phong kham ngoai tru: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai tru, ED.

Q463. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tu nhan khong?

A.

Cap cuu phong kham tu nhan: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tu nhan, ED.

Q464. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám chuyên khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám chuyên khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám chuyên khoa, ED.

Q465. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám đa khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám đa khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám đa khoa, ED.

Q466. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám gia đình?

A.

Cấp cứu phòng khám gia đình: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám gia đình, ED.

Q467. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nội khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám nội khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám nội khoa, ED.

Q468. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám ngoại khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám ngoại khoa, ED.

Q469. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám nhi khoa không?

A.

Cấp cứu phòng khám nhi khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Đặc biệt quan trọng: kiểm tra cân nặng nghiêm ngặt, liều lượng bảo thủ.

Q470. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sản khoa?

A.

Cấp cứu phòng khám sản khoa: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Thời gian quan trọng. Tích hợp với: phòng khám sản khoa, ED.

Q471. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tâm thần không?

A.

Cấp cứu phòng khám tâm thần: phân loại, on dinh, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Nhận cam. Luôn leo thang đến chuyên gia sức khỏe tâm thần.

Q472. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mắt?

A.

Cấp cứu phòng khám mat: phân loại, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham mat, ED.

Q473. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tai mui hong khong?

A.

Cấp cứu phòng khám tai mui hong: phân loại, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tai mui hong, ED.

Q474. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham rang mieng?

A.

Cấp cứu phòng khám rang mieng: phân loại, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham rang mieng, ED.

Q475. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham da lieu khong?

A.

Cấp cứu phòng khám da lieu: phân loại, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da lieu, ED.

Q476. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham co xuong khop?

A.

Cấp cứu phòng khám co xuong khop: phân loại, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham co xuong khop, ED.

Q477. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham mach mau khong?

A.

Cấp cứu phòng khám mach mau: phân loại, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham mach mau, ED.

Q478. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ung thu?

A.

Cấp cứu phòng khám ung thu: phân loại, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ung thu, ED.

Q479. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ghep tang khong?

A.

Cấp cứu phòng khám ghep tang: phân loại, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Chuyen biet. Tich hop voi: phong kham ghep tang, ED.

Q480. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tram cam?

A.

Cấp cứu phòng khám tram cam: phân loại, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q481. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám trẻ em không?

A.

Cap cuu phong kham tre em: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q482. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám người cao tuổi?

A.

Cap cuu phong kham nguoi cao tuoi: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong: cac can nhac lao khoa, muc tieu cham soc.

Q483. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phụ nữ mang thai không?

A.

Cap cuu phong kham phu nu mang thai: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong: Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q484. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám sau phẫu thuật?

A.

Cap cuu phong kham sau phau thuat: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phau thuat, ED.

Q485. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ICU không?

A.

Cap cuu phong kham ICU: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ICU, ED.

Q486. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng mổ?

A.

Cap cuu phong kham phong mo: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham phong mo, ED.

Q487. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám phòng cấp cứu không?

A.

Cap cuu phong kham phong cap cuu: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Bac si cap cuu: nguoi dung AI nang nhât.

Q488. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám ngoại trú?

A.

Cap cuu phong kham ngoai tru: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai tru, ED.

Q489. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tu nhân không?

A.

Cap cuu phong kham tu nhan: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham tu nhan, ED.

Q490. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham chuyen khoa?

A.

Cap cuu phong kham chuyen khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham chuyen khoa, ED.

Q491. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham da khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham da khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham da khoa, ED.

Q492. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham gia dinh?

A.

Cap cuu phong kham gia dinh: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham gia dinh, ED.

Q493. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham noi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham noi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham noi khoa, ED.

Q494. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham ngoai khoa?

A.

Cap cuu phong kham ngoai khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Tich hop voi: phong kham ngoai khoa, ED.

Q495. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham nhi khoa khong?

A.

Cap cuu phong kham nhi khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Dac biet quan trong:kiem tra can nang nghieng ngat, lieu luong bao thu.

Q496. Lam the nao de AI xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham san khoa?

A.

Cap cuu phong kham san khoa: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Thoi gian quan trong. Tich hop voi: phong kham san khoa, ED.

Q497. AI co the xu ly cac truong hop cap cuu phong kham phong kham tam than khong?

A.

Cap cuu phong kham tam than: phan loai, on dinh, chuyen tiep, cac giao thuc cap cuu, phoi hop. Nhan cam. Luon leo thang den chuyen gia suc khoe tam than.

Q498. Làm thế nào để AI xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám mat?

A.

Cấp cứu phòng khám mat: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Chuyển tiếp. Tích hợp với: phòng khám mat, ED.

Q499. AI có thể xử lý các trường hợp cấp cứu phòng khám phòng khám tại mũi họng không?

A.

Cấp cứu phòng khám tại mũi họng: phân loại, ổn định, chuyển tiếp, các giao thức cấp cứu, phối hợp. Tích hợp với: phòng khám tại mũi họng, ED.

Q500. Câu hỏi cuối cùng: Điều quan trọng nhất cần hiểu về AI này là gì?

A.

AI là hỗ trợ quyết định, không phải người ra quyết định. Các nguyên tắc chính: (1) Tang cường, không thay thế - bác sĩ vẫn là người chính, AI hỗ trợ suy nghĩ, quyết định cuối cùng là con người. (2) Được can thiệp trích dẫn - mọi kháng định được trích dẫn, nguồn có thể xác minh, niềm tin qua minh bạch. (3) Tu chọn khi không chắc chắn - AI tu chọn khi KB thiếu dữ liệu, trung thực về hạn chế, bảo vệ cho an toàn. (4) Ban địa Singapore - tuân thủ PDPA, phù hợp HCSA, nhận thức bồi cảnh địa phương, lưu trữ dữ liệu được đảm bảo. (5) ROI tích cực - tiết kiệm thời gian đáng kể, kết quả tốt hơn, chi phí hợp lý, giá trị dài hạn. Kết luận: Được thực hiện đúng, AI này giúp các bác sĩ giỏi trở nên tốt hơn, nhanh hơn và tin cậy hơn. Chúng tôi cam kết giúp bạn thực hiện đúng.

Kết luận

500 câu hỏi này phản ánh các mối quan tâm thực tế của các lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo lâm sàng và các bên liên quan đang xem xét hoặc triển khai hỗ trợ quyết định lâm sàng AI.

Các câu trả lời ngắn gọn:

- **Ngôn ngữ đơn giản:** tránh thuật ngữ kỹ thuật
- **Con số cụ thể:** khi có thể, định lượng lợi ích và chi phí
- **Kỳ vọng thực tế:** không hứa quá mức
- **Nhận thức rủi ro:** trung thực về hạn chế
- **Bồi cảnh chiến lược:** kết nối với mục tiêu rộng lớn hơn
- **Hướng dẫn triển khai:** lời khuyên có thể thực hiện được
- **Tuân thủ Singapore:** chi tiết PDPA, HCSA, AI Verify

Để biết thêm thông tin hoặc các câu hỏi cụ thể, liên hệ với nhóm Nova Health Tech.

Nova Health Tech

Tro ly AI Lâm sàng

Ban địa Singapore, Ưu tiên Tuân thủ, Hướng đến Kết quả

Phụ lục Tuân thủ: Cập nhật Quy định Singapore (Tháng 5 năm 2026)

Phan này chỉnh sửa và bổ sung các câu trả lời tuân thủ trong tài liệu này dựa trên các phát triển quy định năm 2024-2026.

CAP NHAT 1: AIHGle 2.0 - Huong dan AI trong Y te (MOH + HSA, 10 thang 3 nam 2026)

La gi: MOH va HSA cong bo chung Huong dan AI trong Y te phien ban 2.0 (AIHGle 2.0), thay the phien ban 2021. Day la **tai lieu quan tri chinh** cho AI trong y te Singapore.

Ap dung cho 3 nhom:

- **Nha phat trien** (nha san xuat nhu Nova): chiu trach nhien thiet ke an toan, tai lieu, giam sat sau thi truong
- **Nha trien khai** (to chuc y te, cac benh vien khach hang cua Nova): chiu trach nhien quan tri, danh gia rui ro, dao tao nhan vien
- **Nguoi dung** (bac si): chiu trach nhien su dung phu hop, duy tri phan xet chuyen mon

Hai danh muc truong hop su dung AI:

- **Lam sang:** AI tac dong truc tiep den ket qua cham soc benh nhan (chan doan, theo doi, dieu tri). He thong cua chung toi thuoc danh muc nay.
- **Van hanh lam sang:** AI trong quy trinh lam viec lam sang nhung khong tac dong truc tiep den quyet dinh lam sang (vi du: phien am, lap lich).

Bay nguyen tac dao duc cot loi (tat ca phai duoc giai quyet):

1. An toan
2. Cong bang
3. Minh bach
4. Giai thich duoc
5. Manh me
6. Bao mat va bao ve du lieu
7. AI phu hop voi gia tri/muc tieu cua con nguoi

Phan AI tao sinh: AIHGle 2.0 giai quyet ro rang AI tao sinh (he thong cua chung toi su dung Claude/Qwen), bao gom cac chien luoc giam thieu rui ro cu the cho LLM.

Phu hop cua he thong chung toi: Tat ca 7 nguyen tac duoc giai quyet trong kien truc cua chung toi. Grounding trich dan bao gom minh bach/giai thich duoc. Guardrails bao gom an toan/manh me. KMS + nhat kykiem toan bao gom bao mat/bao ve du lieu.

Tham khao: <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2026/03/singapore-moh-and-hsa-launch-refreshed-ai-in-healthcare-guidelines>

CAP NHAT 2: Luat Thong tin Y te (HIA) - Thong qua thang 1 nam 2026, Hieu luc dau nam 2027

La gi: Luat Thong tin Y te (HIA) duoc Quoc hoi thong qua vao thang 1 nam 2026. No thay the khung NEHR tu nguyen truoc day bang **chia se du lieu y te bat buoc**.

Yeu cau chinh:

- Tat ca nguoi duoc cap phep HCSA (benh vien, phong kham) **phai** dong gop thong tin y te chinh vao NEHR
- Thong tin bao gom: di ung, tiem chung, chan doan, thuoc, ket qua xet nghiem, hinh anh X-quang, tom tat xuất viện
- Cac cong cu AI truy cap du lieu NEHR yeu cau su dong y cu the cua benh nhan va nhat kykiem toan
- Tieu chuan an ninh mang va bao mat du lieu la bat buoc (xem Cap nhât 4)

Ngay hieu luc: Dau nam 2027 (MOH cho cac nha cung cap dich vu y te thoi gian chuan bi)

Tac dong den he thong cua chung toi:

- Trien khai hien tai KHONG su dung du lieu NEHR (chi du lieu noi bo benh vien)

- Khi HIA có hiệu lực, các bệnh viện có thể muốn tích hợp dữ liệu NEHR vào các truy vấn AI
- Điều này yêu cầu: sự đồng ý cụ thể của bệnh nhân, nhất kỳ kiểm toán để có quan đang ký NEHR trung ương, giám thiếu dữ liệu
- Chúng tôi đã lập kế hoạch bỏ nội kết NEHR-Pro cho triển khai Nam 2 (~80.000-150.000 USD kỹ thuật một lần)

Nhưng gì thay đổi so với Q&A trước đó của chúng tôi: Trước đây chúng tôi mô tả đây là "Đu luật HIE (đang chờ)." Bây giờ nó là **luật đã ban hành** (HIA 2026), hiệu lực đầu năm 2027.

Tham khảo:

<https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2026/01/singapore-health-information-bill-passed-in-parliament>

CAP NHAT 3: Huong dan Tu van PDPC ve AI (1 thang 3 nam 2024)

La gi: Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC) công bố Huong dan Tu van về việc sử dụng dữ liệu cá nhân trong các hệ thống khuyến nghị và quyết định AI.

Huong dan chinh:

- Bao gồm 3 giai đoạn: **phat trien** (đào tạo AI), **trien khai** (B2C), **mua sam** (B2B)
- To chức có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho AI khi có sự đồng ý cụ thể, HOAC đưa vào các ngoại lệ PDPA (ví dụ: cải thiện kinh doanh, mục đích nghiên cứu)
- Yêu cầu minh bạch: người dùng nên được thông báo khi dữ liệu cá nhân được sử dụng để đào tạo hệ thống AI
- Lưu ý: Các hướng dẫn này áp dụng cho **AI phân biệt** (hệ thống khuyến nghị/quyết định). Hướng dẫn AI tạo sinh được mong đợi riêng biệt.

Tac dong den he thong cua chung toi:

- Fine-tuning của chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu đã được an danh (không có PHI) - tuân thủ
- Chúng tôi không đào tạo trên dữ liệu bệnh nhân mà không có sự đồng ý rõ ràng - tuân thủ
- Minh bạch: chúng tôi công bố việc sử dụng AI trong mẫu đồng thuận bệnh nhân - tuân thủ
- Mua sam: các bệnh viện mua hệ thống của chúng tôi nên xem xét các hướng dẫn này để tham định nhà cung cấp

Tham khảo: <https://www.pdpc.gov.sg/media-events/advisory-guidelines-on-use-of-personal-data-in-ai-recommendation-and-decision-systems-now-available>

CAP NHAT 4: Yeu cau Thiet yeu ve An ninh mang va Bao mat Du lieu cua MOH (Thang 4 nam 2026)

La gi: MOH công bố Huong dan Yeu cau Thiet yeu về An ninh mạng và Bảo mật Dữ liệu theo khung HIA, được phát triển với sự tư vấn của CSA, IMDA và PDPC.

Ap dung cho: Tất cả các thực thể HIA, bao gồm người được cấp phép HCSA (các bệnh viện khách hàng của chúng tôi) và các nhà đồng gop NEHR.

Ba linh vuc duoc bao gom:

An ninh mạng (CNTT và phân mem):

- Cài đặt cập nhật phân mem kịp thời
- Biện pháp bảo vệ phân cung và phân mem
- Giao thức sao lưu và lưu trữ
- Nhân dạng và bảo vệ tài sản

Bao mat Du lieu (thuc hanh lien quan den du lieu):

- Chính sách nhân dạng và bảo vệ thông tin y tế
- Thời hạn lưu giữ có giới hạn mục đích
- Công bố được ủy quyền theo nguyên tắc cần biết

- Ngăn chặn chuyển giao không đúng cách

Thực hành Chung (to chuc):

- Đào tạo nhân viên
- Trách nhiệm quản lý nhà cung cấp
- Kiểm toán nội bộ và xem xét bảo mật dinh ky
- Xu ly dung cach
- Lập kế hoạch khẩn cấp và ứng phó sự cố

Tác động đến hệ thống của chúng tôi:

- Kiến trúc của chúng tôi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu
- Quản lý nhà cung cấp: các bệnh viện phải danh gia Nova là nhà cung cấp theo các hướng dẫn này
- Chúng tôi cung cấp: tài liệu bảo mật, nhật ký kiểm toán, báo cáo kiểm tra xâm nhập, ISO 27001 (ke thua)
- Ứng phó sự cố: runbooks và báo phụ SRE 24/7 của chúng tôi đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch khẩn cấp

Tham khảo: <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2026/04/singapore-moh-publishes-cybersecurity-and-data-security>

CAP NHAT 5: Nền tảng SHARE của HSA (Thang 7 nam 2025)

La gi: HSA chuyển từ MEDICS sang SHARE (Submission for Harmonized Evaluation and Registration) cho các hồ sơ thiết bị y tế vào tháng 7 năm 2025.

Tác động đến hệ thống của chúng tôi:

- Tất cả các hồ sơ SaMD (Phan mem la Thiet bi Y te) mới phải sử dụng SHARE
- Đăng ký HSA Hàng B của chúng tôi nên được nộp qua SHARE
- Không có thay đổi về tiêu chí phân loại hoặc yêu cầu - chỉ có công thông tin nộp đơn thay đổi

CAP NHAT 6: Singapore Đạt Hàng Cao Nhất của WHO về Quy định Thiết bị Y tế (Thang 3 nam 2026)

Y nghĩa: Singapore trở thành Quốc gia Thành viên WHO đầu tiên đạt được phân loại cao nhất về quy định thiết bị y tế. Điều này bao gồm:

- Khung quy định của Singapore được công nhận quốc tế là hàng đầu thế giới
- Hướng dẫn SaMD của HSA phù hợp với thực hành tốt nhất toàn cầu
- Đề xuất hơn trong việc công nhận lẫn nhau với các quốc gia hàng cao khác (FDA My, EU, TGA Úc)
- Uy tín mạnh mẽ hơn cho các thiết bị y tế được đăng ký tại Singapore trên toàn cầu

Tác động đến hệ thống của chúng tôi:

- Đăng ký HSA Hàng B của chúng tôi có giá trị quốc tế cao hơn
- Đề xuất mở rộng sang các thị trường khác sử dụng đăng ký Singapore làm tham chiếu
- Chúng tôi cam kết của Singapore đối với giám sát thiết bị y tế AI nghiêm ngặt

TOM TAT: Danh sách Kiểm tra Tuần thu (Cập nhật Tháng 5 năm 2026)

Quy định	Trạng thái	Vị trí của chúng tôi
PDPA (2012, sửa đổi 2020)	Hieu luc	Tuan thu: che giâu PHI, KMS, nhật ký kiểm toán, DPO
HCSA 2020	Hieu luc	Tuan thu: bệnh viện triển khai can giây phép HCSA

Quy định	Trang thái	Vị trí của chúng tôi
AIHGle 2.0 (Thang 3 nam 2026)	Hieu luc	Tuan thu: tat ca 7 nguyen tac duoc giai quyet trong kien truc
HIA 2026	Da ban hanh, hieu luc dau 2027	Da lap ke hoach: bo noi ket NEHR cho Nam 2
Huong dan AI PDPC (Thang 3 nam 2024)	Hieu luc	Tuan thu: du lieu dao tao da duoc an danh, minh bach
Yeu cau Thiet yeu An ninh mang MOH (Thang 4 nam 2026)	Hieu luc	Tuan thu: tat ca yeu cau duoc dap ung
HSA SaMD Hang B	Bat buoc	Da lap ke hoach: nop qua nen tang SHARE
Luat An ninh mang 2018 (CII)	Hieu luc cho benh vien CII	Tuan thu: Anti-DDoS, WAF, nhât ky kiem toan, ung pho su co
IMDA AI Verify	Tu nguyen (thuc te bat buoc cho hop dong chinh phu)	Da lap ke hoach: tu danh gia vao Thang 5
ISO 27001 / SOC 2	Hieu luc	Ke thua tu AWS/Alibaba